
**STANDARDELE
SISTEMULUI NAȚIONAL
DE ASISTENȚĂ
MEDICALĂ,
PSIHOLOGICĂ
ȘI SOCIALĂ
A CONSUMATORILOR DE DROGURI**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG
România, 2005**

**Editat de AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG
București, Romania, 2005
ISBN 973-9463-79-7**

Reproducerea totală sau parțială a acestui material este permisă în condițiile legii

Dezvoltarea Standardelor sistemului național de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri a fost realizată de către Agenția Națională Antidrog cu sprijinul susținut al grupului consultativ, în cadrul Proiectului „Întărirea managementului programului național de droguri”, program finanțat de Fondul Global de combatere a HIV/SIDA, TBC și Malariei.

Această lucrare a fost dezvoltată și redactată de:

Dr. Gabriel Cicu

Dr. Dana Podaru

Psih. Ana Maria Moldovan

sub coordonarea

Prof. Dr. Pavel Abraham, Președintele Agenției Naționale Antidrog.

La dezvoltarea Standardelor a participat un număr crescut de profesioniști din domeniu, în cadrul grupului consultativ organizat în acest scop.

Membrii grupului consultativ:

Dr. Teodora Ciolompea – Direcția de sănătate publică București

Dr. Florin Ene – Spitalul clinic de psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia”, București

Psih. Daniela Georgescu – Agenția Națională Antidrog

Dr. Eugen Hriscu – ONG ALIAT

Dr. Cristina Hudiță – Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”, București

Bioing.med. Ruxanda Iliescu – ORDT / Agenția Națională Antidrog

Dr. Luminița Mihai – Spitalul de psihiatrie Constantin Gorgos – Titan, București

Dr. Andrei Radu – Spitalul clinic de psihiatrie Socola, Iași

Psih. Diana Șerban – Agenția Națională Antidrog

Dr. Lucian Vasilescu – Spitalul clinic de psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia”, București

As. soc. Cristina Pădean – Unitatea de Management a Proiectului Fondului Global și Băncii Mondiale

Constantin Manoloiu, Director Direcția evaluare – coordonare din Agenția Națională Antidrog și Rodica Mitoiu din cadrul aceleiași direcții și-au adus aportul tehnic și profesional susținut în dezvoltarea acestui material.

Alături de aceștia, din echipa de lucru a Agenției Naționale Antidrog a mai făcut parte Dorina Dimofte și Bogdan Iașnic care și-au dus contribuția prin sprijinirea derulării întregului proces.

Coordonarea instituțională și implicarea profesională a fost permanent susținută de Directorul general al Agenției Naționale Antidrog, Vasile Popa și Directorul Direcției prevenirea consumului, Lucian Fuică.

Pentru dezvoltarea unei concepții integrate asupra sistemului de asistență a consumatorilor de droguri, buna colaborare cu Ministerul sănătății, concretizată prin sprijinul profesional consecvent al dr. Victoria Jugravu și farm. Georgeta Zănescu, a fost esențială.

Expertiza profesională a prof. dr. Petre Boișteanu, conf. dr. Dan Prelipceanu, dr. Cristian Bellu Bengescu a facilitat stabilirea liniilor profesionale directoare.

Carmela Pavon de Paula, consilier de pre-aderare din partea *Plan Nacional sobre Drogas* din Spania, a sprijinit în mod consecvent acest demers prin facilitarea împărtășirii experienței specialiștilor spanioli. Printre experții spanioli care au participat implicit în conceptulizarea acestui document menționăm pe dr. Jose Salvador Casanova, director programe *Plan Nacional sobre Drogas*, Spania.

UNAIDS a sprijinit tehnic și profesional dezvoltarea acestui document.

La elaborarea acestui material am integrat reglementările în vigoare dezvoltate de ministerele cu atribuții în acest domeniu: Ministerul sănătății, Ministerul muncii, solidarității sociale și familiei, Ministerul educației și cercetării, Ministerul justiției, Ministerul administrației și internelor, Ministerul finanțelor publice precum și al altor autorități publice.

Cuvânt înainte

Așa cum menționam și cu alte ocazii nu se poate afirma că, la ora actuală, traficul și consumul de droguri au depășit stadiul de simplu fenomen, manifestându-se ca unele dintre cele mai grave și îngrijorătoare probleme cu care se confruntă civilizația umană, ci mai degrabă se poate spune că, în prezent, fenomenul drogurilor a depășit nivelul de toleranță rezonabilă față de înțelegerea și standardele actuale ale umanității, numai în consum fiind implicate un număr de persoane de circa 3% din populația globului.

Aceste două elemente ne îndreptățesc să credem că știința este arma cu cea mai mare eficiență în lupta împotriva criminalității în general și a traficului și consumului de droguri în special, numai cunoașterea și înțelegerea, în întreaga sa dimensiune, a pericolului pe care-l reprezintă acest fenomen, fiind de natură să ofere soluțiile adecvate pentru gestionarea de o manieră rezonabilă a acestei boli a secolului XXI.

Este o realitate faptul că de mii de ani drogurile au fost folosite legal sau ilegal, de la o etapă la alta a evoluției societății, însă dincolo de acceptarea sau de respingerea drogurilor de către societate, efectele negative ale acestora asupra stării individului și asupra relațiilor lui sociale au devenit incontestabile. Acest adevăr a determinat fără îndoială un transfer al mentalităților prin deplasarea accentului pe tratarea „bolii individului”, prin tratament, asistență, consiliere și reintegrare socială și numai în subsidiar pe tratarea „bolii societății, prin pedeapsă, prin izolarea din comunitate a celor care au încălcat ordinea de drept.

Un exemplu, poate nu cel mai elocvent, în acest sens l-ar putea constitui campania promovată anul trecut de Organizația Națiunilor Unite – *Drogurile: tratamentul funcționează* la lansarea căreia directorul executiv al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, domnul Antonio Maria Costa afirma că: *Este o idee falsă că, cel care devine toxicoman, rămâne toxicoman toată viața. Această idee, ca și oprobiul public asociat abuzului de droguri și dependenței, împiedică societatea să anticipeze răspunsul potrivit nevoilor toxicomanilor și să îi trateze. În realitate tratamentul toxicomaniei este eficient și poate avea un enorm impact asupra indivizilor, familiilor acestora și societății în ansamblu.*

Față de această stare de fapt existentă la nivel mondial, este arhicunoscută adaptarea societății românești, prin construcția instituțională și legislativă de natură a permite abordarea consumului de droguri din perspectiva necesității furnizării unui tratament medical adecvat, a unui asistențe psihologice și sociale de calitate de o manieră integrată, finalizată prin reinsertia socială.

Așa cum era și firesc, față de aceste elemente de absolută noutate pentru societatea românească, următorul pas l-a constituit elaborarea sistemului de oferire a asistenței bazate pe ultimele evidențe științifice și care înlocuiește vechiul sistem, longitudinal, de tipul cură de dezintoxicare și

postcură, devenit anacronic și insuficient, față de abordările actuale a nevoilor consumatorilor de droguri.

De asemenea, în acest context al asistenței consumatorilor de droguri, a devenit necesară definirea structurii sistemului de asistență, începând de la resurse, servicii, centre etc., precum și a modalității de oferire a asistenței: integrată, adecvată problemelor depistate în urma evaluărilor, multidisciplinară (echipă terapeutică), concomitentă și/sau consecutivă.

Totodată, prin utilizarea unor instrumente cum ar fi: identificarea multidimensională a riscurilor și nevoilor individuale prin intermediul evaluării multiple, aplicarea criteriilor de orientare, dezvoltarea abordării integrate în cadrul celor patru programe integrate de asistență, individualizarea abordării prin stabilirea de comun acord cu consumatorul a unui plan individualizat de asistență, asigurarea concomitenței, continuității și adecvării continue a asistenței oferite de managerul de caz se facilitează întâmpinarea și răspunsul la multiplele nevoi ale consumatorului de droguri.

Mai mult, pentru atingerea scopurilor propuse era absolut necesară elaborarea unui cadru național pentru acordarea serviciilor de asistență medicală, psihologică și socială adresate consumatorilor de droguri, în limitele căruia factorii de decizie, de coordonare, dar și specialiștii să dezvolte sisteme eficiente și eficace de asistență.

Răspunsul la toate aceste cerințe îl constituie lucrarea de față, rodul colaborării unui grup de specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Educației și Cercetării, UNAIDS, societatea civilă și, mai ales, a profesioniștilor cu experiență în asistența consumatorilor de droguri, care și-au unit eforturile animați de cea mai înaltă expresia a solidarității umane, grija pentru semenul lor.

Nu în ultimul rând, aș dori să precizez faptul că Standardele sistemului național de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri vor fi supuse aprobării Guvernului României sub forma regulamentului de aplicare a Legii nr.522/2004 de modificare și completare a Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a celorlalte acte normative secundare ce derivă din acesta, și prin aceasta puterea legii acționând în beneficiul individului și al societății.

Prof. Univ. Dr. Pavel ABRAHAM

PREȘEDINTELE AGENTIEI NAȚIONALE ANTIDROG

CUPRINS

INTRODUCERE	8
Cap.I: SISTEMUL INTEGRAT DE ASISTENȚĂ A CONSUMULUI DE DROGURI	13
Cap.II: EVALUAREA ÎN PRETRATAMENT A CONSUMATORILOR DE DROGURI	31
Cap. III: CRITERII DE ORIENTARE A PACIENTULUI	43
Cap.IV: PROGRAME INTEGRATE DE ASISTENȚĂ (PIT)	64
Cap.V: PLAN INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ (PIA)	72
Cap.VI: MANAGEMENT DE CAZ	91
Cap.VII: REINSERTIA SOCIALĂ A CONSUMATORILOR DE DROGURI	121
<i>Anexa 1:</i> Raport evaluare	126
<i>Anexa 2:</i> Evaluarea de proces și înainte de ieșire	129
<i>Anexa 3:</i> Acord de asistență medicală, psihologică și socială	135
<i>Anexa 4:</i> Plan individualizat de tratament	136
<i>Anexa 5:</i> Acord de ieșire la cerere împotriva recomandării profesionistului	137
<i>Anexa 6:</i> Criterii de orientare	138
<i>Anexa 7:</i> Foaie individuală de urgență pentru consumul de droguri	146
<i>Anexa 8:</i> Foaie individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri	148
<i>Anexa 9:</i> Cazuri înregistrate de HVC/HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile	152
<i>Anexa 10:</i> Prevalența infecțiilor cu HIV, HVB/HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile	153
<i>Anexa 11:</i> Fișa de înregistrare individuală a decesului ca urmare a reacției acute la substanțe psihoactive (deces RASP)	155
Glosar de termeni	157
Referințe	159

INTRODUCERE

Consumul și traficul de droguri constituie un element de preocupare pentru toate țările lumii. Dată fiind complexitatea, caracterul multidimensional și caracteristicile de dinamism și schimbare, dificultățile în abordarea terapeutică, structurată și eficientă sunt evidente. În mod particular, este important să se acorde prioritate în oferirea unei asistențe comprehensive problemelor asociate consumului, dependenței și altor consecințe.

O astfel de abordare a asistenței reprezintă o componentă strategică a politicilor de reducere a cererii, prin definirea sistemului de intervenții planificate și monitorizate în scopul atingerii eficienței maxime, în timpul programat, cu resursele minime posibile și în modul cel mai puțin restrictiv pentru pacient.

Scop: dezvoltarea unui model pentru organizarea serviciilor de asistență a dependenței de droguri, astfel încât acestea să răspundă în mare măsură nevoilor beneficiarilor, să permită abordări structurate și sistematice, care pot fi evaluate pe baza unor parametri obiectivi, care ulterior să permită implementarea unor standarde minime de calitate și bune practici.

Rațiunea introducerii standardelor

În perioada 2004-2005 Agenția Națională Antidrog a inițiat proiectul de modificare a Legii 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în scopul reconsiderării poziției față de consumatorul de droguri, în sensul asigurării pentru acesta a unei asistențe medicale, psihologice și sociale, finalizat prin adoptarea Legii nr. 522/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000.

Prin noul act normativ s-a creat posibilitatea includerii consumatorului de droguri, cu acordul său, într-un program integrat de asistență care cuprinde servicii de natură medicală, psihologică și socială. Această posibilitate este consacrată de lege și în cazul consumatorilor care au săvârșit infracțiuni legate de consum, legea instituind, în acest sens, obligativitatea evaluării învinutului/inculpatului în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri. Pentru atingerea finalității urmărite prin introducerea noilor prevederi legale, este necesar ca serviciile de asistență pentru consumatori să se aplice în mod integrat, sens în care a fost constituit circuitul terapeutic.

Astfel, devine necesară dezvoltarea cadrului organizatoric și instituțional de desfășurare integrată a serviciilor de asistență a consumatorilor de droguri.

În acest sens, Agenția Națională Antidrog, a dezvoltat, în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC și Malariei, Standardele sistemului național de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri.

Acestea vor fi aprobate prin Hotărârea Guvernului sub forma regulamentului de aplicare a Legii 522/2004, precum și a celorlalte acte normative secundare care derivă din acesta.

Standardele reflectă în mod pregnant consensul profesional în ceea ce privește modul cel mai adecvat de acordare a asistenței, fiind rezultatul unui proces consultativ extensiv de lungă durată, utilizat în dezvoltarea acestui document. Cadrul consultativ a fost inițiat în anul 2003 și a devenit o permanență a modului de lucru în stabilirea liniilor directoare în dezvoltarea unei structuri organizatorice operaționale, dar și a instituirii abordării profesionale, integrate, comprehensive a problematicii consumului de droguri în România. Activitățile consultative s-au desfășurat prin organizarea unui grup de lucru, la inițiativa Agenției Naționale Antidrog și prin colaborarea cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii Solidarității Sociale și familiei, Ministerului Educației și Cercetării, UNAIDS, societatea civilă. Un rol deosebit de important l-a avut implicarea profesioniștilor cu experiență în asistența consumatorilor de droguri. Fiecare din aceste părți și-au adus aportul, în funcție de mandatul și expertiza profesională și instituțională a fiecăruia. Diferitele perspective exprimate în cadrul acestui demers și-au adus un aport fundamental în conceptualizarea abordării integrate, complementare și comprehensive a răspunsului la fenomenul consumului de droguri, concretizate prin actele legislative menționate mai sus și prin definirea documentului actual.

Acest document reglementează cadrul național pentru acordarea serviciilor de asistență medicală, psihologică și socială adresate consumatorilor de droguri și care se așteaptă a fi implementate în toate regiunile țării, pentru a veni în întâmpinarea necesităților specifice fiecărei populații locale. Pe baza acestora se vor dezvolta atât programele naționale, cât și cele locale.

Ce sunt standardele?

Standardele oferă cadrul general pentru obținerea consistenței, echității, continuității ofertei de asistență adresate consumatorilor de droguri. Acestea sprijină factorii de decizie, de coordonare, dar și specialiștii în dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de asistență a consumatorilor. Prin intermediul acestora se oferă direcțiile necesare de sprijinire a coordonării asistenței consumatorilor și managementul general al fiecărui caz de-a lungul diferitelor servicii oferite pe niveluri de asistență.

Totodată, conform celor mai recente date în domeniu, standardele promovează abordarea care permite întâmpinarea și răspunsul la multiplele nevoi ale consumatorilor de droguri. Acesta se obține prin utilizarea unor instrumente cum ar fi identificarea multidimensională a riscurilor și nevoilor

individuale prin intermediul evaluării pe cele cinci arii, aplicarea criteriilor de orientare, dezvoltarea abordării integrate prin intermediul celor patru programe integrate de asistență (PIT), individualizarea abordării prin stabilirea de comun acord cu pacientul a unui plan individualizat de asistență (PIA), asigurarea concomitenței, continuității și adecvării continue a asistenței oferite prin intermediul managementului de caz. De asemenea, creșterea accesului și facilitarea răspunsului integrat se obține prin recomandările referitoare la diversificarea serviciilor și importanța acordată serviciilor de asistență de tip comunitar, dar și prin promovarea continuă a măsurilor de reabilitare și reinserție socială.

Un alt fapt important este dezvoltarea rețelei de coordonare locală, ceea ce maximalizează rezultatele obținute în tratamentul și asistența consumatorilor de droguri, prin stabilirea unor legături specifice cu serviciile medicale primare și de specialitate, serviciile sociale și sistemul de justiție. Acest fapt devine posibil prin introducerea serviciilor de evaluare și management de caz, la nivelul CEPCA, cu rol de coordonare, monitorizare și planificare la nivel local a asistenței consumatorilor de droguri.

Dezvoltarea standardelor se bazează pe cele mai noi evidențe, privind calitatea și bunele practici în domeniul tratamentului și asistenței consumatorilor de droguri. Au fost luate în considerare atât documentele și materialele științifice publicate în țară, rezultatele cercetărilor naționale și internaționale, modelele de asistență dezvoltate de țări cu experiență și rezultate promițătoare în tratamentul consumatorilor de droguri, cum ar fi SUA, Marea Britanie, Irlanda sau Spania. Considerăm că, deși experiența acestor țări este covârșitoare, comparativ cu noutatea, încă, a fenomenului consumului de droguri în România, aplicarea liniilor directe definite în documentul de față, ca și dezvoltarea în intervalul imediat următor a standardelor de calitate ale sistemului de asistență a consumatorilor de droguri, reprezintă un pas semnificativ în actualizarea și uniformizarea răspunsului terapeutic românesc la cel internațional.

Cui se adresează?

Acest document se adresează factorilor de decizie și executivi, coordonatorilor și implementatorilor de programe și servicii de asistență, cât și profesioniștilor a căror activitate se desfășoară în acest domeniu. Necesitatea standardizării intervențiilor rezidă clar din caracterul complex al fenomenului consumului de droguri, care implică abordarea multidisciplinară, plurifactorială, integrată și comprehensivă. Pe lângă această realitate, confirmată prin evidențe științifice și reglementată de legislația în vigoare, necesitatea dezvoltării unei abordări eficiente în relația cost-eficiență este un obiectiv de bază al politicilor în asistența consumatorilor de droguri.

Ce nu acoperă standardele?

Alcoolul

În etapa inițială, de concepție a standardelor ne-am focalizat asupra tratamentului consumatorilor de droguri. În parte standardele, așa cum sunt dezvoltate în prezent au relevanță și asupra modalităților de asistență a consumatorilor de alcool, dar nu oferă linii directoare specifice, atât în ceea ce privește serviciile, cât și funcționarea integrată. Totuși, este important ca în acordarea asistenței consumatorilor de alcool să se țină cont de orientarea pacienților conform evaluării și criteriilor prezentate în standardele actuale. Totuși, în viitor este important să ne asigurăm de dezvoltarea unor standarde pentru asistența consumatorilor de droguri și alcool sau, global, consumatorilor de substanțe de abuz.

Substanțe administrate cu prescripție

Standardele actuale nu oferă considerații detaliate privind consumul de substanțe administrate cu prescripție medicală, în special benzodiazepine, steroizi, dar și a substanțelor volatile (solvenți). Oricum, în orice evaluare se urmărește problema policonsumului, situație în care se depistează și adresează și problemele generate de consumul substanțelor administrate cu prescripție medicală.

Tinerii sub 18 ani

Standardele descriu în general modalitatea de acordare a serviciilor adresată pacienților adulți, peste 18 ani. Modalitatea de acordare a serviciilor pentru tinerii sub 18 ani trebuie să asigure conexiunile necesare cu reglementările și standardele de asistență adresate minorilor. De asemenea, o altă provocare o reprezintă modalitatea de trecere de la serviciile adresate minorilor la cele ale adulților, cu ocazia schimbării statutului social și juridic.

Tratamentul și asistența în condiții de detenție

Standardele nu fac referiri specifice la asistența consumatorilor de droguri aflați în penitenciare. Regulamentul de aplicare a Legii 522/2004 face referire la alternativa la detenție și la posibilitatea consumatorului, în condițiile acordului său, de a beneficia de asistență medicală, psihologică și socială, în etapele și modalitățile general reglementate. În ceea ce privește consumatorii aflați în detenție, este de așteptat ca aceștia să beneficieze, în mod echitabil de servicii eficiente și de calitate, bazate pe o evaluare multidimensională și planificare, în care rolul comunității să reprezinte un aport semnificativ.

Principiile standardelor

1. Întreaga varietate a serviciilor trebuie să fie disponibilă în toate regiunile țării. Nu toți consumatorii de droguri vor avea nevoie de acces la toate serviciile, sau la toate programele integrate de asistență, dar în fiecare zonă va fi necesar accesul la fiecare serviciu la un anumit moment în timp.

2. Modalitățile de asistență nu sunt alternative, acestea trebuie să fie disponibile la nivel local. Modalitățile de asistență sunt complementare. Fiecare este necesară pentru construirea unui sistem comprehensiv de asistență.
3. Serviciile de asistență nu sunt specifice în mod necesar diferitelor modalități de asistență.
4. Consumatorii de droguri vor necesita acces la servicii, constituite în diferite modalități de asistență și niveluri de asistență. Managerul de caz trebuie să se asigure asupra posibilității oferirii complementarității asistenței în funcție de necesitățile acestora.
5. Decidenții/managerii de caz vor trebuie să asigure posibilitatea adaptării la tendințele fenomenului consumului de droguri (ex. creșterea consumului de stimulente, sau apariția consumului la alte grupuri populaționale).
6. Funcționarea sistemului integrat de asistență trebuie privită strategic. Aceasta înseamnă că din punct de vedere al standardizării asistența nu trebuie privită ca un lanț de servicii și funcții, ci constă în implementarea și funcționarea programelor integrate de asistență.
7. Managerii de caz trebuie să se asigure că în regiunea, județul în care își desfășoară activitatea nu sunt grupuri cu acces mai redus la asistență, indiferent de zonă, etnie, sex sau tipul de drog consumat (datorită locației, criteriilor de orientare, procedurilor de evaluare, timpului de așteptare).
8. Managerii de caz ca și furnizorii de servicii trebuie să fie conștienți că munca de creștere a motivației poate să fie crucială în angajarea pacienților și progresele făcute de aceștia în tratament. Lipsa motivației nu trebuie să fie un criteriu de excludere a pacienților, din contră fiecare furnizor de servicii trebuie să acționeze în sensul creșterii acesteia.
9. Managerii de caz trebuie să se asigure că, atât accesul, cât și asistența structurată sunt disponibile. Modalitățile mai puțin structurate tind să fie mai accesibile și să funcționeze ca puncte de plecare către modalități de asistență mai intensive. Unele cazuri necesită o asistență de intensitate mai mare; de asemenea de multe ori se trece de la o structură de intensitate mai mare, către una de intensitate mai redusă în scopul obținerii eficienței așteptate.
10. Gradul de pregătire al personalului, ca și gradul de utilizare a serviciilor nu sunt în mod necesar în relație directă cu intensitatea modalității de asistență.

I. SISTEMUL INTEGRAT DE ASISTENȚĂ A CONSUMATORILOR DE DROGURI

INTRODUCERE

Natura tulburărilor determinate de consumul și dependența de substanțe implică o serie de aspecte specifice și care trebuie considerate în orientarea politicilor adresate asistenței acestei categorii de pacienți. Enumerarea principalelor aspecte specifice include:

- caracterul unic în cadrul tulburărilor medicale;
- disfuncții ale controlului comportamental și ale autoconservării;
- consumul întărește în mod direct comportamentul care exacerbează tulburarea;
- o abordare mai solicitantă pentru sistemul de asistență comparativ cu afecțiunile cronice sau alte tulburări cognitive sau comportamentale;
- subminează consistența intervențiilor de advocacy.

Din aceste motive, tratamentul și asistența dependenței de droguri trebuie considerat ca un continuum de servicii, începând un continuum de servicii, începând de la servicii de minima complexitate, adresate cazurilor în care complicațiile generate de uzul de droguri sunt minime, până la cazuri de mare complexitate.

PRINCIPII

- **Nici un tratament nu este valabil pentru toți pacienții.** Adecvarea intervențiilor, a modalității de desfășurare a acestora și a serviciilor la problemele și nevoile particulare ale fiecărui individ este esențială pentru succesul final de revenire la o funcționare productivă în familie, la locul de muncă și în societate.
- **Nevoile de tratament trebuie să fie rapid disponibile.** Datorită faptului că indivizii dependenți pot fi nesiguri în legătură cu intrarea într-un program de tratament, este esențială utilizarea momentului când aceștia sunt gata să înceapă. Aplicații potențiali pentru tratament pot fi „pierduți” dacă tratamentul nu este disponibil imediat și nu este accesibil.
- **Tratamentul eficient se adresează necesităților multiple ale individului, nu doar consumului de droguri.** Pentru a fi eficient, tratamentul trebuie să se adreseze consumului de droguri al individului și oricăror probleme asociate, de natură medicală, psihologică, socială, vocațională și juridică.

- **Un plan de tratament și servicii trebuie evaluat continuu și modificat, atunci când este necesar, pentru asigurarea faptului că planul răspunde nevoilor individuale de schimbare.** Un pacient poate necesita diverse combinații de servicii și componente terapeutice în timpul tratamentului și recuperării. În completare la consilierea psihologică și psihoterapie, un pacient poate necesita medicație în anumite etape, sau alte servicii medicale, terapie familială, consilierea și îndrumarea părinților, reabilitare vocațională și servicii sociale sau juridice. Este esențial ca abordarea de tratament să fie adecvată vârstei, sexului, etniei, culturii individuale.
- **Rămânerea în tratament pentru o perioadă adecvată de timp este esențială pentru eficiența tratamentului.** Durata adecvată de timp pentru un individ depinde de problemele și nevoile individuale. Cercetările arată că pentru majoritatea pacienților o îmbunătățire semnificativă apare după aproximativ 3 luni de tratament. După ce se atinge acest prag, intervențiile suplimentare pot produce, în continuare, progrese către vindecare. Datorită faptului că de obicei indivizii părăsesc prematur tratamentul, programele trebuie să includă strategii de angajare și menținere a pacienților în tratament.
- **Consilierea (individuală sau de grup) și alte terapii comportamentale sunt componente esențiale ale tratamentului eficient pentru adicții.** În terapie, pacienții lucrează asupra unor teme legate de motivație, dezvoltarea abilităților de a rezista consumului de droguri, înlocuirea activităților legate de droguri cu activități constructive și plăcute, fără drog și îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. Terapia comportamentală facilitează, de asemenea, dezvoltarea relațiilor interpersonale și capacitatea indivizilor de a funcționa în familie și societate.
- **Medicația este un element important al tratamentului pentru mulți pacienți, mai ales atunci când este combinată cu consilierea psihologică și psihoterapia comportamentală.** Metadona sau altă medicație substitutivă sunt foarte eficiente în sprijinirea indivizilor dependenți de heroină sau alte opiacee, permițând stabilizarea vieții acestora și reducerea utilizării drogurilor ilicite. Pentru pacienții cu probleme psihice atât terapia comportamentală, cât și tratamentul medicamentos sunt de importanță esențială.
- **Indivizii cu dependență și afecțiuni mintale coexistente trebuie tratați într-o modalitate integrată.** Deoarece afecțiunile mintale și tulburările adictive coexistă adesea la unii indivizi, pacienții care se adresează pentru oricare din cele două condiții trebuie evaluați și tratați pentru ambele afecțiuni.
- **Dezintoxicarea fizică este doar o primă etapă în tratamentul adicțiilor și, în absența altor abordări, oferă puțin pentru schimbarea pe termen lung a comportamentului de consum.** Dezintoxicarea fizică asistă în siguranța managementul simptomelor acute fizice asociate cu întreruperea consumului de droguri. Chiar dacă dezintoxicarea este rareori suficientă pentru sprijinirea menținerii abstenenței pe termen

lung a persoanelor dependente, totuși pentru anumiți indivizi este un precursor foarte indicat pentru tratamentul eficient al adicției.

- **Tratamentul nu trebuie să fie voluntar pentru a fi eficient.** Motivația puternică poate facilita progresul tratamentului. Sancțiunile sau pedepsele aplicate în familie, la locul de muncă sau prin justiție pot duce la creșterea semnificativă atât a cererii de intrare în tratament, cât și a ratei de menținere și în consecință, a ratei de succes a tratamentului.
- **Posibilitatea de reluare a consumului de droguri în timpul tratamentului trebuie monitorizată continuu.** Posibilitatea de reluare a consumului de droguri poate apărea pe parcursul tratamentului. Monitorizarea obiectivă a pacienților pe parcursul tratamentului, prin discuții, teste urinare sau alte teste, poate ajuta pacienții să-și controleze nevoia de a consuma droguri. O astfel de monitorizare poate evidenția timpuriu reluarea consumului și astfel planul de tratament poate fi ajustat. Feedback-ul adresat pacienților care au consumat un drog ilicit este un element important de monitorizare.
- **Programele de tratament trebuie să asigure evaluarea pentru HIV/SIDA, hepatita B și C, tuberculoza și alte boli infecțioase, ca și consilierea pentru sprijinirea pacienților în schimbările comportamentelor cu risc pentru ei înșiși sau pentru alții.** Consilierea poate ajuta indivizii în evitarea comportamentelor cu risc. De asemenea poate sprijini pacienții infectați în managementul bolii.
- **Recuperarea după o adicție este un proces pe termen lung și necesită frecvent multiple tranșe de tratament.** Ca și în cazul altor boli cronice, recăderile pot apărea în cursul sau după o etapă de asistență eficientă. Persoanele cu adicție pot necesita tratament prelungit sau mai multe tranșe de tratament pentru menținerea abstinentei și recuperarea totală a funcționării individuale. În menținerea abstinentei, adeseori este utilă participarea la grupuri de auto-suport.

(Principles of Drug Addiction Treatment, NIDA)

OBIECTIVELE ASISTENȚEI CONSUMATORILOR

Conform Asociației Americane de Psihiatrie asistența tulburărilor rezultate în urma consumului de droguri sau alte substanțe are trei scopuri:

1. Pacientul întrerupe sau reduce consumul de droguri și efectele acestuia
2. Pacientul reduce frecvența și severitatea recăderilor
3. Pacientul dezvoltă abilități psihologice și emoționale necesare recuperării și menținerii funcțiilor sale personale, ocupaționale și sociale.

Astfel, **în primul rând**, tratamentul dependenței de droguri trebuie considerat ca un continuum de servicii, pornind de la servicii de minimă complexitate, până la necesitatea folosirii tehnologiei avansate, a unei echipe

profesionale cu grad înalt de specializare, adresate acolo unde consumul de droguri și dependența sunt atât de severe încât rezultatele pozitive pot fi așteptate numai prin implicarea acestui tip de resurse. Continuumul asistenței se referă nu numai la acoperirea tuturor fazelor tulburării adictive, dar și la disponibilitatea unui spectru larg al opțiunilor terapeutice aplicate în concordanță cu nevoile individuale sau nevoile specifice unui grup de populație, în scopul obținerii celor mai bune rezultate.

În al doilea rând asistența este definită ca un cadru de referință constând în dezvoltarea unor criterii aplicabile în planificare în arii cheie cum ar fi evaluarea prealabilă a pacientului, selecția opțiunilor terapeutice, includerea, trimiterea, ieșirea, concomitența, durata; dar și în evaluarea procesului de asistență și a rezultatelor.

În al treilea rând, cadrului de referință dezvoltat i se va asocia într-un viitor apropiat, un set de recomandări practice, sub forma unui ghid al managementului clinic.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ

Aspecte generale

Organizarea sistemului de asistență reprezintă o combinație de intervenții terapeutice, sub forma unui continuum, acoperind tot spectrul de servicii (centre, programe, tipuri de asistență disponibile pentru consumatorul de droguri în concordanță cu nevoile acestuia și într-o perioadă de timp dată; ca și totalitatea serviciilor oferite subsecvent pe parcursul evoluției tulburării, ca parte a procesului de recuperare a tulburării datorate consumului.

Fiecare componentă este considerată extrem de importantă pentru integralitatea și operaționalitatea sistemului de asistență, cu toate că acestea nu au o importanță/valoare terapeutică similară și rareori se regăsesc în totalitate, în timp sau într-un anumit loc.

Sistemul de asistență include câteva componente sau arii de intervenție, aflate în legătură cu stadiile distincte ale adicției, cum ar fi cazul urgențelor sau necesității asistenței imediate, tratamentul și asistența dependenței în sine sau reintegrarea socială. În toate cazurile, intervențiile terapeutice se desfășoară într-un anumit centru, integrat operațional cu centrele/unitățile în care se desfășoară intervenții generale, de specialitate și specifice, posibil și cu serviciile sociale sau comunitare.

Caracterizarea sistemului ca un continuum de asistență se referă la abordarea complementară sau/și la dimensiunile (paleta) de servicii oferite: abordarea longitudinală și abordarea încrucișată.

În cadrul abordării longitudinale ce implică secvențialitatea intervențiilor terapeutice – într-o modalitate istorică/cronologică în mare măsură – procesul de recuperare al consumatorilor de droguri este divizat în secvențe distincte. Măsurile luate în cadrul fiecărei secvențe pot fi asigurate în centre de asistență diferite, dar necesită o secvențialitate logică, ce abilitază pacientul să facă progrese stabile către recuperare și reabilitare, bazate pe diferite perspective ținând cont de programarea intervențiilor și pornind de la prevenire, până la managementul recăderilor și reintegrarea socială.

Abordarea încrucișată se referă la coordonarea diferitelor servicii și intervenții necesare și disponibile pe câte un nivel. Aceste opțiuni pot lua forma unui set de intervenții complementare, simultane sau pe termen scurt, care reflectă diversitatea necesară adecvării la diferitele fațete și nevoi asociate tulburărilor datorate consumului de droguri.

Asistența integrată sistematică se bazează pe intersectarea celor două abordări. Astfel, pacienții pot fi orientați către o singură instituție, într-o modalitate de abordare centralizată sau, cel mai adesea, asistența este coordonată între diferite centre, instituții, prin intermediul trimiterilor și în scopul acoperirii mai multor nevoi de asistență și al continuității.

Abordarea integrată, ca modalitate opusă celei tradiționale, câștigă din ce în ce mai mult credit în asistența consumatorilor de droguri.

Ca parte a abordării integrate, programele de asistență și serviciile de asistență nu sunt integrate numai între ele, dar și cu rețeaua generală de servicii de asistență, primară și de specialitate. Serviciile comunitare joacă, în acest context, un rol cheie.

În cadrul unui sistem sau rețea de asistență este important să definim elementele structurale sau componentele de bază, relația funcțională dintre acestea și diferitele procese aplicate în cadrul asistenței. De exemplu, într-o clinică se pot desfășura mai multe servicii și programe, care se pot desfășura simultan sau paralel, chiar dacă acestea corespund unor componente de bază diferite, cum ar fi cazul programelor ambulatorii de prevenirea recăderilor, terapiei de grup, ambele putându-se derula în cadrul aceluiași centru, cu aceeași echipă terapeutică.

Diferitele componente ale asistenței, acționând în coordonare cu rețeaua generală de tratament, se constituie în sistemul de asistență adresat consumatorilor de droguri. Intervențiile terapeutice coordonate simultan sau secvențial se constituie în procesul terapeutic.

Adecvarea asistenței oferite la nevoile pacienților

Deși criteriile orientează activitatea de adecvare a planului terapeutic conform programelor integrate de asistență stabilite, nevoile pacienților primează iar cunoașterea acestora prin intermediu evaluării desemnează integrarea într-o modalitate de asistență predefinită. Dacă s-ar lua în

considerare în primul rând gruparea pacienților după nivelul de asistență, această ipostază ar conduce la formarea unor grupuri heterogene de pacienți cu o serie de necesități individuale. Apare a fi mai avantajoasă orientarea pacienților în funcție de programele definite pentru a răspunde cât mai adecvat necesităților pacienților decât adaptarea la solicitările nivelurilor de asistență. Potrivirea ofertei de servicii la nevoile pacienților este utilă din punct de vedere clinic, fie că este realizată formal în cadrul unei structuri de cercetare, fie că este realizată informal în clinică. Aceasta implică:

- 1) considerarea necesităților pacientului pe mai multe arii de evaluare
- 2) oferirea de servicii pentru a răspunde acestor necesități.

McLellan și alții (1993) au arătat că potrivirea serviciilor clinice conform necesităților pacientului produce, în general, cele mai bune rezultate în aria problematică respectivă (de exemplu, psihiatric sau familial/social).

Pe lângă severitatea în sine a consumului de substanțe, câteva alte arii de severitate au fost identificate ca având un efect în prognoza și necesitatea de tratament (Gerstein și Harwood 1990; Institute of Medicine 1990). McLellan și alții (1983) utilizând Indexul de Severitate al Adicțiilor (ASI; McLellan și alții 1985, 1982) a arătat că subiecții dependenți de alcool și droguri cărora le erau adecvate serviciile adresate unor arii care arătau severitate crescută, au avut rezultate care erau cu 27% mai bune decât rezultatele subiecților care nu erau potriviți, cu economii în medie de 3,700\$ în costurile tratamentului per pacient. Ulterior, s-a efectuat un studiu prospectiv, în care 130 de pacienți dependenți de alcool și 256 de pacienți dependenți de droguri au beneficiat în mod aleator, fie de tratament adecvat necesităților, fie de tratament convențional, fără adecvarea la necesitățile acestora, în cadrul a două structuri cu regim închis și două structuri ambulatorii făcând parte din programe publice și din sectorul privat (McLellan și alții, 1983). Pacienții cărora li s-a oferit asistență adecvată au primit mai multe servicii adresate familiei, angajării în muncă și de psihiatrie, în funcție de necesități, având ca rezultat o retenție mai mare în tratament dar rezultatele pe 6 luni erau cu 19% mai bune decât cele ale pacienților care au primit doar consiliere pentru consumul abuziv de droguri. Rezultate similare au fost raportate într-un studiu la pacienții care primesc metadonă (McLellan și alții, 1993). Tratamentul multidimensional a generat rezultate substanțial mai bune decât tratamentul de bază cu metadonă și consilierea separat.

Aceste rezultate sunt asemănătoare cu rezultatele anterioare obținute de Joe și alții (1991), care au studiat programele publice de tratament pentru dependența de droguri; de Moos și Finney (1995) care au studiat programele rezidențiale de tratament pentru dependența de alcool; și de Ball și Rodd (1991) care au studiat programele de menținere pe metadonă. Aceste studii indică faptul că adecvarea la nevoile pacienților are validitate predictivă.

Dar deși adecvarea asistenței la nevoile pacienților este un punct de plecare logic și demonstrat pentru un nou model de planificare a asistenței, este în

continuare necesar să se ia în considerare structura în care, sau nivelul de asistență la care serviciile pot fi cel mai bine oferite. O abordare foarte flexibilă, individualizată de desemnare pe program integrat de asistență pare esențială pentru calitatea clinică și eficiența costurilor. Gastfriend (1994) a propus Modelul *Cumulative Block Increment (CBI)*. Bazat pe conceptul unităților mici de servicii ca unități de bază (de exemplu, unități de asistență cu program pe ore), această abordare a recomandat o evaluare amănunțită a necesităților individului, urmată de o grupare a acestor necesități pentru a determina cea mai bună structură organizatorică pentru multitudinea de servicii necesare. Acest model va integra considerațiile cu privire la nivelurile de asistență cu adecvarea serviciilor la nevoile pacienților. Deși modelul *CBI* pare a oferi validitate la fel ca și celelalte modele de criterii pentru plasarea pacientului, și acesta așteaptă validarea empirică.

Furnizori de servicii medicale, psihologice și sociale, pot răspunde problemelor pacienților cu consum de substanțe cu ajutorul criteriilor de orientare a pacientului.

Componentele/resursele și obiectivele acestora în cadrul sistemului integrat de asistență

A. Niveluri de asistență

Nivelurile de asistență reprezintă cadrul instituțional sau programatic în interiorul căruia au loc intervențiile terapeutice. Complexitatea sau modul de operare al unui centru poate să corespundă unui singur nivel; altele pot include componente integrate corespunzând mai multor niveluri. Un nivel de asistență reprezintă o combinație de elemente structurale sau tipuri de centre care oferă sau coordonează servicii ca răspuns la nevoile identificate și care, va determina complexitatea serviciilor necesare unei asistențe adecvate a consumatorilor de droguri. În acest moment un continuum dezirabil de asistență se află doar în stadiul de planificare.

Teoretic, de la un anumit nivel de asistență se pot aștepta rezultate mai bune în ceea ce privește economia costurilor decât de la altele. Totuși, studiile cu privire la rezultate nu au arătat convingător că reabilitarea sau dezintoxicarea în regim închis sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor decât reabilitarea sau dezintoxicarea în ambulator (Annis, 1988; Hayashida și alții, 1989; Litt și alții, 1989; Miller și Hester 1986). De fapt, încercarea de a demonstra că structurile de tratament mai intensive oferă pacienților rezultate mai bune decât cele mai puțin intensive a fost un eșec consecvent. Organizațiile de management al sănătății au utilizat acesta modalitate pentru a justifica eliminarea nivelurilor mai înalte de asistență cum ar fi dezintoxicarea intraspitalicească sau reabilitarea rezidențială. Un punct critic, totuși, este că aceste studii nu încearcă să determine care sunt pacienții care au avut cele mai bune rezultate și de la ce nivel de asistență sunt obținute acestea.

Nivelurile de asistență au fost delimitate în funcție de gradul până la care erau oferite managementul medical, structura, securitatea și intensitatea tratamentului.

Sistemul de asistență medicală, psihologică și socială, este structurat pe trei niveluri de intervenție, incluzând sistemul de asistență medicală ambulatorie (primară și de specialitate) și spitalicească, serviciile psihologice și serviciile sociale. Sistemul include componente publice, private sau mixte acreditate/autorizate și este coordonat și monitorizat de către Agenția Națională Antidrog pe baza standardelor de calitate și în conformitate cu legislația în vigoare.

Nivelul 1

Primul nivel al sistemului presupune identificarea, atragerea, motivarea și trimiterea consumatorilor de droguri spre serviciile specializate, abordarea necesităților sociale și medicale de bază ale consumatorilor de droguri și coordonarea necesară cu resursele din nivelul 2 și 3.

Obiective:

- Minimalizarea riscurilor asociate consumului de droguri, prin oferirea de material steril (seringi, dezinfectanți și apă distilată).
- Oferirea de prezervative pentru prevenirea apariției infecțiilor cu transmitere pe cale sexuală.
- Oferirea de informații specifice și consiliere psihologică pentru dezvoltarea motivației pentru schimbare și pentru promovarea accesului și/sau reluarea contactului cu resursele specializate de asistență a consumatorilor de droguri.
- Oferirea de informare și sprijin pentru schimbarea modului de administrare și/sau a tipului de drog în scopul prevenirii apariției afecțiunilor asociate consumului.
- Intervenții în criză (supradoză, crize convulsive).
- Oferirea de intervenții medicale de bază.
- Informarea și trimiterea către resursele specifice.
- Abordarea necesităților primare cu scopul facilitării dezvoltării unei atitudini favorabile față de asistența specializată.
- Acoperirea necesităților sociale de bază: alimentație, igienă, îmbrăcăminte, odihnă.
- Consilierea juridică.

Forma de acces: directă, la cererea consumatorilor.

Nivelul 2

Nivelul doi este constituit din unități specializate din sistemul de Sănătate Publică și din Centrele de prevenire, evaluare și consiliere antidrog și asigură asistența specializată, monitorizarea și trimiterea spre cel de-al

treilea nivel ca și coordonarea necesară între toate nivelurile de intervenție. Reprezintă nivelul central pentru întreg sistemul de asistență.

Obiective:

- Obiectivul este oferirea unui tratament individualizat prin includerea într-un program integrat de asistență.
- Realizarea evaluării pe cele cinci arii și managementul de caz
- Realizarea planului individualizat de asistență
- Coordonarea în vederea realizării programelor integrate de asistență
- Implementarea programelor integrate de asistență în centre specifice, în sistem ambulatoriu sau în regim închis

Forma de acces: Centrele de prevenire, consiliere și evaluare antidrog sunt centre de primire directă, cu caracter ambulatoriu, la care pot apela toate persoanele dependente de droguri, cu condiția de a avea domiciliul în aria de influență a centrului respectiv și care fac referire către centrele de asistență, conform planului individualizat de asistență, stabilit cu acordul informat al pacientului.

Nivelul 3

Cel de-al treilea nivel asigură reinsertia socială prin intervenții specifice și prin servicii cu nivel crescut de specializare care sprijină nivelul 2.

Obiective:

- Realizarea dezintoxicării fizice a pacienților cu tulburări datorate consumului de substanțe psihoactive, în regim spitalicesc, atunci când echipa tehnică a centrului de referință consideră imposibilă o dezintoxicare ambulatorie.
- Oferirea unui mediu sigur și de sprijin acelor subiecți care, în procesul de dezintoxicare necesită acest mediu din anumite motive.
- Realizarea intervențiilor sociale și psihologice specifice sau specializate.
- Obținerea abilităților personale necesare pentru reabilitarea ulterioară în regim ambulator.
- Facilitarea unei asistențe individualizate în populațiile care, prin caracteristicile lor, au nevoie de centre de tratament specific.
- Să distribuie metadonă populației dependente de droguri aflate în tratament în alte servicii medicale, servind ca sprijin pentru acestea.
- Să sprijine rețeaua de asistență medicală, psihologică și socială pentru consumatorii de droguri prin intervenții specifice și specializate.
- Să ajungă în cartierele mai îndepărtate de centrele de distribuire existente în comunitate sau în acele cartiere în care acest tip de centre lipsesc.
- Să ofere tratamente specifice medicale sau psihiatrice în cazurile în care aceasta nu se poate realiza în rețelele normalizate.

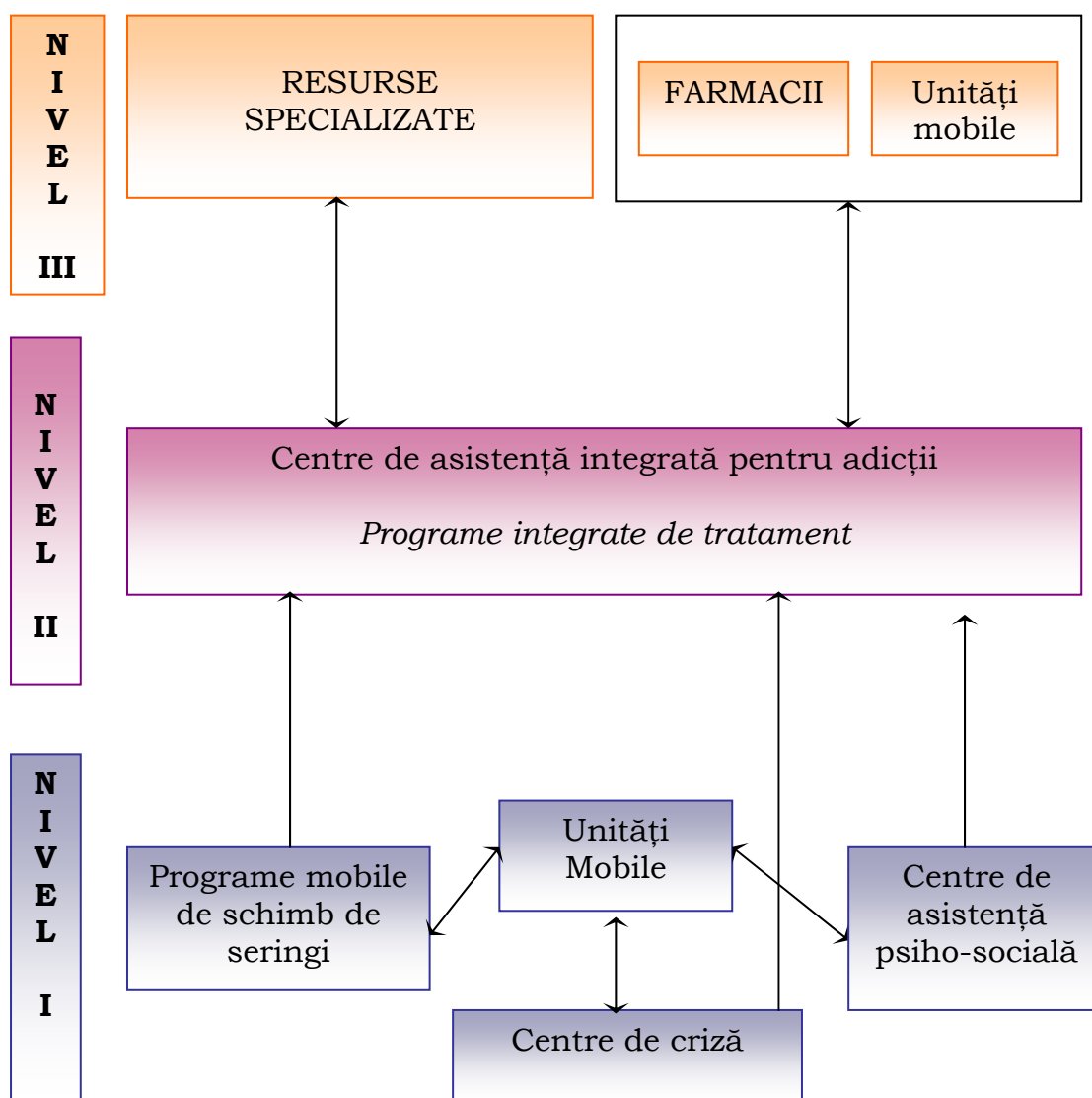
- Asistență la domiciliu dintr-o perspectivă bio-psiho-socială, pentru pacienții cu patologii grave și/sau imobilizați care se află în tratament cu metadonă, sau cu indicații de includere și care nu pot să se deplaseze.

Forma de acces: În cadrul unui program integrat de asistență, prin trimitere din partea echipei de profesioniști a CPCEA.

NIVELURI DE ASISTENȚĂ, FUNCȚII ȘI RESURSE ALE ACESTORA

NIVELURI	FUNCȚII	RESURSE
Primul nivel (Principală cale de acces la sistemul de asistență)	• Identificare, atragere, motivare și trimitere. • Asistența necesităților medicale și sociale de bază. • Coordonare cu resursele nivelului 2.	• Asistență medicală primară. • Servicii Sociale Generale. • Resurse care dezvoltă programe de reducere a riscului. • Servicii de urgență • Alte resurse medicale și sociale ce oferă asistență de bază. Sistem public, privat, mixt sau nonguvernamental
Nivelul doi (Centre de asistență integrată pentru adicții - centrele de referință -	• Planificarea și realizarea evaluării multidisciplinare (bio-psiho-socială) • Elaborarea și dezvoltarea de Planuri individualizate de asistență în cadrul Programelor integrate de asistență. Garantarea asistenței specializate, concomitența și continuitatea serviciilor, precum și trimiterea către servicii din nivelul 3.	• Resurse specializate cu caracter general (asistență primară, specializată sau sănătate mintală - psihiatrie). • Resurse specifice. Sistem public
Nivelul trei	• Asistență specifică și cu grad înalt de specializare • ACCES: doar prin trimitere din resurse ale nivelului 2.	• Resurse de dezintoxicare intraspitalicească. • Resurse Rezidențiale, Comunități Terapeutice etc. Sistem public, privat, mixt sau nonguvernamental

ORGANIZAREA PE NIVELURI A SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ A CONSUMATORILOR DE DROGURI



B. Servicii

În cadrul Standardelor sistemului de asistență pentru consumatorii de droguri următoarele servicii de mai jos au următorul înțeles:

- a) **servicii medicale:** ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor medicale generate de consumul de droguri, în vederea întreruperii consumului, înlăturării dependenței și/sau reducerii riscurilor asociate consumului;
- b) **servicii psihologice:** ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor psihice generate de consumul de droguri în scopul eliminării dependenței psihice și dezvoltării unor abilități personale care să permită integrarea socială a consumatorului;
- c) **servicii sociale:** ansamblu complex de măsuri și acțiuni destinate integrării sociale și profesionale a persoanelor consumatoare de droguri, precum și pentru prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri;
- d) **urgente:** servicii medicale oferite când condiția medicală a unui consumator de droguri, în legătură sau nu cu consumul, îi pune în pericol viața;
- e) **reducerea riscurilor asociate consumului:** ansamblul de măsuri și acțiuni orientate spre reducerea consecințelor negative individuale și/sau sociale generate de consumul de droguri, fără a avea ca obiectiv principal încetarea totală a consumului de droguri;

Obiective:

- Intrarea în contact cu populația aflată în afara rețelei de tratament.
- Vigilență și intervenții cu privire la afecțiunile emergente în colectivele marginale aflate în afara rețelelor medicale (vigilență epidemiologică).
- Reducerea impactului și consecințelor consumului la dependentului: (malnutriție, tulburări ale ritmului somn-veghe, afecțiuni fizico-medicale, psihice, probleme sociale, destructurare) acoperirea necesităților de bază. Intervenții pentru reacțiile acute cu risc vital.
- Diminuarea conflictualității sociale. Diminuarea incidentelor judiciare la consumatori și consumatori dependenți.
- Facilitarea practicilor de injectare mai sigure la persoanele dependente.
- Facilitarea schimbării de la o cale de administrare cu risc crescut la una cu risc minim.
- Facilitarea stabilizării consumatorului dependent în scopul inițierii unui tratament adecvat.
- Facilitarea motivării consumatorului dependent în scopul inițierii unui tratament adecvat

f) **dezintoxicare:** procesul terapeutic ce are ca scop întreruperea consumului pentru acele substanțe capabile să producă dependență fizică și prevenirea sau tratamentul sindromului de abinență;

g) **testarea prezenței drogurilor:** analiza fluidelor organismului (sânge, urina sau saliva) sau a părului sau altor țesuturi pentru depistarea prezenței uneia sau mai multor substanțe psihoactive sau metaboliților acestora;

h) **menținere cu agoniști de opiacee (metadonă, LAAM, buprenorfină etc.):** ansamblul de măsuri terapeutice care are ca obiectiv stabilizarea consumatorului, prin înlocuirea drogului consumat cu un agonist adecvat de la caz la caz, pe o perioadă de timp îndelungată, în vederea reducerii consumului drogurilor și a riscurilor asociate și facilitarea reabilitării și reinsertiei sociale;

i) **susținerea abinenței cu antagonist opiaceu** (de tip naltrexonă): ansamblul de măsuri terapeutice care au ca scop blocarea efectelor drogului utilizat;

j) **schimb de seringi:** ansamblul activităților și măsurilor adresate consumatorilor de droguri injectabile, care au ca scop asigurarea injectării în condiții de siguranță medicală și prevenirea îmbolnăvirilor ce pot surveni din acest mod de administrare (distribuire și colectare de seringi, oferirea altor materiale utilizate la injectare – tampoane dezinfectante, garouri, substanțe de dizolvare, altele – oferirea de referințe și informații, consiliere pentru reducerea riscurilor utilizării drogurilor, intervenții destinate creșterii motivației pentru schimbarea comportamentului, consiliere pretestare și posttestare pentru infecții cu virusul HIV și al hepatitelor virale, al altor infecții cu transmitere sexuală, testare HIV, hepatită B și C, vaccinare, distribuire de prezervative etc.).

j) **reinsertie:** procesul de normalizare a situației personale și sociale a consumatorilor de droguri și de integrare în societate ca cetățean responsabil, autonom și în mod nediscriminatoriu.

k) **consiliere și psihoterapie:** ansamblu de metode, tehnici specifice destinate să faciliteze schimbări ale comportamentului, eliminarea dependenței psihice și dezvoltarea unor abilități personale care să permită integrarea socială a utilizatorului.

C. Furnizorii de servicii

Furnizorii de servicii medicale, psihologice și sociale pentru consumatorii de droguri pot fi persoane fizice sau juridice, publice, private sau mixte, autorizate, iar prestarea serviciilor se face pe baza **standardelor de calitate**. Criteriile și metodologia de autorizare precum și standardele de calitate sunt stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și ministrului administrației și internelor.

Furnizorii **publici** de servicii pentru consumatori sunt:

- a) serviciul public de asistență psiho-socială, prevenire, evaluare și consiliere antidrog;
- b) serviciul public de asistență medicală (de urgență, primară, ambulatorie și de specialitate etc.);
- c) serviciul public de asistență socială;
- d) alte servicii publice.

Furnizorii **privați** de servicii pot fi, în condițiile legii:

- a) asociații și fundații și orice alte forme organizate ale societății civile;
- b) persoane fizice și juridice autorizate în condițiile legii;
- c) organisme internaționale care desfășoară activități în domeniu, potrivit legii.

Furnizorii de servicii de asistență pentru consumatorii de droguri pot încheia convenții de parteneriat, contracte și contracte cadru de servicii medicale și/sau sociale.

Convențiile de parteneriat constituie cadrul de cooperare stabilit în urma negocierilor, în scopul organizării și dezvoltării serviciilor pentru consumatorii de droguri și pentru a se asigura o asistență medicală, psihologică și socială concomitentă. Convenția de parteneriat se referă la:

- a) responsabilitățile furnizorilor;
- b) serviciile implementate de furnizori;
- c) contractele de acordare a serviciilor încheiate între diferiții furnizori;
- d) sursele de finanțare și estimarea nivelului acestora;
- e) resurse umane implicate în acordarea serviciilor;
- f) sancțiuni.

Contractul de acordare servicii cuprinde obligatoriu: serviciile oferite, natura și costurile acestora, drepturile și obligațiile părților, perioada și condițiile de furnizare, cu respectarea standardelor de calitate, sancțiuni în cazul nerespectării condițiilor de calitate.

Contractul cadru de servicii medicale se încheie cu casele de asigurări de sănătate în condițiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

D. Centre

Serviciile se acordă în următoarele tipuri de **centre**:

- a) **centru de evaluare, prevenire și consiliere antidrog;**

- b) **centru de zi:** acordă servicii de asistență în regim ambulator, pe o perioadă de 12 ore;
- c) **centru tip comunitate terapeutică, locuință protejată, locuință socială** etc.: acordă servicii de asistență în regim hotelier;
- d) **centru de tratament al adicțiilor (centru de asistență integrată pentru adicții):** acordă unul sau mai multe servicii de tratament în regim ambulator;
- e) **centre, secții și compartimente de dezintoxicare de tip spitalicesc:** acordă servicii medicale de dezintoxicare într-o structură aprobată de Ministerul Sănătății;
- f) **centru de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri:** acordă servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri în regim ambulator sau unități mobile;
- g) **laborator de sănătate mintală** cu staționar de zi;
- h) **alte** categorii de instituții publice sau private, prevăzute de lege.

Standardele minime obligatorii de organizare și funcționare ale centrelor sunt stabilite și actualizate, după caz, prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și ministrului administrației și internelor.

E. Echipa terapeutică

Echipa multidisciplinară joacă un rol esențial în tratamentul dependenței de droguri. Complexitatea problemei și varietatea sarcinilor profesionale ce necesită a fi desfășurate implică stabilirea unei echipe profesionale multidisciplinare și a unei echipe tehnice care acționează în diferite locații – la nivel comunitar, clinici, spitale, centre de asistență rezidențială, altele.

Funcțiile echipei terapeutice:

- dezvoltarea și menținerea motivației pacientului de a participa la tratament,
- evaluarea condiției pacientului pe parcursul procesului de asistență,
- oferirea de sprijin în obținerea și menținerea abstenenței,
- reducerea impactului consumului de droguri, acolo unde nu poate fi obținută abstenența,
- managementul oricăror complicații acute care pot apărea,
- tratamentul condițiilor bio-medicale și psiho-sociale concomitente,
- încurajarea pacientului în continuarea asistenței,
- prevenirea, depistarea și asistarea recăderilor,

- oferirea instrumentelor prin intermediul activităților de conștientizare psihologică, care să sprijine pacienții și familiile acestora în înțelegerea problemelor legate de consumul de droguri,
- minimalizarea invalidității, morbidității și mortalității în legătură cu consumul de droguri și îmbunătățirea nivelului general de funcționare al pacienților,
- reabilitarea familială, profesională/educațională, socială și interpersonală, comunitară în scopul integrării sociale cât mai facile, progresive și realist posibil de obținut.

Calitatea serviciilor de asistență medicală, psihologică și socială și a celor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri este îmbunătățită prin programe de formare, documentare și cercetare în acest domeniu, dezvoltate de Centrul Național de Formare și Cercetare în Adicții din cadrul Agenției Naționale Antidrog care colaborează pentru îndeplinirea acestui deziderat cu mediul universitar dar și cu alte asociații profesionale, instituții și centre de formare, cercetare, perfecționare din domeniile medical, psihologic și social.

Personalul implicat în furnizarea de servicii de asistență a consumatorului de droguri trebuie să aibă, în afara pregătirii de bază și autorizării, conform legii, o formare profesională inițială și continuă în domeniul drogurilor.

MODALITATEA DE OFERIRE A ASISTENȚEI INTEGRATE

Procesul de acordare a serviciilor de asistență medicală, psihologică și socială are următoarele etape:

- a) evaluarea;
- b) includerea într-un program integrat de asistență (PIT);
- c) elaborarea planului individualizat de asistență (PIA);
- d) implementarea și monitorizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat;
- e) evaluarea implementării măsurilor prevăzute în planul individualizat și a rezultatelor acestora.

Obiectivul evaluării este identificarea caracteristicilor individuale ale consumatorului, în vederea selectării programului integrat de asistență și individualizării serviciilor terapeutice, psihologice și sociale.

Evaluarea se realizează pe următoarele arii:

- a. Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abținere bazat pe istoricul personal și de consum și pe semnele specifice ale acestora;

- b. Condiții bio - medicale și complicații curente care, deși nu au legătură cu sindromul de abstenență sau intoxicarea, necesită tratament deoarece pot genera riscuri sau pot complica procesul de asistență și reabilitare;
- c. Condiții psihologice și/sau psihiatrice și complicații, precum și alte condiții care pot genera riscuri sau pot complica procesul de asistență și reabilitare, cum sunt: acceptarea /rezistența la tratament, potențial de recădere, continuarea utilizării etc.
- d. Condiții sociale și familiale care pot fi surse de suport individual, familial sau comunitar sau pot îngreuna/împiedica procesul de asistență și reabilitare;
- e. Situația juridică anterioară și prezentă

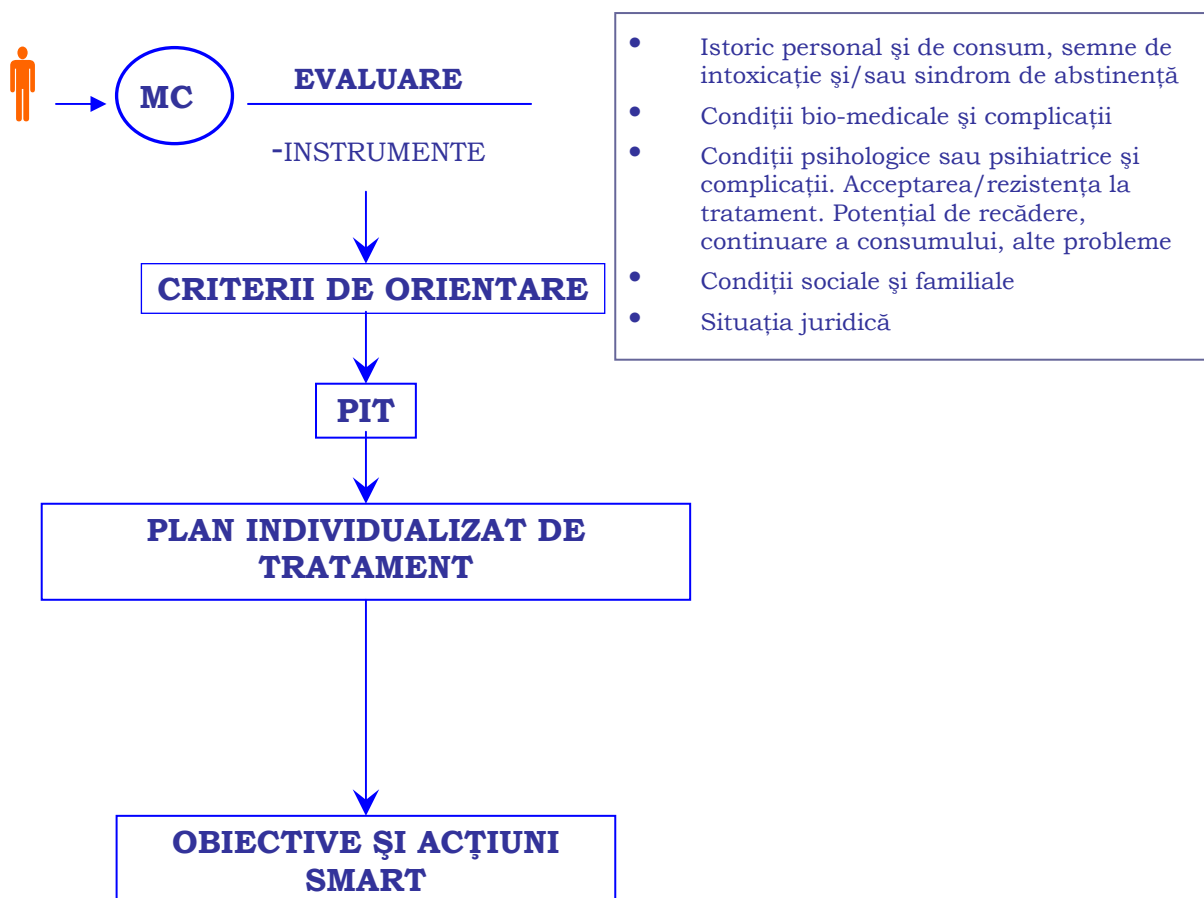
Stabilirea **programului integrat de asistență** în care este inclus consumatorul se face în funcție de criteriile de orientare. **Criteriile de orientare** sunt specifice ariilor de evaluare. Pentru includerea într-unul din cele 4 Programe sunt necesare unul sau mai multe din criteriile enumerate la fiecare arie. Acestea au caracter de orientare pentru selecția programului adecvat profilului fiecărui consumator. Acolo unde criteriile sunt similare sau opuse se vor lua în considerare cele potrivite cazului și orientarea se va face pe baza cumulului criteriilor particulare ale consumatorului de pe toate ariile. În tot cazul, criteriile specifice și cele caracteristice vor fi considerate cele pe baza cărora managerul de caz va face selecția.

Planul individualizat de asistență cuprinde o serie de componente funcționale, ce constau în totalitatea activităților destinate asistenței consumatorilor de droguri, în concordanță cu nevoile depistate, a căror aplicare se desfășoară în centre, servicii sau programe, de-a lungul unui continuum de servicii. Componentele de constituie în general din doua tipuri de intervenții:

- a. **farmacologice:** acestea se desfășoară sub controlul și responsabilitatea echipei medicale și este dezvoltată în sensul restabilirii echilibrului consumatorului de droguri prin intermediul mijloacelor farmacologice. Obiectivele includ:
 - tratamentul intoxicației acute sau a sindromului de abstenență
 - atenuarea efectelor pozitive (plăcute, de creștere a energiei) a drogului de abuz
 - inducerea unor efecte indezirabile la consumul de drog (efect adversiv)
 - înlocuirea drogului de abuz cu un altul, cu efect antagonic
 - tratamentul complicațiilor sau a altor probleme concomitente.
- b. **psiho-sociale:** termenul acoperă o serie de intervenții de diferite tipuri, adresate dezechilibrelor funcționale rezultate din tulburarea adictivă. Acest tip de intervenții include terapiile cognitive-comportamentale, comportamentale, de familie, de grup, psihodinamică, interpersonale, grupuri de auto-suport, suport mutual.

Procesul de acordare a serviciilor în toate etapele sale este evaluat și monitorizat prin intermediul managementului de caz. Managementul de caz urmărește pentru fiecare pacient în parte, următoarele elemente specifice:

- realizarea evaluării pe cele cinci arii de identificare,
- utilizarea criteriilor de orientare, pentru identificarea PIT cel mai adecvat nevoilor depistate în urma evaluării
- includerea într-un PIT și stabilirea unui plan individualizat de asistență
- monitorizarea implementării planului individualizat urmărind:
 - concomitența,
 - trimiterea,
 - șederea
 - ieșirea,
 - durata,
 - evaluarea procesului,
 - evaluarea rezultatului și
 - coordonarea.



II. EVALUAREA ÎN PRETRATAMENT A CONSUMATORILOR DE DROGURI

INTRODUCERE

Atunci când realizăm o evaluare încercăm să evidențiem fiecare dintre relațiile funcționale care se produc, pentru a contura programul integrat de asistență, atât în ceea ce privește intervențiile specifice cât și resursele și nu în sens contrar, așa cum se întâmplă în unele situații, în care se aplică „pachete de programe” și resursele sunt utilizate în formă standard, fără a ține cont de necesitățile individuale. Programele și serviciile vor fi eficace doar în cazul în care sunt utilizate în cadrul unei intervenții adaptate la acestor necesități.

Evaluarea, privită ca o formă de analiză funcțională este instrumentul care permite urmărirea în mod mai eficient a acestor obiective, ceea ce va face posibilă:

- Depistarea comportamentelor problemă
- Cunoașterea elementelor sau variabilelor funcționale care adaptează interacțiunea: funcție de stimul – funcție de răspuns
- Determinarea celorlalte variabile, care nu fac parte din interacțiune și nu sunt specifice acesteia, fiind variabilele dispoziționale în care se află atât pacientul, cât și mediul său, și care afectează probabilitatea ca intervenția să se producă.
- Crearea intervenției specifice pentru fiecare individ:
 - o Stabilirea obiectivelor
 - o Determinarea planului individualizat de asistență
 - o Stabilirea tehnicilor specifice de intervenție.
 - o Alegerea celei mai adecvate structuri.
 - o Determinarea necesității de utilizare a resurselor de sprijin.
 - o Selecționarea modalităților de asistență.
- Monitorizarea și evaluarea rezultatelor intervenției realizate

În consecință, „sarcina noastră va fi de a realiza, în primul rând, o analiză a secvenței sau interacțiunii funcționale și, în al doilea rând, de a întâmpina condițiile date, în ceea ce privește subiectul și mediul, pentru care această interacțiune a fost (explicație) sau va fi (predicție) foarte probabilă, puțin probabilă sau absentă” (Segura, Sanchez și Barbado, 1991).

A fost deja semnalată complexitatea tulburării adictive și multiplele intervenții care trebuie realizate în diferite medii, în funcție de obiectivele programului integrat de asistență care este selectat și momentul în care se implementează. Evaluarea în pretratament, pentru programului integrat de asistență (PIT) și ulterior a planului individualizat de asistență (PIA), urmare a complexității tulburării adictive, este multidimensională, iar ponderea diverselor variabile care trebuie luate în considerare variază. Astfel, spre exemplu, dacă trebuie determinată modalitatea cea mai adecvată de dezintoxicare, variabilele care vor cântări cel mai mult vor fi cele biologice și sociale; în schimb, variabilele psihologice și sociale vor fi cele care vor determina modalitatea de tratament și programele specifice de intervenție în faza ulterioară de detoxifiere.

OBIECTIVELE EVALUĂRII

Consecința imediată a unui proces de evaluare este stabilirea unui program integrat de asistență și crearea unei intervenții individualizate, în care se concretizează obiectivele ce urmează a fi atinse. Prin determinarea obiectivelor se dorește clarificarea fiecăruia dintre comportamentele care trebuie modificate și stabilirea priorităților în abordarea acestora.

Planificarea tratamentului va cuprinde toate obiectivele medicale, psihologice și sociale. Structura unor astfel de obiective se poate stabili prin împărțirea evaluării și a rezultatelor acesteia în arii, dezvoltarea obiectivelor mici operaționale și prioritizarea în timp în funcție de severitate, dar și de potențialul de prognoză a unora dintre rezultate.

Aspecte urmărite în procesul de evaluare multidimensională în pretratament

Evaluarea de constituie în piesa esențială în tratamentul dependenței de droguri, atât în ceea ce privește diagnosticul, cât și gradul de disfuncționalitate în ariile biologică, psihologică, socială și juridică.

Cele cinci arii de evaluare sunt propuse în scopul determinării celui mai adecvat program integrat de asistență față de necesitățile/problemelor individuale depistate. Descrierea acestor arii intenționează să acopere multitudinea aspectelor ce necesită a fi abordate în problematica consumatorilor de droguri.

Aria 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abstenență

Existența riscurilor asociate intoxicației acute a pacientului sau simptomelor severe de abstenență sau convulsii, bazate pe: istoricul personal și de consum, semne specifice.

Aspectele cuprinse în această arie includ:

- Riscul potențial asociat cu nivelul actual de intoxicație acută
- Posibilitatea simptomelor severe de sevraj sau convulsii, bazat pe:
 - simptomele prezentate la întreruperea consumului în antecedente
 - cantitatea, frecvența, caracterul cronic, reducerea recentă a consumului
 - prezența semnelor curente de sevraj
 - disponibilitatea surselor externe de sevraj pentru asistarea pacienților pentru a primi asistență în regim ambulator

În această arie răspunsul terapeutic intenționează să:

- Minimalizeze riscul potențial asociat cu întreruperea consumului
- Faciliteze dezintoxicarea sau accesul la menținerea cu agoniști de opiacee, ca și adresarea concomitentă sau consecutivă a condițiilor depistate în alte arii.
- Promoveze respect față de pacient prin minimalizarea disconfortului din timpul perioadei de întrerupere a consumului

Aria 2: Condiții bio-medicale și complicații

Existența în mod curent a unor afecțiuni fizice care nu au legătură cu sindromul de abținere sau intoxicarea sau care necesită tratament deoarece generează riscuri sau pot complica sau bloca procesul de asistență și reabilitare al consumatorilor.

Aspectele cuprinse în această arie includ:

- Depistarea oricărei afecțiuni fizice, care nu este în legătură cu sevrajul sau intoxicația;
- Determinarea tratamentului necesar pentru evitarea sau minimalizarea riscului ca îmbolnăvirea curentă să interfereze cu procesul de recuperare;
- Depistarea condițiilor cronice, care pot afecta evoluția tulburării determinate de dependență sau a tratamentului acesteia;

Aria 3. Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații; Acceptarea/rezistența la tratament; Potențial de recădere, continuarea utilizării, alte probleme

Existența unor tulburări psihologice și psihiatrice care generează riscuri sau complicații în tratament sau probleme cronice care pot afecta progresul în tratament, în legătură sau nu cu consumul de droguri.

Existența capacității de rezolvare a activităților zilnice, dorinței de angajare în tratament, de schimbare și prevenire a recăderilor

În această arie evaluarea urmărește:

Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații

- Depistarea existenței unor tulburări psihologice sau psihiatrice, care nu sunt în legătură cu sevrul sau intoxicația. Aceste tulburări includ afecțiuni psihiatrice sau probleme comportamentale, emoționale, cognitive;
- Depistarea oricăror afecțiuni cronice psihologice sau psihiatrice care pot interfera cu procesul de recuperare;
- Explorarea poziționării acestor probleme ca fiind de tipul: consecință, parte sau independentă față de tulburarea de consum;
- În cazul în care condiția psihologică sau psihiatrică este în legătură cu consumul, determinarea măsurii în care pentru acestea este necesar tratament psihiatric specific;
- Determinarea capacității curente de a face față activităților zilnice și propriilor probleme emoționale, comportamentale sau cognitive;

Acceptarea/rezistența la tratament

Evaluarea acceptării/rezistenței la tratament merge mai departe decât evaluarea gradului de negare sau opoziție la tratament. Dorința pacientului de a se angaja în tratament este determinată în scopul schimbării stilului de viață și creșterii gradului de funcționare individuală și socială. În explorarea aspectelor acoperite de această dimensiune, scopul este de a stabili:

- Gradul așteptat de cooperare în tratament
- Măsura în care pacientul este conștient de impactul negativ al consumului de droguri asupra calității vieții sale

Cunoașterea măsurii dorinței pacientului pentru schimbare este mult mai utilă în selectarea tratamentului adecvat și a intensității folosirii intervențiilor de creștere a motivației, decât de a luări în considerare doar a alegerii de către pacient a unei forme de tratament, ca unica modalitate de adecvare la necesitățile acestuia și orientarea către un program integrat de asistență.

O data ce aceste aspecte au fost evaluate, se poate trece la stabilirea gradului în care strategiile programelor existente stimulează creșterea angajamentului în tratament și a motivației și participării, pentru selecția programului și dezvoltarea planului individualizat de asistență.

Potențial de recădere, continuarea utilizării, alte probleme

Evaluarea în această arie are caracter prognostic și se referă la probabilitatea revenirii la consum sau a continuării consumului, ca și a evoluției altor probleme în special cele psiho-sociale, dar fără excluderea tulburărilor psihiatrice sau altor probleme de sănătate. Este evaluată de asemenea măsura în care aceste circumstanțe afectează progresul pacientului în recuperare.

În cazul recăderii, decizia de orientare a pacientului către un anumit program trebuie să se bazeze pe istoricul prealabil al tulburării, situația pacientului și a familiei și o analiză detaliată a situației curente și a determinantilor pentru consum. Eșecul terapeutic sau agravarea tulburării nu indică în mod necesar schimbarea, necesitatea trecerii într-un program în care condiția de consum este considerată mai severă sau a creșterii nivelului de intensitate al intervențiilor.

Aspectele care trebuie considerate în evaluarea în această dimensiune includ:

- Pericolul imediat al unor probleme severe urmare a consumului
- Capacitatea pacientului de a realiza, recunoaște și confrunta problema dependenței sau a tulburării psihiatrice, de a face schimbările necesare pentru prevenirea recăderilor, întreruperii consumului, sau prevenirii continuării problemelor asociate.
- Severitatea problemelor care trebuie confruntate și stresul suplimentar asociat care poate rezulta în cazul în care pacientul nu se angajează cu succes în tratament, în acest moment.
- Gradul de conștientizare de către pacient a mecanismelor declanșatoare a recăderilor, a alternativelor de a face față dorinței intense de consum, și gradul de control asupra impulsului de a consuma sau de a fi un risc pentru sine sau pentru alții.

Aria 4: Condiții sociale și familiale

Acestea se referă la mediul de recuperare și mediul de viață. În această arie se evaluează mediul exterior pacientului și impactul acestuia asupra recuperării. Existența pericolului potențial pentru siguranța pacientului sau angajarea în tratament, a surselor de suport individual, familial sau comunitar.

Evaluarea constă din:

- Examinarea mediului pacientului pentru a identifica orice amenințare la siguranța pacientului sau a continuității angajării acestuia în tratament. Aceste riscuri pot fi depistate în mediul de viață, familie, relații personale, slujbă, școală, altele.

- Explorarea surselor potențiale de suport: oameni, resurse financiare, posibilități educaționale sau de angajare – aceasta va ajuta la îmbunătățirea pronosticului de succes al tratamentului.
- Evaluarea condițiilor sociale care măresc motivația pacientului de a solicita tratament, cum ar fi presiunea familiei, a serviciului sau cea juridică.
- Determinarea disponibilității suportului comunitar pentru procesul de recuperare, cum ar fi facilitățile de transport, de supraveghere a copiilor, locuința sau găzduirea și angajarea.

Aria 5: Situația juridică

Situația juridică reflectă, în ansamblu, atitudinea “pacientului” față de ordinea de drept. O eventuală încălcare a normelor de drept exprimată în antecedentele penale în legătură sau nu cu drogurile constituie un reper important în orientarea intervențiilor specifice.

În mod concret, criteriile din această arie sunt informații/date determinate despre pacienți, înscriindu-se în istoricul comportamental al acestora. Situația generală este cea în care aria juridică este pozitivă privind din perspectiva respectării normelor juridice. În această situație, atunci când pacientul nu are contact cu sistemul judiciar întrucât nu a încălcat prin actele sale nici o lege, în aria juridică nu va fi înregistrat nici un criteriu.

Există și situația în care pacientul a adus o vătămare valorilor sociale protejate prin lege, caz în care poate avea antecedente penale sau poate fi în momentul evaluării subiect al procesului penal.

Criteriile ariei juridice sunt de fapt, infracțiuni, pedepse, măsuri de siguranță. Unele dintre criteriile constând în infracțiuni sunt indicate în mod concret și anume infracțiunile de trafic de droguri și cele legate de consumul ilicit. Acestea vor fi menționate expres, conform legii speciale în materie sau Codului penal. Vor fi indicate, de asemenea, infracțiunile cu violență.

În funcție de momentul evaluării, criteriile acestei arii arată situația juridică anterioară sau cea care îl caracterizează pe pacient în momentul respectiv.

Cu referire la situația prezentă (pct. b), care este cea ulterioară primei evaluări este important de reținut că aceasta este susceptibilă de modificare, criteriile acestei secțiuni fiind condiționate de faza procesuală în care pacientul - implicat într-un proces penal - se află precum și de atitudinea acestuia în diferitele faze ale procesului. Spre exemplu, în cazul unui pacient – inculpat într-un proces penal pentru infracțiuni în legătură cu consumul - , în contextul noilor dispoziții legale care prevăd posibilitatea amânării aplicării pedepsei, unul dintre criterii este însuși termenul de încercare, respectiv termenul fixat de instanță pentru a se pronunța.

Evaluarea este coordonată și/sau efectuată de **managerul de caz** sau de personalul de specialitate cu competențe în domeniul asistenței sociale, psihologie, medical din cadrul CPECA sau din alte servicii autorizate în cadrul unor echipe interdisciplinare de specialiști.

Problema plasării pacienților cu diagnostic dual

În general, s-a constatat o creștere a numărului pacienților cu probleme psihiatrice în concomitență cu tulburarea de consum ceea ce face necesară dezvoltarea unei abordări unitare și specifice.

Variabilitatea serviciilor pentru pacienții cu diagnostic dual se explică prin următoarele:

- creșterea consumului de droguri în rândul tinerilor, cu scăderea vârstei de debut
- creșterea conștientizării asupra naturii tulburării adictive, bazată pe ample evidențe științifice asupra mecanismelor neurofiziologice ale dependenței de droguri;
- gradul de acceptare al abordării farmacologice în tratamentul dependenței de droguri, cu dezvoltarea unor alternative farmacologice și diminuarea controverselor cu privire la această alternativă;
- înțelegerea mai bună a dimensiunii psiho-sociale a tulburării de consum și folosirea strategiilor cognitiv-comportamentale psiho-sociale, cu o creștere corespunzătoare a cunoștințelor privind modalitățile de răspuns la varietatea de necesități individuale ale pacienților;
- creșterea conștientizării legate de sănătatea mintală, securitatea socială și sistemul de justiție, cu impact asupra tulburărilor de consum și o angajare mai mare în intervențiile precoce ca alternativă la închisoare.

În plasarea acestor pacienți trebuie luată în considerare severitatea afecțiunii concomitente, ca factor decizional la această categorie de pacienți. Ca regulă generală poate fi acceptată următoarea conduită: în cazul în care condiția medicală sau psihiatrică este severă, se va acorda prioritate stabilizării acesteia, amânând tratamentul dependenței de droguri după obținerea stabilizării. Inițierea tratamentului pentru dependența de droguri, ca primă abordare trebuie să fie subiectul unei evaluări bazate pe principiul „problema cea mai severă determină prioritizarea” , lăsând liberă alternativa de a de a crește sau scădea intensitatea intervențiilor, în concordanță cu evoluția pacientului.

Pentru pacienții cu diagnostic dual, inclusiv cei cu schizofrenie, tulburări emoționale sau de personalitate severe (cum ar fi borderline), sunt necesare programe speciale pentru tratamentul dependenței. În alte circumstanțe, cum ar fi schimbările de dispoziție sau anxietatea, condiții care sunt mult

mai stabile și în care simptomele nu interferează semnificativ cu alte activități, pacienții pot fi tratați în programele integrate de asistență.

ARII DE EVALUARE - DESCRIERE

Ariile de evaluare

Aria 1 **Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abinență**

Descrierea aspectelor ce trebuie evaluate

Se evaluează riscurile actuale ale pacientului de intoxicație acută/cronică sau de sindrom de abinență sau convulsii, bazate pe:

- Istoricul pacientului
- Cantitatea, frecvența, natura cronică sau natura recentă a reducerii sau întreruperii consumului de alcool sau alte droguri
- Semne curente ale sindromului de abinență
- Surse de suport extern pentru program de dezintoxicare în ambulator
- Pericol imediat de probleme severe ca rezultat al consumului de droguri

Aria 2 **Condiții bio-medicale și complicații**

Existența unor condiții bio-medicale, fără legătură cu sindromul de abinență sau intoxicație.

Condițiile existente, acute sau cronice, necesită tratament deoarece prezintă riscuri sau complicații pentru procesul de recuperare.

Existența unor tulburări cronice care afectează evoluția dependenței sau tratamentului acesteia.

Aria 3 **Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații;**

Existența în prezent a unor condiții psihologice sau psihiatrice cu risc pentru tratament, probleme cronice care pot afecta progresul în tratament.

Se verifică dacă problemele psihologice sau psihiatrice reprezintă consecințe ale consumului de droguri, fac parte din problema consumului de droguri, sau nu sunt în legătură cu consumul de droguri și dacă aceste condiții sunt suficient de severe pentru a necesita tratament specific.

Gradul de risc asupra propriei persoane sau asupra celorlalți.

Capacitatea curentă a pacientului de a gestiona activitățile zilnice și de a face față problemelor psiho-emoționale.

Acceptare/rezistență la tratament;

Dorința pacientului de a se angaja în tratament care reprezintă un instrument pentru schimbare și îmbunătățire a funcționării.

Capacitatea pacientului de a recunoaște și de a se confrunța cu problema dependenței sau tulburarea mintală, realizând schimbările necesare pentru

prevenirea recăderilor, întreruperea consumului sau prevenirea continuării problemelor asociate acestuia.

Evaluarea impactului severității problemelor actuale și a stresului suplimentar generat de tratament care poate conduce la eșecul pacientului de a se angaja cu succes în tratament la acest moment.

	Potențial de recădere, continuare a consumului sau alte probleme	Nivelul de conștientizare cu privire la mecanismele care declanșează recăderile, alternative de coping față de nevoia imperioasă de a consuma droguri și gradul de control asupra impulsurilor de a consuma droguri.
Aria 4	Condiții sociale și familiale	Stil sau condiții de viață care reprezintă un potențial pericol pentru siguranța pacientului sau angajamentul în tratament (situații din viața cotidiană, relațiile cu familia sau cu persoanele semnificative, situația profesională sau educativă. Surse de suport – persoane, resurse economice, posibilități de angajare – care ar putea sprijini întărirea motivației pentru tratament și creșterea posibilității de succes terapeutic. Disponibilitatea suportului comunității pentru procesul de recuperare.
Aria 5	Situația juridică	a) situația anterioară - antecedente penale fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor - antecedente penale în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor - trafic - consum - violență - altele - pedepse aplicate privative de libertate - pedepse aplicate neprivative de libertate - măsuri de supraveghere și obligații impuse - măsuri de siguranță b) situația prezentă: - proces penal fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor - proces penal în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor - în urmărire penală - în judecată - termen încercare - executare pedeapsă privativă de libertate - executare pedeapsă neprivativă de libertate - măsuri supraveghere și obligații

REZULTATELE EVALUĂRII

Din punct de vedere organizatoric, rezultatul evaluării se consemnează într-un raport de evaluare al cărui model este prezentat în anexă. În situația în care consumatorul este de acord cu includerea în program, acesta semnează acordul de asistență medicală, psihologică și socială la care este anexat planul individualizat de asistență.

Din punct de vedere al acordării asistenței, rezultatele evaluării sunt colectate de către managerul de caz (care coordonează și se asigură de efectuarea evaluării). Acesta listează și ierarhizează problemele depistate în cele cinci arii de evaluare și, utilizând criteriile de orientare a pacientului, selectează programul integrat de asistență (PIT), care apare a adresa cel mai bine necesitățile pacientului. Foarte sintetic, procesul de selecție cuprinde următoarele faze: stabilirea potențialului pacientului de a se angaja și menține într-un program integrat drog 0, sau sunt necesare măsuri și intervenții pentru menținerea cu agoniști de opiacee. Dacă pacientul, în urma aplicării criteriilor de orientare, este eligibil pentru prima alternativă (drog 0), se va stabili gradul de intensitate al intervențiilor și problematica individuală cu selectarea unuia din primele trei PIT (1-3). Selecția va urmări depistarea criteriilor specifice și se va desfășura în colaborare cu pacientul. După selectarea unui PIT, urmează etapa de pregătire și dezvoltare a unui plan individualizat de asistență (PIA). Pentru dezvoltarea unui PIA adecvat necesităților/ problemelor depistate managerul de caz, în acord cu pacientul, va stabili tipul de servicii ce urmează a fi acordate și modalitatea de asistență. Procesul terapeutic prin care urmează să fie atinse obiectivele PIA cuprinde o serie de servicii desfășurate într-una sau mai multe modalități de asistență, care se concretizează într-un continuum al asistenței.

EVALUAREA DE PROCES ȘI EVALUAREA ÎNAINTE ȘI LA IEȘIREA DIN PROGRAM

Așa cum am menționat, procesul terapeutic este determinat de *evaluarea inițială* și este urmărit prin intermediul *evaluării continue*, pentru stabilirea măsurii în care sunt îndeplinite obiectivelor stabilite, la intervalele de tip stabilite, pentru fiecare pacient în parte.

În cadrul acestui continuum de evaluare, se stabilesc momente precise pentru aprecierea progresului unui consumator în cadrul unui program integrat de asistență.

Aceste momente sunt denumite *evaluări de proces*, în care, diferiții profesioniști care intervin în procesul terapeutic al consumatorului și pe de alta parte managerul de caz actualizează analiza funcțională pentru a determina progresul pacientului și pentru stabilirea adecvărilor sau

schimbărilor necesare. Aspectele cele mai relevante, apreciate în evaluarea de proces, sunt:

- Obiective individuale urmărite,
- Perioada de abstenență la principalele droguri. Alunecări ocazionale. Recăderi,
- Consum de alte droguri,
- Aderența la tratament,
 - o Participare,
 - o Asistență,
 - o Punctualitate,
 - o Realizarea sarcinilor terapeutice,
- Aprobarea conținuturilor diferitelor programe specifice,
- Achiziționarea de abilități specifice,
 - o Abilități de anticipare și prevenire a recăderilor,
 - o Abilități de înfruntare a stresului și stărilor depresive,
 - o Abilități de îngrijire a propriei persoane,
- Schimbări în stilul de viață, analizând în formă exhaustivă ceea ce s-a produs în următoarele arii:
 - o Conviețuire,
 - o Relaționare,
 - o Destindere și petrecerea timpului liber,
 - o Formare de abilități sociale, profesionale,
 - o Situație juridică,
 - o Situație economică,
 - o Status medical.

Aceeași procedură se va realiza pentru decizia de ieșire din programul terapeutic și inițierea urmăririi, menținând criteriile minime stabilite pentru ieșire.

🗒 PUNCTE CHEIE:

- o Evaluarea se constituie în etapa esențială a acordării asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri.
 - o Caracterul multidimensional al evaluării permite depistarea problemelor legate de consumul de droguri în complexitatea și consecuția acestora și contribuie esențial la adresarea individualizată a asistenței prin intermediul planului individualizat de asistență.
 - o Aspectele urmărite pe cele cinci arii de evaluare vor permite utilizarea ulterioară a criteriilor de orientare pentru stabilirea programului integrat de asistență.
 - o Criteriile de selecție a serviciilor specifice și a modalității de asistență se constituie în aspecte ce trebuie urmărite de asemenea în cadrul evaluării în scopul stabilirii planului individualizat de asistență.
 - o Stabilirea planului individualizat nu va urmări exclusiv criteriile de selecție.
-

III. CRITERII DE ORIENTARE A PACIENTULUI

Criteriile de orientare reprezintă un set de caracteristici cu funcție normativă, stabilite în scopul standardizării asistenței și tratamentului adresat consumatorilor de droguri pentru obținerea unei eficiențe clinice optime și pentru alocarea eficientă a costurilor. Cercetările demonstrează că abordările terapeutice integrate adresate consumului abuziv de substanțe reduc consumul de alcool și droguri și ameliorează condițiile medicale asociate și problemele sociale, familiale și psihologice. Cu toate acestea, eficacitatea intervențiilor și programelor variază foarte mult. Deși primele principii privind oferirea unui program de asistență potrivit există de mai mult de jumătate de secol, protocoalele au devenit recent disponibile practicienilor.

Tulburările determinate de consumul de substanțe sunt heterogene și variază în funcție de populație. Evaluarea standardizată poate crește eficiența tratamentului prin faptul că permite individualizarea asistenței și totodată permite alocarea eficientă a costurilor. Criteriile se constituie într-o serie de elemente specifice de descriere, având ca scop orientarea către un program integrat de asistență adecvat gradului de severitate stabilit în urma evaluării pe cele cinci arii. Conceptualizarea acestora implică necesitatea unui spectru larg al continuumului asistenței, unei evaluări și asistențe comprehensive adresate nevoilor biologice, psihologice și sociale.

Dezvoltarea criteriilor a avut ca sens inițial oferirea unor linii directoare necesare pentru plasarea pacienților cu combinații specifice de probleme, în programul integrat de asistență potrivit/adecvat. Menționăm faptul că adecvarea nu se referă la un tratament sau serviciu, ci se realizează prin oferirea unei palete de servicii planificate pe baza identificării nevoilor pacientului și concretizate în planul individual de asistență. Ulterior, am observat că, deși, scopul principal a fost oferirea unui grad înalt de specificitate, în sensul adresării paletei de servicii cât mai adecvate nevoilor individuale, parte relativ importantă se regăsește în orientarea către două sau mai multe programe integrate de asistență. Acest fapt se datorează în parte, caracterului complex al tulburării adictive, ceea ce face ca, cel puțin teoretic, toți indivizii cu tulburări prin consum de substanțe să prezinte probleme multidimensionale, iar pe de altă parte funcției de orientare a criteriilor, făcând astfel deosebirea față de un set de reguli, care trebuie urmate întocmai.

De aici nu trebuie să se înțeleagă faptul că aproape orice pacient poate fi orientat în oricare din programele integrate (PIT), deoarece există criterii specifice pentru fiecare tip de orientare, iar pentru selectarea cât mai adecvate a intrării într-un PIT gradul de flexibilitate menționat poate fi de real folos pentru adecvarea în funcție de intensitatea problematicei depistate

în fiecare arie, a capacităților și limitărilor fiecărui pacient și a mediul său de suport. Aceste elemente fac activitatea managerului de caz mai amplă, mai complexă și mai responsabilă, în sensul în care cunoștințele și experiența sa, cât și lucrul în cadrul echipei multidisciplinare sunt un factor semnificativ în cântărirea fiecărui criteriu și orientarea potrivită nevoilor pacientului, către unul din cele patru PIT.

CONTINUITATEA ASISTENȚEI MEDICALE, PSIHOLOGICE ȘI SOCIALE

Un avantaj deosebit al criteriilor este că acestea încurajează continuitatea, multidisciplinaritatea, ca și abordarea multidimensională, comparativ cu abordările tradiționale focalizate asupra dezintoxicării intraspitalicești și postcurei.

Criteriile oferă un grad de caracterizare a fiecărui program integrat de asistență, ca și a fiecărui pacient în parte. Evaluarea pe cele cinci arii, plasarea specifică într-un program integrat de asistență face ca ariile specifice ale asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri, să devină modalități sistematice de descriere a continuumului de asistență.

Deși criteriile sunt definite în funcție de cele cinci arii de evaluare, acestea au cel puțin două limitări care trebuie luate în considerare de către clinicieni: dimensiunea fiecărui criteriu în scopul ierarhizării acestora ca și faptul că multe din acestea nu sunt specifice strict pentru un anumit program. Lipsa de claritate generată de aceste din urmă două aspecte permite un grad de variabilitate, dar și standardizarea excesivă ar determina o diminuare a flexibilității. Clarificarea acestor aspecte revine gândirii clinice, care nu poate fi substituită de nici un instrument de standardizare.

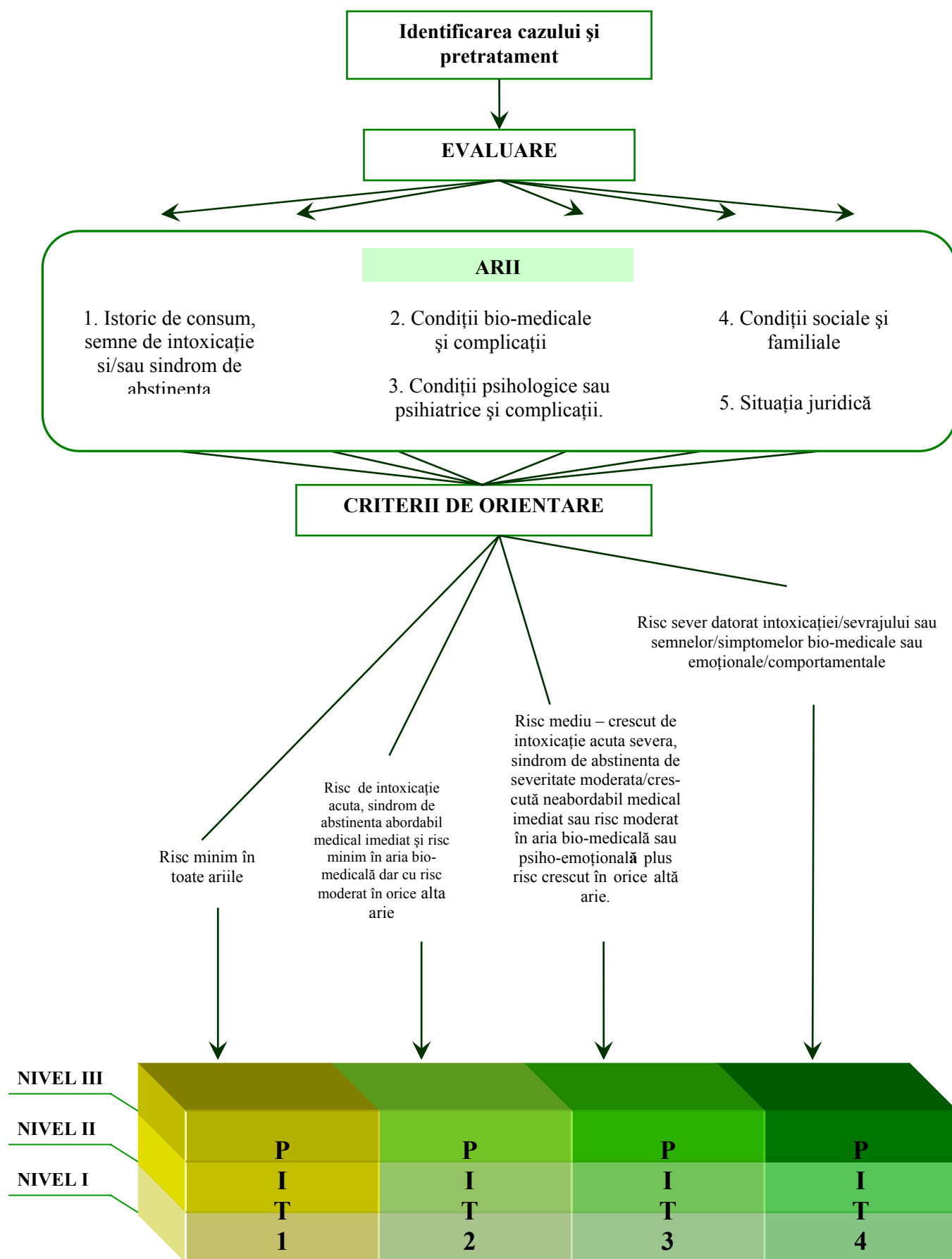
În general, literatura cu privire la rezultatele tratamentului duce la concluzia că nici o abordare singulară nu este superioară. În dezvoltarea criteriilor de orientare s-a ținut cont de adecvarea abordării terapeutice la nevoile pacienților dar și de relația cost-eficiență a intervențiilor.

RAȚIUNEA INTRODUCERII CRITERIILOR DE ORIENTARE

Rațiunea principală a dezvoltării criteriilor de orientare este de a permite selectarea programului integrat de asistență cel mai potrivit cu statusul și nevoile individuale ale fiecărui pacient, obținute în urma evaluării. În cazul în care criteriile utilizate sunt valide și este disponibil un continuum de structuri organizatorice crearea rețelei de management al cazurilor este cea mai bună oportunitate pentru optimizarea clinică și a costurilor.

În contrast cu modalitățile de asistență, programele de asistență sunt opțiuni de plasare care oferă structuri de intensități diferite, modalități de abordare corelate consecutive și continue, dar și discrete restricții în tratament. Nivelurile tipice de asistență au implicații importante în ceea ce privește costurile; nivelurile tipice de asistență în ordine descrescătoare în funcție de cheltuieli sunt: spitalele, structurile cu regim închis non-spitalicești (sau rezidențiale), tratament de zi și asistență în ambulator. Pe de altă parte, programele integrate de asistență au implicații în abordarea concretă, individualizată și continuă a pacienților în funcție de nevoile depistate ale acestora, scopul fiind eficientizarea asistenței în sensul rezultatelor așteptate.

Următoarea schemă conturează cele patru Programe integrate de asistență dezvoltate de Agenția Națională Antidrog.



ORIGINILE CRITERIILOR PENTRU PLASAREA PACIENTULUI

Criteriile specifică regulile pentru orientarea pacienților potrivit nevoilor individuale ale acestora. Pentru a orienta un pacient, se solicită ca evaluatorul să realizeze să stabilească un diagnostic și apoi să evalueze caracteristicile pacientului după cele cinci arii.

Adecvarea asistenței se realizează în funcție de trei momente: admitere/intrare, examinarea continuării șederii și terminare. Până în acest moment sunt stabilite numai prima categorie de criterii, celelalte două vor fi elaborate pe măsura dezvoltării și diversificării sistemului integrat de asistență, adecvat monitorizării și evaluării implementării standardelor.

Terapiile farmacologice cum ar fi dezintoxicarea și terapia de menținere cu opiacee (de exemplu, terapia cu metadonă) au fost separate de serviciile de reabilitare și au fost create criterii multinivelare pentru intrarea în structurile cu regim închis sau ambulatorii.

Pe măsura dezvoltării și diversificării sistemului de asistență va fi necesară completarea criteriilor în funcție de gradul de intensitate al asistenței (ambulatorii – asistență de zi, de noapte, etc. sau în regim închis - internare, etc.)

AVANTAJE ȘI LIMITĂRI ALE UTILIZĂRII CRITERIILOR DE ORIENTARE

Dezvoltate și implementate adecvat, criteriile asigură dezvoltarea unor abordări terapeutice unitare și standardizate, îmbunătățirea adecvării serviciilor și alocarea cost-eficientă a resurselor. Aplicarea criteriilor asigură continuitatea și consistența serviciilor de asistență oferite consumatorilor de droguri și limitează posibilitatea oferirii unor măsuri minime de asistență, urmare a constrângerilor/considerentelor financiare sau absenței alternativelor de tratament.

Un risc major al aplicării criteriilor de orientare este posibilitatea ca acestea să fie luate în considerare *ad literam* de cei care nu sunt implicați direct în asistența consumatorilor de droguri, ceea ce conduce la oferirea unor servicii insuficient adecvate la nevoile individuale ale consumatorilor.

Managerii de caz și clinicienii trebuie să analizeze fiecare caz în parte înaintea stabilirii unui program integrat de asistență și să propună consumatorului un plan individualizat de asistență. Considerarea unui tip de abordare ca fiind cel „corect” conduce la pierderea potențialului de multidimensionalitate, continuitate și integralitate. Valoarea esențială a criteriilor de orientare constă în posibilitatea furnizorilor de servicii de a identifica nevoile specifice ale fiecărui consumator, prin intermediul procesului de evaluare detaliat, urmat de selectarea programului integrat de

asistență care să se adreseze nevoilor specifice identificate, prin intermediul planului individualizat și intrării în continuumul de asistență.

CRITERII DE ORIENTARE ÎNTR – UN PROGRAM INTEGRAT DE TRATAMENT

Pentru includerea într-unul din cele 4 programe sunt necesare unul sau mai multe dintre criteriile enumerate la fiecare arie. Acestea au caracter orientativ, în general, mai puțin cele specifice și caracteristice, pentru selectarea programului adecvat profilului fiecărui consumator. Acolo unde criteriile sunt similare sau opuse se va lua în considerare cel potrivit cazului și orientarea se va face pe baza cumulului criteriilor particulare ale consumatorului de pe toate ariile. Prin *condiție specifică* descriem aspecte relevante ale celor cinci arii de evaluare care nu se regăsesc în nici un alt grup de criterii, iar prin *condiție caracteristică* descriem condițiile care definesc fiecare tip de program integrat în parte, dar care nu sunt neapărat regăsite doar în unul din cele patru PIT.

Criteriile juridice sunt aceleași în toate cele patru categorii de criterii, ceea ce nu înseamnă că acestea nu se constituie în factori de orientare, ci că echipa de evaluare și managerul de caz vor lua în considerare potențialul problematic atât al problematicei anterioare (în sensul riscurilor actuale) cât și al situației actuale în sensul planificării și monitorizării cazului în coordonare cu sistemul de justiție și având în vedere legislația în vigoare. De asemenea, trebuie să se țină cont și de alți factori specifici acestor situații: motivația pentru schimbare poate să lipsească în totalitate sau factorii care determină acceptarea tratamentului să fie diferiți, măsurile cu caracter juridic pot fi adesea într-un grad de disonanță cu cele de recuperare, dificultatea parcurgerii continuumului de asistență este crescută, fiind semnalate frecvent cazuri în care pacientul renunță și dorește să se reîntoarcă în sistemul penitenciar, condițiile sociale sau cele psihologice și comportamentale pot fi mult mai dificile sau mai complexe și multe altele, specifice fiecărui caz.

Program integrat de asistență 1 (PIT 1): Program drog 0 de intensitate mică

Descriere: Risc minim în toate ariile

ARIA 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abstenență

Istoricul de consum (durata, intensitatea, tipul și numărul drogurilor consumate, modalitatea de administrare, caracteristicile consumului din ultimele două săptămâni) nu releva un potențial risc de intoxicație acută

sau sevraj (*condiție specifică*). Modalitatea de consum nu indică necesitatea dezintoxicării ca modalitate terapeutică de răspuns (*condiție specifică*).

Criterii:

1. istoric scurt de consum;
2. monodependență;
3. istoric recent de administrare intravenoasă;
4. absența consumului de droguri în ultimele 2 săptămâni, dar există potențial de recădere și necesită asistență de prevenire a recăderilor;
5. consum de droguri cu potențial mic de dependență;
6. nu prezintă risc de sevraj;
7. nu este necesar un management medical pentru consumul de droguri;
8. nu este necesară dezintoxicarea.

ARIA 2: Condiții bio-medicale și complicații

Condițiile bio-medicale în legătură sau asociate consumului pot fi absente, sau pot fi vindecate. Acestea nu au caracter cronic sau nu interferează cu procesul de recuperare. Răspunsul terapeutic pentru condițiile bio-medicale poate fi oferit în ambulator sub forma urmăririi periodice. Nu este necesar tratamentul în regim spitalicesc pentru condițiile bio-medicale, înaintea sau în timpul procesului de recuperare.

Criterii:

1. fără condiții medicale cronice;
2. starea de sănătate nu a fost afectată de consum;
3. existența unor condiții bio-medicale care pot fi vindecate sau care nu interferează cu procesul de recuperare;
4. există condiții medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică.

ARIA 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații. Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme.

Condițiile psihologice sau psihiatrice și complicații în legătură sau asociate consumului pot fi absente sau sunt abordabile în acest program. Acceptarea tratamentului, ca și potențialul de recădere pot fi sau nu prezente. Potențialul de continuare a consumului este minim sau redus. Răspunsul terapeutic se poate desfășura în sistem ambulator sau rezidențial în funcție de severitatea condițiilor depistate.

Criterii:

Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații:

1. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații;
2. există tulburări emoționale și/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare;
3. risc absent sau redus pentru sine sau alții;
4. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 1;
5. există condiții psihologice care necesită monitorizare atentă în regim închis;

Acceptarea/rezistența la tratament:

6. conștientizarea problemei și dorința de angajare în tratament;
7. grad redus sau absent de conștientizare și/sau motivare; necesită asistență structurată de intensitate medie sau mare.

Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:

8. risc redus de recădere;
9. potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis.

ARIA 4: Condiții sociale și familiale

Condițiile sociale și familiale în legătură sau asociate consumului pot fi favorabile recuperării, nu interferează cu procesul de recuperare sau interferează, dar într-o măsură manageriabilă pentru acest program. Răspunsul terapeutic se va sprijini pe mediul suportiv existent, sau va urmări creșterea capacității de coping sau considera necesitatea sprijinului sistematic prin acordarea asistenței în regim închis, în funcție de intensitatea condițiilor depistate.

Criterii:

1. mediu suportiv;
2. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare;
3. mediul nu este suportiv, dar asistența poate crește abilitățile de coping;
4. mediu nesuportiv sau interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis.

ARIA 5: Situația juridică

Prezența unor antecedente juridice face necesară evaluarea riscurilor actuale în stabilirea modalităților de asistență din cadrul PIT, iar cele actuale, fac necesară considerarea impactului acestora asupra elaborării și implementării planului individualizat de asistență (atât din punct de vedere al specificităților problematicei acestor pacienți, cât și al implicațiilor deciziilor juridice) și al colaborării permanente cu sistemul de justiție.

Criterii:**a) situația anterioară:**

1. antecedente penale fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor;
2. antecedente penale în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor;
3. trafic;
4. consum;
5. violență;
6. altele;
7. pedepse aplicate privative de libertate;
8. pedepse aplicate neprivative de libertate;
9. măsuri de supraveghere și obligații impuse;
10. măsuri de siguranță.

b) situația prezentă:

1. proces penal fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor;
2. proces penal în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor;
3. în urmărire penală;
4. în judecată;
5. termen încercare;
6. executare pedeapsă privativă de libertate;
7. executare pedeapsă neprivativă de libertate;
8. măsuri supraveghere și obligații.

Program integrat de asistență 2 (PIT 2): drog 0

Descriere: Risc de intoxicație/sevraj de intensitate mică și risc minim în aria bio-medicală dar cu risc moderat în orice alta arie

ARIA 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abstenență

Istoricul de consum (durata, intensitatea, tipul și numărul drogurilor consumate, modalitatea de administrare; caracteristicile consumului din ultimele două săptămâni) nu relevă un risc crescut de intoxicație sau sevraj de intensitate severă. Modalitatea de consum sau/si simptomele de sevraj indica necesitatea dezintoxicării (*criteriu caracteristic*) în regim ambulator sau spitalicesc în funcție de condițiile existente în celelalte arii, continuată sau nu, de susținerea abstenenței cu antagoniști de opioace (în cazul în care drogul de consum este heroina).

Criterii:

1. istoric mediu sau scurt de consum;
2. monodependență;
3. perioade de abstenență semnificative (60 zile) în istoric;
4. consum de droguri în ultimele 2 săptămâni;
5. recădere recentă;
6. risc minim de sevraj sever, există surse externe pentru administrarea medicației;
7. semne curente ale sindromului de abstenență moderat-sever și necesită medicație și monitorizare în regim închis.

ARIA 2: Condiții bio-medicale și complicații

Condițiile bio-medicale în legătură sau asociate consumului pot fi absente sau pot fi vindecate. Uneori, acestea pot avea caracter cronic sau nu interferează cu procesul de recuperare. Răspunsul terapeutic pentru condițiile bio-medicale poate fi oferit în ambulator sub forma urmăririi periodice. Nu este necesar tratamentul în regim spitalicesc pentru aceste condiții, înaintea sau în timpul procesului de recuperare.

Criterii:

1. absența antecedentelor medicale sau condiții bio-medicale stabilizate;
2. starea de sănătate nu este grav afectată de consum;
3. existența unor condiții bio-medicale, dar acestea pot fi vindecate sau nu interferează cu procesul de recuperare;

4. există condiții medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică.

**ARIA 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații
Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme**

Condițiile psihologice sau psihiatrice și complicații în legătură sau asociate consumului pot fi absente sau sunt medii și pot fi abordabile în acest program, în timpul și după dezintoxicare în regim ambulatoriu sau spitalicesc (*condiție caracteristică*). Acceptarea tratamentului, ca și potențialul de recădere pot fi sau nu prezente. Potențialul de continuare a consumului este minim sau redus (*condiție caracteristică*). Răspunsul terapeutic se poate desfășura în sistem ambulator sau rezidențial în funcție de severitatea condițiilor depistate.

Criterii:

Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații:

1. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 2 în timpul dezintoxicării;
2. există condiții psihologice care necesită monitorizare atentă în regim închis după dezintoxicare;
3. condiții psihologice instabile, care necesită monitorizare structurată dar nu influențează dezintoxicarea;
4. risc absent sau redus pentru sine sau alții;
5. există tulburări emoționale și/sau cognitive care nu interferează cu procesul de recuperare;
6. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații.

Acceptarea/rezistența la tratament:

7. conștientizarea problemei și dorință de angajare în tratament;
8. potențial de creștere a motivației dacă sunt oferite intervenții suplimentare;
9. istoric de non-complianță la dezintoxicare ambulatorie și necesită asistență în regim închis;

Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:

10. risc redus – mediu de recădere; potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis;
11. necesită asistență pentru prevenirea recăderilor.

ARIA 4: Condiții sociale și familiale

Condițiile sociale și familiale în legătură sau asociate consumului pot fi favorabile recuperării și nu interferează cu procesul de recuperare sau interferează, dar într-o măsură medie, manageriabilă pentru acest program. Răspunsul terapeutic se va sprijini pe mediul suportiv existent, sau va urmări creșterea capacității de coping sau considera necesitatea sprijinului sistematic prin acordarea asistenței în regim închis, în funcție de intensitatea condițiilor depistate. De asemenea, acolo unde este cazul, sunt necesare măsuri de restabilire a condițiilor necesare reabilitării.

Criterii:

1. mediul în care asistența poate crește abilitățile de a face față dorinței de consum;
2. mediu nesuportiv sau interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis, iar măsurile pot restabili condițiile necesare reabilitării;
3. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare;
4. mediu suportiv care permite administrarea medicației și monitorizarea dezintoxicării în ambulator.

ARIA 5: Situația juridică

Criterii: Aceleași ca la PIT 1

Program integrat de asistență 3 (PIT 3): Program drog 0 cu stabilizare

Descriere: Risc de intoxicație/sevraj de severitate moderată sau risc moderat în aria bio-medicală sau psiho-emoțională, plus risc crescut în orice altă arie

ARIA 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abținere

Istoricul de consum (durata, intensitatea, tipul și numărul drogurilor consumate, modalitatea de administrare; caracteristicile consumului din ultimele două săptămâni) relevă un risc de intoxicație acută sau sevraj de intensitate moderată sau severă. Modalitatea de consum indică necesitatea dezintoxicării în regim ambulator sau spitalicesc după stabilizare, continuată sau nu cu un program de susținere a abținerei cu antagoniști de opiacee (în cazul drogului de consum este heroina) în funcție de condițiile existente în celelalte arii (*criteriu specific*) sau stabilizarea cu agonist înainte

de dezintoxicare (*criteriu specific*). Stabilizarea este necesară, de asemenea, pentru situațiile de policonsum, ce necesită gestionarea consumului pentru drogul principal înaintea propunerii programului drog 0 (*criteriu specific*).

Criterii:

1. istoric mediu sau scurt de consum;
2. monodependență/polidependență ce poate fi stabilizată;
3. istoric de consum de alte droguri/medicamente;
4. perioade de consum compulsiv semnificative;
5. risc de sevraj moderat - sever;
6. semne curente ale sindromului de abstință care necesită medicație și monitorizare după stabilizare;
7. și/sau necesită medicație și monitorizare în regim închis după stabilizare;
8. istoric de consum îndelungat care permite dezintoxicarea după stabilizare.

ARIA 2: Condiții bio-medicale și complicații

Condițiile bio-medicale în legătură sau asociate consumului pot fi absente sau pot fi vindecate. Acestea nu au caracter cronic sau nu interferează cu procesul de recuperare dacă sunt rezolvate înaintea începerii dezintoxicării (*condiție specifică*). Răspunsul terapeutic pentru condițiile bio-medicale implică cel mai adesea stabilizarea unor condiții bio-medicale înaintea dezintoxicării (*condiție specifică*). Acesta poate fi oferit în ambulator sub forma urmăririi periodice sau poate fi necesar tratamentul în regim spitalicesc, înaintea sau în timpul procesului de recuperare.

Criterii:

1. starea de sănătate este grav afectată de consum și necesită stabilizare;
2. existența unor condiții bio-medicale, dar acestea pot fi vindecate/stabilizate înaintea și/sau în timpul procesului de recuperare pentru a nu interfera cu acesta;
3. există condiții medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică;
4. afecțiuni medicale în tratament care poate interfera cu medicația pentru dezintoxicare și necesită consult interdisciplinar;
5. absența condițiilor bio-medicale.

**ARIA 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații
Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme**

Condițiile psihologice sau psihiatrice și complicațiile acestora în legătură sau asociate consumului pot fi medii sau severe, stabile sau instabile, necesitând stabilizare înaintea dezintoxicării (*condiție specifică*). Acestea pot de asemenea lipsi, iar orientarea în acest PIT să fie dată de condiții ale altor arii, ce necesită stabilizare înaintea dezintoxicării. Răspunsul terapeutic se poate desfășura în sistem ambulator sau rezidențial în funcție de severitatea condițiilor depistate prin stabilizare înaintea dezintoxicării (*condiție specifică*). De asemenea atunci când aceste condiții lipsesc sau sunt medii și stabile răspunsul terapeutic se poate desfășura în sistem ambulator sau rezidențial în funcție de severitatea condițiilor depistate (după stabilizarea condițiilor din alte arii), în timpul dezintoxicării și după încheierea acesteia.

Rezistența la tratament, ca și potențialul de recădere pot fi sau nu prezente. Răspunsul terapeutic este adesea complex și începe, cel mai frecvent în acest PIT, înaintea dezintoxicării (stabilizare) *condiție specifică*; se poate desfășura în sistem ambulator sau rezidențial în funcție de severitatea condițiilor depistate. În cazul absenței acestor condiții, răspunsul terapeutic adresat rezistenței la tratament sau/și potențialului de recădere se va desfășura după stabilizarea problemelor depistate în alte arii în timpul dezintoxicării și după încheierea acesteia.

Potențialul de continuare a consumului este redus sau mediu și necesită răspuns terapeutic înaintea dezintoxicării (stabilizare) *condiție specifică*), în timpul și după încheierea acesteia.

Criterii:**Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații:**

1. există tulburări emoționale și/sau cognitive, care interferează cu procesul de recuperare și necesită stabilizare înaintea dezintoxicării
2. există condiții psihologice sau psihiatrice care necesită monitorizare atentă în regim închis înainte de dezintoxicare;
3. condiții psihiatrice sau psihiatrice care necesită stabilizare înaintea dezintoxicării;
4. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 3;
5. există tulburări emoționale și/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare;
6. risc pentru sine sau alții ce necesită stabilizare înaintea dezintoxicării;
7. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații.

Acceptarea/rezistența la tratament:

8. rezistența la tratament, necesită asistență pentru creșterea motivației înainte de intrarea în tratament;
9. grad redus sau absent de conștientizare și/sau motivare; necesită asistență structurată de intensitate medie sau mare pentru intrarea în tratament;
10. istoric de non-complianță și necesită asistență în regim închis
11. conștientizarea problemei și dorința de angajare în tratament

Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:

12. potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis;
13. istoric de recădere la o intensitate mai redusă a intervențiilor;
14. necesită asistență pentru prevenirea recăderilor;
15. risc redus de recădere.

ARIA 4: Condiții sociale și familiale

Condițiile sociale și familiale în legătură sau asociate consumului se caracterizează cel mai adesea prin lipsa unui suport social minim, situație care interferează cu procesul de recuperare (*condiție specifică*). În alte cazuri, acestea pot fi favorabile recuperării, nu interferează cu procesul de recuperare sau interferează, dar într-o măsură medie, manageriabilă pentru acest program, după stabilizarea problemelor depistate în alte arii. Răspunsul terapeutic se va putea sprijini pe mediul suportiv existent după rezolvarea unor condiții sociale de bază (*condiție specifică*). Alteori se va lua în considerare necesitatea sprijinului sistematic prin acordarea asistenței în regim închis, mai ales în condițiile în care după stabilizarea, prin realizarea condițiilor minime, persistă o situație socială lipsită de siguranță minimă (*condiție specifică*); sau se va desfășura în funcție de intensitatea condițiilor depistate. De asemenea, acolo unde este cazul, sunt necesare măsuri de restabilire a condițiilor necesare reabilitării.

Criterii:

1. mediul nu este suportiv, dar asistența poate crește abilitățile de a face față dorinței de consum;
2. mediu nesuportiv sau interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis;
3. necesită suport social minim înaintea intrării în tratament;
4. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare;
5. mediu suportiv care permite administrarea medicației și monitorizarea dezintoxicării în ambulator;

ARIA 5: Situația juridică

Criterii: Aceleași ca la PIT 1.

Program integrat de asistență 4 (PIT 4): Program de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri

Descriere: Risc sever datorat intoxicației/sevrajului sau semnelor/simptomelor bio-medicale sau emoționale/comportamentale

ARIA 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abținere

a. Program substitutiv cu agoniști de opiacee:

Istoricul de consum (durata, intensitatea, tipul și numărul drogurilor consumate, modalitatea de administrare; caracteristicile consumului din ultimele două săptămâni) relevă un risc semnificativ de intoxicație acută sau sevraj sever (*condiție caracteristică*). Modalitatea de consum indică necesitatea includerii într-un program de menținere cu agoniști de opiacee inițiat în regim ambulator sau spitalicesc în funcție de condițiile existente din această arie sau din celelalte arii (*condiție specifică*).

b. Program de schimb de seringi și alte măsuri adresate reducerii riscurilor:

Istoricul de consum (durata, intensitatea, tipul și numărul drogurilor consumate, modalitatea de administrare, caracteristicile consumului din ultimele două săptămâni) și istoricul tratamentelor experimentate releva un potențial risc sever de intoxicație acută sau sevraj (*condiție specifică*) și incapacitate de a renunța la consum (*condiție specifică*). Modalitatea de consum și istoricul tratamentelor experimentate indică necesitatea includerii într-un program de schimb de seringi, în special dacă condițiile existente în celelalte arii impun/implică aceasta.

Criterii:

1. vârstă peste 18 ani;
2. consum de heroină;
3. testare pozitivă pentru heroină sau metadonă;
4. istoric lung de consum, în cantitate mare;
5. polidependență;
6. consumul de opiacee intravenos în ultimul an;
7. risc de sevraj sever;
8. eșecuri repetate în programe drog;
9. perioade semnificative de consum compulsiv;
10. multiple episoade de recădere.

ARIA 2: Condiții bio-medicale și complicații

Condițiile bio-medicale în legătură sau asociate consumului sunt, în cele mai multe cazuri, severe, pot interfera cu procesul de recuperare drog O, necesitând menținerea cu agoniști de opiacee (*condiție specifică*). În alte

situații condițiile bio-medicale pot fi tratate și/sau vindecate în condițiile menținerii cu agoniști de opiacee (*condiție specifică*). Răspunsul terapeutic poate fi oferit în ambulator sub forma urmăririi periodice. Poate fi necesar tratamentul condițiilor bio-medicale, în regim spitalicesc, înaintea sau în timpul procesului de recuperare.

Criterii:

1. starea de sănătate este grav afectată de consum și necesită menținere;
2. existența unor condiții bio-medicale, dar acestea pot fi vindecate înaintea și/sau în timpul procesului de recuperare și nu interferează cu menținerea;
3. există condiții medicale severe în legătură sau nu cu consumul de heroină pentru a căror stabilizare este necesară intrarea într-un program de menținere cu agoniști de opiacee;
4. sarcină apărută la o consumatoare de heroină.

ARIA 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații. Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme

Condițiile psihologice sau psihiatrice și complicațiile acestora în legătură sau asociate consumului necesită, în cele mai multe cazuri, intrarea într-un program de menținere (*condiție specifică*) datorită prezenței comportamentelor antisociale, tulburărilor psihiatrice, condițiilor emoționale sau cognitive decompensate (*condiție caracteristică*). Acestea pot, de asemenea lipsi, iar orientarea în acest PIT să fie dată de condiții ale altor arii, ce necesită menținerea cu agoniști de opiacee. Răspunsul terapeutic se poate desfășura în sistem ambulator sau rezidențial în funcție de severitatea condițiilor depistate.

Conștientizarea problemei este cel mai adesea redusă; rezistență la tratament sau istoric de non-complianță sunt semnificative (*condiție specifică*).

Potențial crescut de recădere sau incapacitatea obținerii abstenenței (*condiție specifică*). Răspunsul terapeutic este adesea complex și se poate desfășura în sistem ambulator sau rezidențial în funcție de severitatea condițiilor depistate, înaintea menținerii în timpul și după încheierea acesteia.

Potențialul de continuare a consumului este crescut sau recăderea a fost experimentată și necesită răspuns terapeutic complex cu menținerea cu agoniști de opiacee, în regim ambulator sau în regim închis (*condiție nespecifică dar care se aplică tuturor pacienților ce vor fi incluși în PIT 4*).

Criterii:**Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații:**

1. există tulburări emoționale și/sau cognitive, care interferează cu procesul de recuperare și necesită menținere cu agoniști;
2. condiții psihiatrice sau psihologice care necesită intrarea într-un program de menținere cu agoniști de opiacee;
3. risc pentru sine sau alții ce necesită menținere cu agoniști;
4. există condiții psihologice sau psihiatrice importante;
5. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate în PIT 4;
6. există tulburări emoționale și/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare;
7. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații;

Acceptarea/rezistența la tratament:

8. rezistența la tratament, necesită asistență pentru creșterea motivației înainte de intrare și în timpul tratamentului;
9. grad redus sau absent de conștientizare și/sau motivare; necesită asistență structurată de intensitate medie sau mare;
10. istoric de non-complianță ce necesită asistență în regim închis;
11. conștientizarea problemei și dorința de angajare în tratament de menținere;

Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:

12. risc crescut de recădere;
13. potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis;
14. istoric de recădere la o intensitate mai mică a intervențiilor;
15. risc crescut de recădere;
16. potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis.

ARIA 4: Condiții sociale și familiale

Condițiile sociale și familiale în legătură sau asociate consumului se caracterizează cel mai adesea marginalizare, izolare, lipsa resurselor materiale, sociale, profesionale sau educaționale, situații care interferează cu procesul de recuperare (*condiție caracteristică*). În alte cazuri, acestea pot fi favorabile recuperării, nu interferează cu procesul de recuperare sau interferează, dar într-o măsură medie, manageriabilă pentru acest program. Răspunsul terapeutic va considera necesitatea sprijinului sistematic prin acordarea asistenței în regim închis sau măsuri psiho-sociale intensive și,

acolo unde este cazul, rapid disponibile. Ori de câte ori este posibil, se va sprijini pe elementele suportive ale mediului existent, sau va urmări creșterea capacității de coping, în funcție de intensitatea condițiilor depistate. De asemenea, acolo unde este cazul, sunt necesare măsuri de restabilire a condițiilor necesare reabilitării.

1. mediu nesuportiv sau interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis;
2. necesită suport social;
3. mediul nu este suportiv, dar asistența poate crește abilitățile de a face față dorinței de consum;
4. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare;
5. mediu suportiv care permite administrarea medicației și monitorizarea menținerii în ambulator;

ARIA 5: Situația juridică

Criterii: Aceleași ca la PIT 1.

CRITERII DE MENȚINERE SAU IEȘIRE DINTR-UN PROGRAM INTEGRAT DE ASISTENȚĂ

Luarea deciziilor în privința duratei asistenței într-un serviciu sau program și a factorilor care trebuie luați în considerare în trimiterea sau ieșirea pacienților reprezintă o dilemă frecventă.

Asistența dependenței de droguri este dezvoltată și aplicată ținând cont de problemele depistate cu ocazia procesului de evaluare, și continuă sau se întrerupe, în funcție de caz, în funcție de rezultatele obținute. În general discutând, în cazul în care problemele inițiale persistă sau apar altele noi, procesul de asistență continuă. Iar dacă acestea dispar, se soluționează conduce la terminarea asistenței. În mod specific, pentru sprijinirea acestor decizii se va urmări gradul de atingere a obiectivelor generale și a celor operaționale prin implementarea măsurilor de asistență propuse. Următoarele linii directoare vor fi utile în luarea acestor decizii:

Pacientul va rămâne la programul asistență actual dacă:

1. A făcut progrese semnificative dar nu a atins toate scopurile stabilite în planul individual de tratament; sau nu a făcut progrese dar prezintă potențial să progreseze.
2. Au apărut noi probleme care pot fi tratate în mod eficient la programul curent.

Pacientul va fi exclus sau transferat din programul de asistență actual dacă:

1. Problemele care au determinat includerea pacientului au fost rezolvate (excludere bazată pe îndeplinirea obiectivelor).
2. Problemele nu au fost rezolvate, în ciuda eforturilor făcute, datorită incapacității pacientului sau lipsa de resurse suficiente la programul curent de asistență (trimitere bazată pe lipsa de progres).
3. Problemele s-au intensificat sau au apărut noi probleme care nu pot fi tratate suficient cu resursele disponibile la programul curent de asistență (trimitere bazată pe regres).

CIRCUMSTANȚE ÎN CARE NU SE APLICĂ CRITERIILE DE PLASARE A PACIENȚILOR

Majoritatea circumstanțelor permit orientarea pacientului într-un program dat, dar acesta nu este posibil în mod indefinit. Trebuie luate în considerare situații în care aplicarea rigidă a criteriilor face dificilă abordarea nevoilor specifice ale pacientului. Iată câteva exemple:

- atunci când criteriile indică un anumit program în care parte importantă a serviciilor nu este disponibilă
- atunci când continuitatea în cadrul unui program sau plan a eșuat și este necesară reevaluarea și trecerea într-un alt program
- atunci când exercitarea activității profesionale sau a funcționării unui centru este legal restricționată.

🔗 **PUNCTE CHEIE**

- o Criteriile de orientare sunt un instrument elaborat pe baza aspectelor considerate în ariile de evaluare și care are ca scop selecția simplificată a unui program integrat de asistență (PIT)
 - o Criteriile specifice și cele caracteristice sunt elementele definitorii în selectarea unui PIT.
 - o Criteriile enumerate pe arii se pot regăsi în selecția unuia sau mai multor PIT-uri, dat fiind caracterul complex al tulburării adictive, dar și necesității păstrării unui grad de flexibilitate.
 - o Deși definitorii, criteriile specifice pot păstra acest caracter doar într-o fază inițială a planificării, pentru ca ulterior să devină semnificative criterii mai puțin selective, dar mult mai semnificative pentru progresul fiecărui caz.
 - o Criteriile rezultate din aria socială și juridică pot avea o importanță cel puțin egală cu cele ale istoricului de consum sau cele medicale în selecția PIT și stabilirea planului individualizat, dat fiind caracterul mandatoriu, sau personalizat al acestora.
-

IV. PROGRAME INTEGRATE DE ASISTENȚĂ (PIT)

INTRODUCERE

Programele integrate de asistență implică un set comprehensiv de programe terapeutice, psihologice și sociale, complementare, simultane sau secvențiale, care se concretizează într-un plan individualizat de asistență.

Programele integrate de asistență (PIT) structurează modalitatea de acordare a serviciilor într-o manieră integrată și continuă. Caracterul integrat rezultă din corelarea abordării longitudinale cu cea încrucișată și va lua forma unui set de intervenții complementare, simultane sau secvențiale - care reflectă diversitatea necesară adecvării la diferitele fațete și nevoi asociate tulburărilor datorate consumului de droguri. Ca parte a acestei abordări, programele de asistență și serviciile nu sunt integrate numai între ele, dar și cu rețeaua generală de servicii de asistență, primară și de specialitate.

Continuumul asistenței se referă atât la acoperirea tuturor fazelor tulburării adictive, cât și la disponibilitatea unui spectru larg al opțiunilor terapeutice aplicate în concordanță cu nevoile individuale, din momentul evaluării, dar și a celor depistate pe parcurs, în scopul obținerii celor mai bune rezultate.

În mod practic, pe baza rezultatelor evaluării și aplicării criteriilor de orientare este posibilă selectarea unuia din cele patru PIT, ca fiind cel mai adecvat problematicii depistate. În cadrul unui PIT, modalitățile de asistență selectate pot corespunde unuia sau mai multor niveluri de intervenție, în funcție de complexitatea, dificultatea, severitatea, necesitatea intervenției imediate - aspecte identificate în urma evaluării. Pe de altă parte, secvențialitatea intervențiilor va fi asigurată urmărind nu numai parcursul evoluției adictive, dar și o ierarhizare a problematicii care permite dezvoltarea abordărilor succesive, cu caracter continuu.

Dezvoltarea PIT a urmărit, pe lângă garantarea continuumului și caracterului integrat al abordărilor terapeutice, severitatea adicției dar și al existenței și severității problematicii bio-medicale, psihologice, sociale sau juridice potențial existente în rândul populației consumatoare de droguri. Menționăm aceasta deoarece aparent, PIT-urile sunt organizate în funcție de severitatea adicției, care de fapt, nu este în mod necesar într-o corelație directă cu restul problematicii bio-psiho-sociale a consumatorilor de droguri.

Desigur, scopurile generale ale fiecărui PIT pot fi separate în condiționările esențiale ale fenomenului adictiv: obținerea și menținerea abstenenței sau evitarea/reducerea riscurilor asociate consumului, fie de menținere, schimb de seringi și alte intervenții destinate acestui scop. Stabilirea scopului general și a obiectivelor specifice fiecărui PIT se constituie în urma coroborării rezultatelor multidimensionale ale evaluării.

AVANTAJE ȘI LIMITĂRI ALE DEZVOLTĂRII PIT

Avantajul esențial al dezvoltării PIT constă în garantarea caracterului integral și continuu al asistenței acordate consumatorilor de droguri.

Pe lângă acesta, abordarea individualizată, posibilă în urma evaluării și aplicabilă prin intermediul planului individualizat de asistență permit prin abordărilor ce urmează a fi oferite în cadru acestuia obținerea eficienței prin atingerea rezultatelor așteptate.

Desigur, individualizarea și răspunsul în timp alocat, adecvat la nevoile depistate este o sursă semnificativă pentru planificarea și managementul serviciilor terapeutice, cu posibilitatea planificării eficace a resurselor financiare disponibile. Particularizarea intervențiilor, astfel încât, acestea să se adecveze nevoilor pacienților probabil va determina o percepere mult mai „prietenoasă” atât pentru consumatori, cât și pentru familiile acestora.

Dezvoltarea PIT permite o structuralizare a sistemului de servicii într-o bază umanistă, îndreptată spre individ și nevoile acestuia, fără a neglija însă aspectele profesionale sau manageriale. Prin comparație, abordarea clasică, dezintoxicare și postcură devine simplistă față de complexitatea problematicei consumului de droguri și adesea, inadecvată nevoilor pacienților. Din aceste motive, alocarea ineficace a resurselor financiare și a celor profesionale, dar și cele mai recente date cu privire la abordarea terapeutică a consumatorilor de droguri a condus la reglementarea abordării integrate, comprehensive. Asemănător, abordarea longitudinală pe niveluri de intervenție oferă o perspectivă mai degrabă din partea sistemului și mai puțin a individualității consumatorilor. Aceasta poate într-adevăr să determine o alocare mai eficace a resurselor, cel puțin pentru moment, dar limitează într-o măsură semnificativă individualizarea și integrarea asistenței.

Limitările în dezvoltarea PIT constau în structurarea aparentă (dar nu este în mod necesar și o realitate) în funcție de severitatea adicției, ceea ce ar semnifica în consecință, menținerea unui grad excesiv de medicalizare a asistenței adresate consumatorilor. Stabilirea imediat succesivă a planului individualizat de asistență înlătură această perspectivă și asigură abordarea comprehensivă.

O alta limitare este dată de caracterul complex al abordării terapeutice și de asistență a consumatorilor de droguri. Înțelegem prin aceasta că pentru

selectarea unui PIT este absolut necesară evaluarea complexă, multidisciplinară. Este astfel, necesară dezvoltarea unei rețele de instituții și profesioniști care să răspundă acestei provocări. Aceasta implică dezvoltarea unui cadru relațional bazat pe legături formale – contracte și convenții de parteneriat - dar și informale, aplicabile ori de câte ori se dovedește necesar și alocarea resurselor financiare care să permită funcționarea eficace a acestei rețele. De asemenea, pregătirea specifică pentru realizarea managementului de caz este absolut necesară pentru ca, alături de stabilirea instrumentelor de lucru, să permită orientarea, pregătirea profesională în scopul abordării cât mai potrivite a fiecărui caz.

TIPURI DE PROGRAME INTEGRATE DE ASISTENȚĂ

Pentru fiecare din cele patru PIT au fost stabilite scopul acestuia, regăsit în denumirea programului, obiectivele specifice fiecăruia, listate în sensul atingerii scopului, dar și al rezultatului final așteptat în urma aplicării intervențiilor și anume, reabilitarea și reinserția socială. De asemenea, suplimentar, pentru simplificarea selecției sunt precizate tipurile de servicii ce pot fi oferite exclusiv sau nu într-un PIT, în totalitate sau în parte, în funcție de evaluare și implementate prin intermediul planului individualizat.

Program integrat de asistență 1: Program drog 0 de intensitate mică

- **Descriere:** acest tip de program este un program drog 0 în cadrul căruia pot fi necesare măsuri terapeutice adresate întreruperii consumului de droguri, dar acestea sunt minime, constând din intervenții psiho-sociale destinate menținerii abstinentei și reintegrării sociale și, acolo unde este cazul, de susținere a abstinentei cu antagoniști de opiacee.
- **Mijloace:** mijloace medicamentoase pentru dobândirea și menținerea abstinentei, consiliere, psihoterapie, informare, educare
- **Intensitate:** intensitatea intervențiilor este cel mai adesea minimă, dar, în funcție de riscurile depistate în ariile de evaluare, unele intervenții pot avea caracter intensiv, în regim închis
- **Caracteristici: Risc minim în toate ariile:** riscul de sevraj/intoxicație, cel al complicațiilor bio-medicale, psihologice și comportamentale este absent, complianță pentru schimbare, capacitate de menținere a abstinentei, mediul de recuperare suportiv.

Obiective:

1. Dobândirea și/sau menținerea abstinentei
2. Îmbunătățirea integrării familiale, sociale și profesionale
3. Ameliorarea problemelor psiho-emoționale și de comportament și optimizarea dezvoltării personale
4. Dezvoltarea sau redobândirea abilităților sociale

5. Stimularea includerii în activități profesionale, sportive, culturale

Servicii:

1. Servicii medicale de bază și specializate; vaccinare;
2. Susținerea abstinentei cu antagoniști de opiacee;
3. Servicii de consiliere psihologică și/sau psihoterapie în scopul dezvoltării motivației, scăderii rezistenței la tratament sau creșterii acceptării acestuia;
4. Servicii de consiliere psihologică pre și post testare HIV, hepatite B și C;
5. Testarea prezenței drogurilor;
6. Servicii de consiliere psihologică și/sau psihoterapie în scopul ameliorării problemelor psiho-emoționale și de comportament și optimizării dezvoltării personale;
7. Servicii de asistență socială;
8. Consiliere juridică;
9. Activități de informare, consiliere educațională și vocațională, în scopul creșterii autonomiei și valorii sociale individuale, a dezvoltării responsabilității și recâștigării abilităților sociale;
10. Educare-formare pentru achiziționarea unor norme de coabitare, formare profesională: îmbogățirea cunoștințelor, obiceiurilor și tehnicilor profesionale;
11. Consiliere pentru dezvoltarea abilităților de căutare și obținere a unui loc de muncă;
12. Educare și formare pentru obținerea unui nivel educativ, cultural și relațional suficient pentru a conștientiza și participa la viața socială și a accesa servicii de sprijin comunitar.

Program integrat de asistență 2: drog 0

- **Descriere:** acest tip de program este un program drog 0 în cadrul căruia, sunt necesare măsuri terapeutice adresate întreruperii consumului, dezintoxicării și menținerii abstinentei la care se asociază intervenții psiho-sociale destinate menținerii abstinentei și reintegrării sociale.
- **Mijloace:** mijloace medicamentoase pentru dobândirea și menținerea abstinentei, consiliere, psihoterapie, informare, educare.
- **Intensitate:** intensitatea intervențiilor este adesea minimă, dar, în funcție de riscurile depistate în ariile de evaluare unele intervenții pot avea caracter intensiv, în regim închis.
- **Caracteristici:** **Risc minim de intoxicație acută severă, sindrom de abstinență abordabil medical imediat și risc minim în aria bio-medicală dar cu risc moderat în orice altă arie:** riscul de sevraj/intoxicație este minim, complicații bio-medicale gestionabile, complicații psihologice și comportamentale de severitate medie, pregătirea pentru schimbare: cooperare, dar necesită structurare, potențial de recădere redus sau moderat, necesită monitorizare,

mediul de recuperare mai puțin suportiv, structurarea va crește capacitatea de coping.

Obiective:

1. Întreruperea consumului de droguri sub control medical și menținerea abstenenței.
2. Îmbunătățirea integrării familiale, sociale și profesionale.
3. Ameliorarea problemelor psiho-emoționale și de comportament și optimizarea dezvoltării personale.
4. Dezvoltarea sau redobândirea abilităților sociale.
5. Stimularea includerii în activități profesionale, sportive, culturale.

Servicii:

1. În plus față de serviciile oferite în PIT 1 pot fi oferite următoarele:

- dezintoxicare substitutivă sau non-substitutivă, în ambulator sau în regim spitalicesc.

Program integrat de asistență 3: Program drog 0 cu stabilizare

- **Descriere:** acest tip de program este un program drog 0 în cadrul căruia măsurile adresate stabilizării medicale, psihologice sau sociale preced pe cele adresate direct întreruperii consumului, la care se asociază intervenții psiho-sociale destinate menținerii abstenenței și reintegrării sociale.
- **Mijloace:** medicamentele pentru stabilizarea condițiilor medicale asociate consumului, asistența socială, juridică pentru stabilizarea condițiilor psihologice și/sau sociale, mijloace medicamentele pentru dobândirea și menținerea abstenenței, consiliere, psihoterapie informare, educare, formare, asistență socială în vederea reabilitării.
- **Intensitate:** intensitatea intervențiilor este rareori minimă, și în funcție de riscurile depistate în ariile de evaluare unele intervenții pot avea caracter mediu și intensiv, în regim închis.

Caracteristici: Risc mediu – crescut de intoxicație acută severă, sindrom de abstenență de severitate moderată/crescută neabordabil medical imediat sau risc moderat în aria bio-medicală sau psiho-emoțională plus risc crescut în orice altă arie: risc moderat - crescut de intoxicație acută sau sevraj de severitate moderată/crescută, pentru a căror abordare medicală este necesară stabilizarea, condiții bio-medicale care necesită monitorizare sau adresare în vederea stabilizării, risc psihologic, comportamental moderat, rezistență la schimbare, necesită intervenții intensive, potențial de recădere crescut, incapacitate sau capacitate redusă de a controla consumul, mediul de recuperare: deficitar/non-suportiv, periculos pentru recuperare, incapacitate de reintegrare.

Obiective:

1. Pregătirea pentru abstință. Stabilizare bio-medicală, psihologică, socială, juridică în vederea obținerii abstenței
2. Crearea condițiilor de bază pentru îmbunătățirea calității vieții.
3. Întreruperea consumului de droguri sub control medical și menținerea abstenței.
4. Îmbunătățirea integrării familiale, sociale și profesionale
5. Stimularea includerii în activități profesionale, sportive, culturale

Servicii:

În plus față de serviciile oferite în PIT 1 pot fi oferite următoarele:

1. Servicii medicale specializate pentru afecțiuni coexistente și/sau cauzate de consum și care necesită o intervenție imediată
2. Servicii psihologice sau psihiatrice specializate pentru afecțiuni coexistente și/sau cauzate de consum și care necesită o intervenție imediată
3. Servicii sociale și juridice specializate pentru condiții coexistente și/sau cauzate de consum și care necesită o intervenție imediată.

Program integrat de asistență 4: Program de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri

- **Descriere:** acest tip de program urmărește reducerea impactului și consecințelor consumului de droguri prin menținerea cu agoniști de opiacee – în cazul programelor substitutive cu agoniști de opiacee - sau intervențiilor minime sau a celor în criză – în cazul programelor de schimb de seringi și/sau alte măsuri adresate reducerii riscurilor, acolo unde este cazul, la care se asociază intervenții psiho-sociale destinate reducerii consumului, schimbării căii de administrare sau a drogului consumat sau întreruperii consumului și menținerii abstenței dar și reabilitării și reintegrării sociale
- **Mijloace:** medicamentoase pentru substituție sau asigurarea intervențiilor medicale de bază sau în criză, măsuri specifice de reducere a riscurilor vitale sau de comorbiditate, consiliere, psihoterapie, informare, educare, asistență socială și juridică.
- **Intensitate:** intensitatea intervențiilor este cel mai adesea minimă, și în funcție de riscurile depistate în ariile de evaluare unele intervenții pot avea caracter mediu și intensiv.
- **Caracteristici:** **Risc sever datorat intoxicației/sevrajului sau semnelor/simptomelor bio-medicale sau emoționale/comportamentale:** risc de sevraj sever, condiții bio-medicale care pot necesita monitorizare medicală sau asistență intensivă în regim închis, complicații psihologice sau comportamentale severe

a. Program substitutiv cu agoniști de opiacee:

Obiective:

4. Înlocuirea drogului consumat cu un substitut opiaceu controlat medical.
5. Îmbunătățirea calității vieții.
6. Îmbunătățirea integrării familiale, sociale și profesionale.
7. Reducerea riscului de infectare cu HIV, hepatită B și C, tuberculoză, BTS-uri etc.
8. Reducerea consumului de alte substanțe

Servicii:

În plus față de serviciile oferite în PIT 1 pot fi oferite următoarele:

1. Prescriere și eliberare de metadonă,
2. Servicii de consiliere psihologică în scopul practicării sexului protejat și a unui consum fără risc

Cu excepția pct.2 – Sustinere a abstinentei cu antagoniști de opiacee

b. Program de schimb de seringi și/sau alte măsuri adresate reducerii riscurilor

Obiective:

1. Intrarea în contact și atragerea populației din afara rețelei de tratament.
2. Asigurarea vigilenței epidemiologice; reducerea incidenței infecțiilor cu transmitere pe cale sanguină sau sexuală (HIV, hepatite B și C, BTS, tuberculoză).
3. Reducerea impactului și consecințelor negative rezultate în urma consumului.
4. Diminuarea conflictualității sociale și a incidentelor judiciare
5. Facilitarea practicilor de injectare sigure.
6. Facilitarea schimbării căii de administrare în sensul scăderii riscului de transmitere a infecțiilor pe cale sanguină.
7. Facilitarea stabilizării și/sau creșterea motivației pentru schimbare în scopul inițierii unui tratament adecvat.

Servicii:

În plus față de serviciile oferite în PIT 4 pot fi oferite următoarele:

1. Oferirea de material steril de injectare și schimbul de seringi.
2. Oferirea de prezervative.
3. Intervenții în criză, asistență medicală, psihologică și socială de bază, vaccinări.

4. Depistarea patologiilor asociate și facilitarea trimiterii către servicii specializate.
5. Informare și/sau servicii de consiliere psihologică în scopul practicării sexului protejat, a unui consum fără risc.
6. Activități de informare cu privire la serviciile de asistență medicală, psihologică și socială existente.
7. Acoperirea necesităților de bază: alimentație, igienă, odihnă, îmbrăcăminte.

PUNCTE CHEIE

- o Programele integrate de asistență permit o abordare umanistă (bazată prioritar pe necesitățile pacienților depistate în ariile de evaluare) integrată, bazată pe principiile diversității, disponibilității, continuității, complementarității medicale, psihologice și sociale.
 - o În aplicarea programelor integrate de asistență se urmăresc obiectivele esențiale ale asistenței consumatorilor de droguri: întreruperea consumului și/sau reducerea efectelor acestuia, prevenirea sau reducerea frecvenței și intensității recăderilor, dezvoltarea capacității psihologice și sociale necesare refacerii funcționării personale și sociale.
 - o Nici un program de asistență nu este cel mai bun, ci există programe adecvate nevoilor depistate.
 - o Chiar dacă fiecare program integrat implică folosirea întregii palete de resurse de asistență, acestea nu vor fi toate potrivite la toți pacienții.
 - o Definirea fiecărui program prin descriere, mijloace, intensitate, caracteristici, obiective și servicii are caracter orientativ în selecția PIT și nu ține locul aplicării criteriilor de orientare.
-

V. PLANUL INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ (PIA)

Planul individualizat de asistență reprezintă componentele funcționale, intervențiile terapeutice, psihologice și sociale individualizate din cadrul unui PIT, pe două componente:

- terapeutică
- psiho-socială

În stabilirea unui plan individualizat de asistență, rezultatele obținute prin intermediul evaluării, vor fi utilizate nu numai în stabilirea tipurilor de servicii adecvate necesităților, dar și în stabilirea modalității de asistență:

1. Asistența intensivă de urgență/imediată, în situațiile în care există un potențial pericol iminent pentru pacient sau pentru alte persoane;
2. Asistența ambulatorie, acolo unde nu există un pericol potențial;
3. Orientare și stabilizare în așteptarea intrării într-un serviciu formal de asistență.

Vor fi realizate, de asemenea, alegerea celei mai adecvate structuri, determinarea necesității de utilizare a resurselor de sprijin și determinarea tehnicilor specifice de intervenție.

Acest plan va trebui să reprezinte o balanță între nevoile depistate în ariile de evaluare (riscurile potențiale) și serviciile existente și disponibile.

Motivele indicării unui anumit plan de tratament și asistență, ca și ale pacientului de a accepta aceste modalități, variază foarte mult. Iată câteva exemple:

- capacitatea pacientului de a participa și coopera
- resursele (medicale, psihologice și sociale) care pot permite pacientului să beneficieze de pe urma tratamentului
- gradul de structurare și sprijin extern necesar
- capacitatea pacientului de a întrerupe consumul de droguri și dorința sa de a adopta un comportament care să susțină abținerea
- necesitatea unui tip particular de intervenție, disponibil numai în anumite centre de asistență.

Caracteristici/aspecte considerate în elaborarea unui PIA	
Caracteristici ale pacientului Vârstă, sex, etnie, particularități culturale Severitatea și istoria tulburării adictive, experiența asistenței primite anterior Potențial de recădere Nevoia de tratament medical sau al adicției sau de servicii farmacologice, psihiatrice, familiale sau sociale, angajare sau asistență juridică Atitudinea față de intrarea și menținerea în program/plan Efectele mediului de viață și influențele sociale: de ex. condiții de trai, sprijin familial, susceptibilitatea la influențe, abuz sau neglijare	Caracteristici ale serviciului – intensitatea intervențiilor Intensitatea serviciului Disponibilitatea serviciilor medicale, psihologice și sociale Variatatea disciplinelor profesionale implicate Disponibilitatea serviciilor față de specificitatea individuală sau dizabilitățile acestuia Componentele/ Activitățile programului Planificarea duratei diferitelor intervenții Gradul de încărcare al serviciului/profesiionistilor

În mod ideal, pacientul va trebui tratat în modul cel mai puțin restrictiv, cel mai sigur, cel mai eficient, beneficiind de o flexibilitate care să permită trecerea atunci când este necesar într-un alt program integrat de asistență sau într-un alt nivel de asistență.

Planul de asistență reprezintă un instrument de ghidare, un „traseu” stabilit de echipa profesională, adecvat în măsura posibilului la nevoile pacientului exprimate sau depistate prin evaluare, ca și la resursele disponibile. Această abordare reprezintă un efort de a obține un echilibru între cererea exprimată și oferta de servicii.

La finalizarea evaluării, consumatorul este informat despre structurile programului integrat de asistență, despre condițiile de asistență și reabilitare proprii fiecărui serviciu sau centru medical la care poate fi trimis, în scopul ajutării pacientului în luarea unei decizii informate privitoare la participarea sa activă la procesul de reintegrare socială.

Planul individualizat de asistență cuprinde, în principal:

- Date generale despre solicitant
- Prezentarea problemelor depistate pe arii și prioritizarea acestora
- Puncte tari/puncte slabe

- Scop
- Obiective și data la care se așteaptă să fie atinse
- Metode/intervenții și programarea serviciilor medicale, psihologice și sociale, personalul responsabil, precum și procedurile și protocoalele de acordare.

În definirea unui plan, problemele identificate sunt enumerate și prioritizate; este făcut un inventar al surselor și potențialului de sprijin extern al pacientului, ca și a măsurii în care acesta este pregătit pentru recuperare. Planul de asistență cuprinde scopul și obiectivele specifice, rezultatele așteptate și modalitățile de atingere a acestora, într-un cadru temporal și spațial dat, astfel încât, observarea progreselor ca și ajustările necesare să permită obținerea celor mai bune rezultate posibile.

Listarea punctelor tari și a celor slabe, deși poate apărea ca o formalitate în plus, se constituie într-un instrument util în managementul de caz, în sensul monitorizării eficiente; acestea pot sprijini echipa multidisciplinară în corelarea intervențiilor profesioniste planificate. Acestea pot fi eficiente în prevenirea conjuncturilor ce creează dificultăți sau în intervenția promptă acolo unde este cazul, dar și utilizarea tuturor modalităților de suport pentru a putea atinge rezultatele așteptate. Astfel, pot fi prevenite sau atunci când totuși se întâmplă, pot fi depășite situațiile de criza sau recăderile, fie că acestea sunt generate de condiții externe, din cadrul programului integrat (tranziții, excluderi premature sau disciplinare, inadecvarea, golurile dintre aplicarea diferitelor intervenții planificate, altele), sau al vieții curente (probleme ale familiei, locuinței, surselor de venit) sau interne (situații de facilitare sau reapariție a nevoii de consum, stare psiho-emoțională instabilă).

Punctele tari depistate cu ocazia definirii planului individualizat de asistență vor putea fi utilizate în intervențiile managerului de caz către un serviciu și în interacțiunile sale cu pacientul în sensul întăririi progresului în tratament, al facilitării schimbării, al implicării în măsurile de reabilitare și reintegrare în comunitate. De asemenea, elementele enumerate la listarea punctelor tari pot fi folosite de managerul de caz pentru a sprijini pacientul în depășirea situațiilor de criză sau recădere descrise mai sus, prin adăugarea unor elemente de intervenție suplimentară sau complementare. Acestea pot fi readuse în discuțiile cu pacientul în ședințele programate urmare a sesizării unor situații cu potențial de recădere sau criză, absența de la programări, pierderea interesului, altele, în scopul reafirmării potențialului pacientului sau al mediului de sprijin.

Punctele slabe depistate se pot constitui pe măsura monitorizării progresului pacientului în cadrul PIA în tot atâtea surse de cunoaștere, previzionare și răspuns la situațiile care pot determina întreruperea prematură a asistenței. Unele din acestea vor necesita rezolvare chiar în etapa de pretratament, ne referim aici la necesitățile bazale care pot oblitera dorința, motivația sau potențialul pacientului de a se angaja în PIT. Altele nu au potențial imediat de a influența negativ intrarea sau menținerea în

tratament, dar care trebuie considerate ori de câte ori obiectivele mici operaționale/acțiunile nu par să poată fi atinse. Discuțiile cu pacientul asupra punctelor slabe în perioada de pretratament, sau atunci când apare necesar în urma observațiilor din procesul de monitorizare, pot fi, dacă sunt corect utilizate, resurse de prevenire sau evitare a dificultăților îndeplinirii obiectivelor PIA, prin creșterea conștientizării și eventual a motivației pentru schimbare.

Obiectivele sunt urmărite și listate în funcție de problemele depistate în ariile de evaluare și sunt completate în definirea PIA pe măsura ce pe una din arii a fost depistată una sau mai multe probleme. Stabilirea obiectivelor în cadrul planului este, de asemenea, un instrument util atât pentru pacient – cunoașterea acestora facilitează participarea activă a acestuia la procesul terapeutic, cât și pentru echipa multidisciplinară – desfășurarea planificată, integrată și colaborativă a intervențiilor, a succesiunii și/sau concomitenței acestora.

Ca și în alte demersuri planificate, obiectivele trebuie să fie realiste, pragmatice și posibil a fi îndeplinite. Acesta este o condiție esențială pentru obținerea eficacității abordării terapeutice. Supradimensionarea acestora, fie ca număr, fie ca potențial de realizare poate fi o sursă de creștere a presiunii asupra pacientului, în sensul atingerii obiectivelor propuse, sau de scădere a încrederii acestuia în propriul potențial sau în cel al mediului de sprijin și asistență urmare a dificultăților, uneori chiar insurmontabile (rezultatul lipsei de realism). De asemenea, acestea pot da pacientului perspectiva lipsei unei finalități sau stabilități a eforturilor sale pentru schimbare. Obiectivele supradimensionate pot fi rezultatul unui entuziasm excesiv față de rezultatele sau eforturile ce trebuie implicate în procesul terapeutic, dar și a dorinței pacientului de a intra mai rapid în circuitul de asistență; pot fi de asemenea, rezultatul unei evaluări ineficace sau incomplete, urmare a limitărilor de timp, a oportunităților de asistență ce nu se dorește a fi pierdute sau a impunerilor generate de oricare din sistemele implicate în consumul de droguri. O altă cauză, în legătură cu echipa de evaluare și management de caz este evaluarea nerealistă a resurselor de asistență și a disponibilității acestora.

Stabilirea unor obiective subdimensionate, față de realitatea depistată, poate fi în aceeași măsură o sursă de scădere a încrederii pacientului în propriul potențial, cel al mediului de sprijin sau de asistență, prin menținerea unor așteptări neîndeplinite, lipsa valorizării sau lipsa unui suport pe măsura nevoilor depistate.

Gradul de pragmatism se referă la aplicabilitatea obiectivelor listate. Astfel, lipsa unor structuri de asistență sau indisponibilitatea acestora, ca și dificultatea (neluata în considerare) de accesare, sunt tot atâtea surse de neîmplinire a așteptărilor pacientului. Managerul de caz, în definirea împreună cu pacientul a planului individualizat pentru îndeplinirea pragmatismului necesar, trebuie să găsească soluții de înlocuire, intercalare, creștere a accesului la serviciile existente. Fără discuție,

aplicabilitatea se referă și la resursele și potențialul actual, dar și al celui de pe parcursul derulării planului, de a face față tranzițiilor sau de a participa la etapele și intervențiile motivaționale, educative sau formative. O altă sursă o reprezintă lipsa de acuratețe a evaluării.

Definirea obiectivelor trebuie să fie în aceeași măsură astfel realizată încât să permită monitorizarea, cu măsurarea periodică a progresului pacienților, fie prin indicatori de rezultat (încheierea unei cure de dezintoxicare) sau de impact (urmare a dezvoltării abilității de căutare a unui loc de muncă, pacientul s-a angajat și își menține serviciul).

Încadrarea în timpul alocat desfășurării intervențiilor menite să asigure atingerea obiectivelor propuse este în aceeași măsură și o resursă de realism pentru atingerea obiectivelor, dar și o sursă de informare și conștientizare a intervalului în care se poate aștepta obținerea unor rezultate: renunțarea la consum, construirea abilităților individuale de coping, dezvoltarea abilităților de relaționare, reintegrare și reabilitare socială.

Sintetizând, dezvoltarea unor obiective adecvate în cadrul planului individualizat se constituie într-un element esențial pentru dimensionarea eforturilor pacientului de asistență, motivarea angajării și menținerii pacientului în program, antrenarea și utilizarea suportului existent, monitorizarea și evaluarea progresului și rezultatelor planului individualizat și a serviciilor oferite.

Partea finală în dezvoltarea planului individual este stabilirea și planificarea intervențiilor terapeutice, în funcție de numărul, complexitatea și amploarea problemelor depistate în cadrul evaluării și a căror soluționare a fost stabilită prin intermediul obiectivelor enumerate pe cele cinci arii. De asemenea, aici este locul unde se va realiza o ierarhizare în scopul prioritizării intervențiilor ce urmează a fi desfășurate în faza de pretratament și în cadrul PIT în continuumul de asistență. De multe ori va fi necesar să se răspundă problemelor prioritare de bază, înaintea intrării în continuumul de asistență. Tot în această etapă poate fi necesară planificarea altor măsuri necesare stabilizării, urmare a existenței unor afecțiuni medicale, psihologice/psihiatrice sau sociale, care pot împiedica tratamentul adicției sau pot interfera sau întârzia obținerea unor rezultate ale asistenței. În planificarea intervențiilor vor fi urmărite o serie de coordonate care să asigure complementaritatea, continuitatea, consecvența și intensitatea necesare dezvoltării unor intervenții integrate și comprehensive, adaptate etapei de evoluție/progres prevăzute în urma evaluării pe cele cinci arii și discuțiilor pacientului cu managerul de caz pentru stabilirea obiectivelor generale și operaționale.

Aceste coordonate pot fi structurate în funcție de:

- Gradul de intensitate al intervențiilor în diferite etape ale continuumului de asistență;

- Prioritatea dată de nevoile individuale, cele medicale, psihologice și sociale depistate în urma evaluării (stabilite de managerul de caz în acord cu pacientul) și, nu neapărat în ultimul rând, al ofertei de servicii disponibile;
- Complementaritatea necesară pe parcursul întregului circuit al asistenței; măsurile psihologice și sociale vor iniția intrarea în serviciile medicale, ulterior, se vor asocia acestora, și în final, vor fi preponderente sau chiar singurele, în sensul scopului final al reinsertiei sociale;
- Adecvarea temporală, spațială și individuală a măsurilor psihologice în funcție de scopul acestora, pe parcursul pretratamentului și continuumului de asistență de a pregăti, iniția motivația pentru schimbare și menținerea acesteia, prevenirea și managementul recăderilor, dezvoltarea capacității de control, negociere, rezolvarea problemelor și alte intervenții menite să dezvolte capacitatea individuală de autogestionare; intervenții dedicate dezvoltării capacității de relaționare și sprijin familial și de mediu;
- Adecvarea temporală, spațială și individuală a măsurilor sociale în funcție de scopul acestora, pe parcursul pretratamentului și continuumului de asistență de a pregăti intrarea în tratament, menținerea și pregătirea ieșirii (educarea și formarea deprinderilor de viață, a celor vocațională și de căutare a unui loc de muncă, găsirea și menținerea acestuia, gestionarea banilor, transportul, găsirea și menținerea unei locuințe, rezolvarea problemelor juridice sau a celor familiale, altele);
- Adecvarea temporală, spațială și individuală a măsurilor medicale. Acestea, ca și cele precedente, vor fi adresate problemelor depistate în legătură directă, asociată sau fără legătură cu consumul de droguri;
- Asigurarea intervențiilor necesare, întărirea acolo unde este cazul, pentru parcurgerea etapelor de tranziție de la un nivel de asistență la altul, dintr-un serviciu în altul, de la o etapă la alta, de la un regim de asistență la altul;
- Asigurarea intervențiilor necesare de prevenire sau depășire a recăderilor sau situațiilor de criză, prin stabilirea punctelor tari și slabe ale fiecărui caz, dar și prin monitorizarea susținută și legăturile colaborative realizate de către managerul de caz;
- Nivelul de intensitate necesar, dar niciodată mai restrictiv decât este cazul, pentru a permite pacientului atât obținerea intensității necesare pentru o etapă anume a evoluției sale, dar și pentru a-și putea păstra capacitatea de funcționare individuală și socială;
- Temporalitatea, integrarea în timp și planificarea integrată într-o perioadă de timp dată, dar și a momentelor de implementare previzionate după încheierea evaluării și orientarea într-unul din cele 4 PIT;
- Serviciile existente și disponibile și accesarea acestor resurse.

Dezvoltarea planului cu precizarea cadrului de timp, modalității și intensității (cantitate, frecvență) intervențiilor permite monitorizarea progresului în cadrul de timp estimat și dezvoltarea adaptărilor în funcție de evoluția cazului. Aceasta se aplică, de asemenea, atunci când se abordează alte patologii asociate, acolo unde tratamentul poate fi selectat și extins, față de estimarea inițială, în funcție de progresul în atingerea obiectivelor propuse și depistarea soluțiilor coerente.

În efortul de a optimiza nivelul general de reabilitare al pacientului, pot fi aduse **modificări ale componentelor planului**, în sensul metodelor selectate, intensității, frecvenței, tipurilor de servicii oferite, duratei. Aceste modificări se vor face în acord cu gradul de eficiență al intervențiilor în soluționarea situațiilor critice curente, ca și în efectul acestora pe termen lung asupra evoluției afecțiunii. În modificarea uneia sau mai multor componente din planul individual de asistență, managerul de caz trebuie să realizeze o evaluare cât mai acurată a situației care necesită schimbarea și să facă o balanță între nevoile sau problemele productive sau contraproductive pentru progresul pacientului, din punct de vedere atât al pacientului, cât și al serviciului. Urmare a acestei prime etape, realizate prin măsuri de reevaluare în arii de necesitate și prin discuții cu responsabilul de caz sau coordonatorul centrului sau serviciului, managerul de caz va trece la negocieri pentru obținerea alternativei celei mai productive pentru progresul cazului. Această alternativă poate să nu fie în mod necesar și cea mai dorită de pacient sau de serviciul respectiv, și aceasta deoarece sunt multe momente pe parcursul evoluției unui caz în care apar rezistențe sau scăderea motivației pentru schimbare, iar pe de altă parte, din partea serviciului, urmarea a limitărilor financiare, listelor de așteptare sau aplicării prea riguroase a regulamentelor interne. Aceasta înseamnă, desigur, ca nici o componentă din plan să nu fie schimbată, sau mult mai puțin decât părea necesar în primul moment.

În tot cazul, atunci când sunt aduse schimbări în PIA, managerul de caz va trebui să discute acestea cu pacientul, să-l informeze asupra tuturor coordonatelor modificate, astfel încât acesta să-și exprime un acord în cunoștință de cauză (acord informat), dar și cu responsabilul de centru.

Planul individual de asistență se elaborează în maximum 5 zile de la data solicitării, iar în cazuri excepționale acest interval poate fi prelungit.

În condițiile în care planul individual de asistență cuprinde participarea mai multor servicii sau instituții specializate în domeniul medical, psihologic sau social acestea se vor desfășura într-un mod integrat, pe baza convențiilor de parteneriat, astfel încât solicitantul să poată beneficia de o asistență concomitentă și continuă.

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR STABILITE ÎN PIA

Implementarea măsurilor stabilite în PIA este realizată prin intermediul serviciilor de asistență și tratament, care își desfășoară activitatea în centre uni sau multifuncționale. Procesul de acordare a serviciilor se desfășoară în cadrul continuumului de asistență, intervențiile având loc integrat în succesiune sau concomitent, în sensul acordării paletelor necesare de servicii, adecvate nevoilor individuale. Managerul de caz face legăturile și trimerile necesare către toate resursele precizate în PIA, în fiecare etapă și ghidează pacientul în cadrul continuumului de asistență.

Monitorizarea, coordonarea și evaluarea rezultatelor de proces integrat a metodelor/acțiunilor planificate și implementate este efectuată de managerul de caz. Evaluarea rezultatelor măsurilor este realizată de responsabilul serviciului care îl va informa pe managerul de caz asupra acesteia. Managerul de caz, prin intermediul legăturilor stabilite cu diferitele componente ale sistemului de asistență, precum și cu pacientul și mediul său de suport, va fi în contact permanent cu progresul fiecărui caz. Conform datelor consemnate în PIA acesta va urmări măsura atingerii obiectivelor mici operaționale/acțiunilor, în sensul atingerii pe parcursul implementării a rezultatelor așteptate la datele stabilite, sau atunci când este cazul. Trecerea de la un serviciu la altul, sau de pe un nivel pe altul, precum și reîntoarcerea în comunitate, conform evoluției fiecărui pacient sunt puncte slabe recunoscute aproape pentru toți pacienții. Desigur, la acestea se asociază și cele individuale, iar toate acestea reprezintă situații în care managerul de caz trebuie să-și intensifice intervențiile și interacțiunea cu pacientul și cu rețeaua de servicii.

Evaluările efectuate la intervalele stabilite vor aduce precizări clare asupra progresului individual. Rezultatele evaluărilor se concretizează în păstrarea sau modificarea unor elemente componente ale PIA.

Procesul terapeutic reprezintă un set de activități conduse în centre definite prin una sau mai multe modalități de asistență, pentru fiecare program integrat de asistență (PIT), în scopul îndeplinirii necesităților pacienților.

Procesul sau componentele funcționale constau în toate activitățile stabilite pentru adresarea problemelor pacientului, depistate în urma evaluării, prin asigurarea continuumului de asistență. Componentele constau din cel puțin două tipuri de intervenții:

a. medicale: intervenții aflate în controlul și responsabilitatea echipei medicale și sunt constituite în sensul obținerii echilibrului prin mijloace medicamentoase. Acestea includ:

- tratamentul intoxicației acute sau sindromului de abstință
- atenuarea efectelor stimulente sau plăcute ale drogului de abuz

- inducerea unor efecte neplăcute la consumul drogului (efect aversiv)
- înlocuirea drogului de consum, cu un agonist
- tratamentul complicațiilor sau altor efecte concomitente

b. psiho-sociale: intervenții de diferite tipuri, coordonate de o echipă multidisciplinară și dezvoltată pentru adresarea disfuncțiilor rezultate din tulburarea adictivă. Intervențiile de acest tip care și-au dovedit eficiența includ terapiile cognitiv-comportamentale, de grup, de familie, interpersonale, psihodinamice, grupuri de autosuport, terapii vocaționale, intervenții educative, formarea de abilități sociale și relaționale, altele.

Selecția unei modalități de asistență și a serviciilor specifice adresate consumatorilor de droguri trebuie să țină cont, în afara criteriilor enumerate mai jos, de procesul terapeutic ca întreg, în sensul integralității și continuumul de asistență. Criteriile descrise mai jos le considerăm ca fiind instrumente utile pentru managerul de caz în evaluarea fiecărui caz, dar și în selecția PIT și stabilirea PIA. Totuși, aceste criterii considerate separat, fără să țină cont de integralitatea problematicei depistate în evaluare, ca și de continuitatea și filozofia procesului terapeutic, pot deveni factori cu caracter de obstacol, prin pierderea continuității sau a abordării multidimensionale, individuale a fiecărui pacient.

SELECȚIA MODALITĂȚII DE ASISTENȚĂ

Modalitatea de asistență se referă la nivelul de tehnologie și expertiza profesională utilizate, care prin caracteristicile sale răspunde cel mai adecvat la problema sau grupul de probleme ale consumatorului de droguri în modul cel mai puțin restrictiv, dar și cel mai sigur pentru pacient.

Modalitatea de asistență și selecția unui centru în cadrul planificării depinde de o serie de factori:

- modalitatea specifică de asistență selectată este disponibilă atunci și acolo unde este nevoie,
- gradul de control urmărit față de accesul pacientului la droguri,
- resursele necesare pentru asistența comprehensivă,
- mediul de desfășurare a asistenței,
- filozofia asistenței,
- riscul de „afectare iminentă” asociat cu probleme care pot avea consecințe serioase pentru pacient sau pentru alții, care justifică intervenția imediată,
- probabilitate crescută de recădere sau continuare a consumului,

- risc semnificativ de apariție a consecințelor negative asupra consumatorului sau altora,
- posibilitatea ca acestea să apară în viitorul apropiat,
- durata estimată a asistenței,
- posibilitatea de monitorizare toxicologică a consumului de droguri,
- continuitatea serviciilor în timp și gradul de coordonare între servicii și tipuri de asistență,
- coordonarea cu alte servicii comunitare sau nu, fără limitarea asistenței la modalitățile care sunt incluse într-un plan specific,
- flexibilitatea și obiectivitatea în aplicarea criteriilor de orientare, în sensul optimizării confortului și siguranței pacientului,
- rezultatele așteptate în urma abordării fiecărei probleme identificate, în acord cu severitatea acesteia. Rezultatul obținut în urma intervenției trebuie documentat pe baza literaturii medicale și științifice disponibile,
- disponibilitatea alternativelor în cazul eșecului unei intervenții terapeutice.

Criterii de selecție a modalității de asistență

Dezvoltarea și aplicarea criteriilor standardizate pentru selecția unei anumite modalități de tratament va sprijini îmbunătățirea potențialului beneficiu obținut din intervenția terapeutică, ce depinde foarte mult de măsura în care paleta de servicii și intensitatea acestora poate fi adecvată la necesitățile pacientului.

Procedurile de evaluare sistematică vor depista necesitățile de tratament ale pacientului în diverse arii funcționale și pentru a defini capacitatea și calificările necesare a fi adresate la fiecare grad de intensitate a asistenței. Scopul aplicării acestor criterii este de a plasa pacientul la cea mai adecvată modalitate de asistență, cea care are cea mai mare posibilitate de a atinge obiectivele terapeutice în cel mai puțin intensive și cele mai sigure servicii posibile pentru fiecare caz. Aceste criterii se constituie într-un cadru instituțional și programatic în interiorul căruia se desfășoară activitățile de asistență. Tratamentul afecțiunilor rezultate din sindromul de abstenență și consum compulsiv la pacienții dependenți de droguri include un grup de intervenții realizate la diferite niveluri de intensitate a serviciilor și complexitate tehnologică.

1. Asistența de urgență. Managementul intoxicației acute și sindromului de abstenență

Această modalitate cuprinde intervențiile necesare pentru asistența pacienților aflați în situații acute ce necesită un răspuns terapeutic prompt și în care amânarea intrării în tratament apare defavorabilă pacientului. Acestea implica tratamentul complicațiilor consumului (intoxicație sau

sevraj sever), urmate de orientare sau trimitere ulterioară către Centrele de Prevenire Evaluare și Consiliere antidrog în vederea evaluării și stabilirii unui PIT.

Aceste intervenții nu sunt o modalitate specifică de asistență a tulburărilor adictive, deși sunt, fără discuție, o resursă indubitabil utilă și care sprijină îmbunătățirea prognosticului pacientului. În fapt, această abordare terapeutică se adresează la două condiții clinice cauzate direct de consumul de droguri (fie a consumului curent, fie a discontinuării acestuia). Prima se ocupă de riscul iminent la adresa vieții pacientului; în această situație tehnologia este în mod esențială, și poate fi generală (terapie intensivă) sau specifică (toxicologie), dar sunt necesare întotdeauna suportul psiho-social pentru pacient și familia acestuia, pentru a face față circumstanțelor în sine.

Această modalitate de asistență poate fi oferită înaintea intrării într-un PIT sau ulterior, indiferent de tip, și ori de câte ori este cazul. Serviciile care oferă acest tip de asistență sunt: serviciile de urgență organizate în cadru spitalicesc.

Am descris deja poziția distinctă a asistenței de urgență. Modalitățile specifice de oferire a asistenței adresate consumatorilor de droguri și a consumatorilor dependenți, pot fi clasificate în funcție de intensitatea intervențiilor în:

1. asistență ambulatorie de intensitate redusă și de intensitate crescută
2. asistență în regim rezidențial și
3. asistență în regim spitalicesc

2. Asistență ambulatorie

a. de intensitate redusă

În acest tip de asistență sunt oferite servicii specializate de asistență, de diverse tipuri, în arii ca evaluare, tratament și reabilitare. Intervențiile sunt bazate pe un protocol definit și o agendă programată regulat. Intensitatea este scăzută în ceea ce privește frecvența ședințelor, cu scopul de a realiza schimbări semnificative în comportament și de a stabili un stil de viață fără drog. Durata tratamentului depinde de severitatea și evoluția condiției particulare a pacientului. Intervențiile se desfășoară în regim ambulator, pe o durată limitată de timp, până la nivel de câteva ore.

Această modalitate de asistență este selectată atunci când:

- condițiile clinice sau mediul de viață nu necesită o intensitate mai mare a intervențiilor

- abordarea comprehensivă, incluzând intervenții psihoterapeutice și farmacologice, monitorizare comportamentală sunt posibile (The American Psychiatric Association)

b. de intensitate crescută

Acest nivel de asistență poate fi oferit într-o varietate largă de structuri ambulatorii cu program de peste câteva ore, în timpul zilei, înainte sau după orele de lucru sau școală și în timpul perioadelor considerate critice pentru evitarea consumului de droguri, cum ar fi nopțile, sfârșitul de săptămână, vacanțele sau zilele libere. Intervențiile din aceasta modalitate de asistență au caracter sistematic și structurat, mai concentrate pe nevoile pacienților.

La acest nivel, este oferită asistență integrată care poate include evaluarea și dezvoltarea unui plan de tratament, activități psiho-educative, management de caz, intervenții comportamentale, tratament medical specializat, administrarea medicației și tratamentul comorbidității psihiatrice, intervenție în criză, trimiterea spre alte niveluri de asistență și către serviciile de sprijin comunitar. Durata tratamentului depinde de severitatea și evoluția condiției clinice particulare ale pacientului.

Această modalitate de asistență este selectată atunci când:

- există probleme care justifică intervențiile de intensitate crescută
- există posibilitatea rezonabilă de a stopa consumul de substanțe într-un mediu nerestrictiv
- pacienții sunt externați din spital sau încheie un program rezidențial și sunt în situația de risc de recădere – aceasta include o motivație redusă de angajare în tratament
- în cazul comorbidității psihiatrice
- există istoric de recădere la ieșirea dintr-o structură rezidențială sau spitalicească
- mediul de viață al pacientului este riscant, iar suportul psiho-social este limitat
- pacienții prezintă un nivel scăzut de performanță la o intensitate mai crescută a asistenței. (The American Psychiatric Association)

3. Asistență în regim rezidențial

Acest nivel de asistență constă într-o serie de servicii oferite într-o structură rezidențială, 24 ore/zi de către o echipă tehnică calificată de profesioniști, urmând un protocol clinic definit. Asistență poate fi pe termen scurt, 4-6 săptămâni sau lung, peste 6 săptămâni, în mod excepțional chiar peste 1 an. Este oferit un mediu sigur care să conducă spre recuperare, în relație de continuitate cu intervențiile de sprijin comunitar. La acest nivel, o structură permanentă de sprijin și participare la grup ajută pacienții să dezvolte

capacitatea de relaționare interpersonală, promovând recuperarea și reintegrarea în comunitate.

Pacienții tratați la acest nivel de asistență prezintă tulburări funcționale specifice care necesită o structură de tip rezidențial stabilă și sigură alături de intervenții de tratament orientate spre o abordare integrată sau dezvoltate separat, cu o coordonare atentă. Aceste programe sunt caracterizate printr-o abordare terapeutică bazată pe comunitate. Componentele rezidențiale pot fi combinate cu servicii ambulatorii intensive pentru indivizi ale căror situații de trai sunt incompatibile cu scopurile lor de recuperare, în cazul în care răspund criteriilor de admitere pentru asistența intensivă în ambulator. Programele de la acest nivel pot varia în ceea ce privește intensitatea intervenției clinice conform necesităților pacientului.

Acest nivel de asistență este indicat pacienților care:

- Au nevoie de timp și structură pentru a practica și integra recuperarea și mecanismele de coping.
- Au nevoie să fie scoși dintr-un mod de viață de consum sau lipsit de pentru a diminua consumul de alcool sau droguri.
- Prezintă deficiențe funcționale, inclusiv probleme în aplicarea mecanismelor de recuperare, lipsa responsabilității personale sau lipsa preocupării pentru muncă, educație sau viața de familie.
- Nu conștientizează încă faptul că au probleme legate de consumul de alcoolul sau droguri.
- Se află într-o fază timpurie a ciclului schimbării și necesită strategii motivaționale și de monitorizare pentru a preveni obstacolele, consolida angajamentul în tratament și facilita schimbarea progresivă spre recuperare.
- Au fost afectați în mod semnificativ de consum, cu un nivel crescut de deteriorare, iar strategiile motivaționale pentru prevenirea recăderilor nu sunt posibile sau sunt ineficiente într-o structură ambulatorie.
- Prezintă tulburări cognitive temporare sau permanente, care interferează cu relațiile lor interpersonale sau cu abilitățile emoționale de coping.
- Prezintă probleme serioase care indică condiții cum ar fi senilitate, tulburări cognitive sau retard în dezvoltare.
- Au nevoie de un program care să acorde timp suficient pentru asimilarea lecțiilor învățate și experimentate în cadrul asistentei pentru a putea să le aplice în viața lor de zi cu zi.
- Prezintă anumite probleme medicale și au nevoie de plasare într-o centru de tip medico-social sau de un alt centru cu resurse de personal medical, sau prezintă probleme psihologice și sociale severe.
- Au relații interpersonale haotice, chiar abuzive, sprijin inadecvat, istoric extins de tratament, probleme juridice, performanță deficitară la locul de muncă sau școlară sau sistem de valori antisociale.

- Necesită tratament integrat cu durată relativ lungă pentru tulburări multiple, inclusiv deficiențe educaționale sau vocaționale și probleme interrelaționate.

Scopurile tratamentului la acest nivel (tratament rezidențial/bazat pe comunitate) sunt sprijinirea pacientului în:

- Obținerea abstenenței la consumul de substanțe și eliminarea comportamentului antisocial.
- Schimbarea complexă în stilul de viață, atitudini și valori.
- Remedierea deficiențelor prin intervenții focalizate.
- Reducerea riscurilor de recădere.
- Reîntărirea comportamentului social pozitiv.
- Aplicarea mecanismelor de recuperare.
- Îmbunătățirea funcționării emoționale.
- Promovarea responsabilității personale.
- Reintegrarea individului prin găsirea unui loc de muncă, educație și viața de familie.
- Creșterea gradului conștientizare a problemelor legate de dependența, depășirea ambivalenței.

Această modalitate de asistență este selectată atunci când:

- nu sunt motive suficiente care să justifice internarea
- stilul de viață și interacțiunea socială sunt orientate către consumul de substanțe
- pacientul nu are suficiente abilități sociale sau vocaționale
- se remarcă lipsa suportului social liber de drog pentru menținerea abstenenței prin asistență ambulatorie. (The American Psychiatric Association)

4. Asistență în regim spitalicesc

Procedurile de tratament la acest nivel sunt oferite în structuri dotate cu toate tipurile de resurse ale unui spital, sau ale unui spital specializat de psihiatrie și sunt administrate de o echipă interdisciplinara de profesioniști în medicină și din alte arii calificați în tratamentul pentru probleme de consum de droguri. Evaluarea planificată și serviciile de tratament sunt oferite în funcție de protocolul definit pentru intervenții clinice.

Acesta este cel mai intensiv nivel de asistență din continuumul de tratament. Obiectivul principal este de a corecta dezechilibrele din condiția pacientului, stabilizarea acestuia și pregătirea pacientului pentru o posibilă

admitere într-un program de intensitate mai mică pentru pacienți decompensați urmare a unei probleme biologice, psihologice sau sociale de severitate suficientă cât să necesite prioritar asistență medicală. Durata tratamentului depinde de severitatea și evoluția condiției particulare a pacientului.

Această modalitate de asistență este selectată atunci când:

- supradoza nu poate fi tratată în condiții de siguranță în ambulator sau servicii de urgență
- există riscul unui sindrom de abținere sever sau al complicațiilor medicale severe
- comorbiditatea medicală interferează cu dezinxicarea în condiții de siguranță
- pacientul are un istoric de recădere sau abandon într-o modalitate de asistență de o intensitate mai redusă
- comorbiditatea psihiatrică interferează cu tratamentul, sau necesită spitalizare (psihoză acută sau risc suicidal crescut)
- condiția pacientului implică un risc pentru sine sau pentru alții
- pacientul nu răspunde la o modalitate de asistență mai puțin intensivă
- când consumul curent prezintă un risc evident pentru sănătatea fizică sau mintală. (The American Psychiatric Association)

PUNCTE CHEIE

- o Planul individualizat de asistență se realizează în cadrul unui PIT, folosind în acest scop, caracteristicile și necesitățile pacienților și mediului de suport al acestora, dar și caracteristicile mediului de asistență în care urmează să se implementeze planul.
- o În toate cazurile PIA este realizat cu acordul informat al pacientului.
- o Realizarea PIA sub forma unui proiect permite managerului de caz, furnizorilor de servicii și pacienților realizarea unei abordări realiste, aplicabile și măsurabile.
- o Ca multe alte decizii și deciziile privind elemente componente ale PIA pot fi schimbate; măsura schimbărilor va fi în funcție de datele obiective sau obiectivabile apărute pe parcursul derulării planului și de care trebuie să se țină cont pentru asigurarea menținerii pacientului în circuitul de asistență.
- o Criteriile de selecție a serviciilor și modalităților de asistență pot fi utilizate de managerul de caz pentru selecția mijloacelor care să permită desfășurarea acțiunilor propuse și atingerea obiectivelor generale și operaționale.

MODALITĂȚI DE ASISTENȚĂ

Modalitate	Descriere	Caracteristici ale pacienților
1. Ambulator de intensitate redusă	- Tratament în cadru non-rezidențial - Ședere limitată (ore) - Frecvență: (săptămânal, o dată sau de două ori) - Exemplu: Serviciu de consultație în ambulator, de consiliere	Pacienți: - diagnosticați cu grade de severitate care pot fi tratate cu resursele disponibile, sau - care au primit tratament la un nivel mai intensiv și au progresat până la punctul în care pot beneficia de acest nivel de asistență, sau - care pot solicita asistență mai intensivă dar nu sunt pregătiți să se angajeze complet în tratament.
2. Ambulator de intensitate crescută	- Tratament într-un cadru non-rezidențial, dar cu o intensitate crescută a intervențiilor - Ședere de câteva ore, dimineața, după-amiaza,, ambele, noaptea, la sfârșit de săptămână - Frecvență: zilnic - Exemplu: centru de zi	Pacienți: - diagnosticat cu grad de severitate care poate fi tratat în cadrul unui program ambulator, care, în orice caz, necesită reîntărirea în ceea ce privește nivelul de intensitate al asistenței care poate fi oferit zilnic în timpul unor ședințe cu durată de câteva ore. Acest nivel poate implica componente aflate în mod normal în programele rezidențiale, mai structurate.
3. Asistență în regim rezidențial	- Tratament în regim închis - Ședere de 24 de ore - Cadru structurat, rezidențial - Include asistență tipic oferită în mediile rezidențiale, asistență medicală, de psihiatrie, psiho-socială, controlul medicației, evaluare, tratament, reabilitare, abordări bazate pe familie. - Exemplu: comunitate terapeutică	Pacienți: - pentru care timpul și structura sunt necesare pentru a integra recuperarea cu dezvoltarea abilităților de coping, - aflați în faza de negare a problemelor legate de consumul de droguri, - la care efectele tulburărilor datorate consumului de substanțe sunt evidente și foarte semnificative, cu afecțiuni multiple, făcând strategiile de creștere a motivației și de prevenire a recăderilor imposibile sau ineficiente într-un cadru ambulator, - cu tulburări cognitive, interferează permanent sau temporar cu relațiile interpersonale sau cu abilitățile de coping,

		- cu anumite probleme grave medicale, psihologice și sociale care necesită tratament comprehensiv, multidimensional și pe termen lung, - la care mediul de viață este non-protectiv sau de consum de substanțe, relațiile interpersonale sunt haotice sau chiar abuzive, oferind sprijin minim, - cu istoric lung de tratament, - cu probleme legale, - cu performanțe scăzute la școală sau la serviciu, sistem de valori antisociale.
4. Asistență în regim spitalicesc	• Tratament în regim închis • Ședere de 24 de ore • Accentul este pe asistența medicală specializată și specifică • Include asistență tipică oferită în mediile rezidențiale, asistență medicală, de psihiatrie, psihosocială, controlul medicației, evaluare, tratament, reabilitare, abordări bazate pe familie, sub supervizarea unei echipe de profesioniști în domeniul sănătății. Exemple: dezintoxicarea spitalicească	Pacienți - la care necesitățile derivate din tulburările datorate consumului de droguri necesită suport de intensitate crescută - cu complicații medicale și probleme mintale moderate și severe. - cu tulburări psihiatrice sau de sănătate sub-acute care necesită toate resursele disponibile în cadrul unui spital cu caracter general sau specializat.
Intervenții de urgență	• Servicii de asistență imediată pentru tratamentul complicațiilor acute datorate consumului de droguri, în care cel mai important este riscul iminent cu privire la viața pacientului; în consecință, tehnologia implicată este de tip medical general sau specializat. Exemplu: Camera de gardă a unui spital	Pacienți - care prezintă decompensare datorită unei stări biologice, psihologice sau sociale cu o severitate ce necesită asistență medicală imediată. - cu simptome de intoxicație sau cu sindrom de abstinență severă, prezentând un risc crescut și care necesită asistență din partea unei echipe de profesioniști în domeniul sănătății

CRITERII DE SELECȚIE A UNEI MODALITAȚI DE ASISTANȚĂ ÎN FUNCȚIE DE REZULTATELE EVALUĂRII

Aria de evaluare	Ambulator/intensitate redusă	Ambulator/intensitate crescută – servicii de zi	Regim rezidențial	Regim spitalicesc
Aria 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abstinență.	Nesemnificativ sau minim.	Risc moderat de sindrom de abstinență.	Sindrom de abstinență minim, moderat sau sever dar poate fi tratat în acest regim.	Risc crescut, poate fi tratat exclusiv în regim spitalicesc.
Aria 2: Condiții bio-medicale și complicații	Absente sau foarte stabile, sub control	Absente sau prezente, dar pot fi vindecate; nu interferează cu procesul de recuperare	Absente sau condiții stabilizate sub supervizare medicală.	Prezente și necesită monitorizare medicală 24 de ore, serviciile de asistență și resursele spitalicești sunt necesare.
Aria 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații. Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, a continuare consumului, alte probleme.	Absente sau foarte stabile, sau pacientul se află sub supervizare în cadrul unui serviciu de sănătate mintală Severitate crescută în cadrul acestei arii dar nu și în altele. Orientat spre schimbare dar necesită motivație și control. Capacitate de menținere a abstinentei sau de a controla consumul. Capacitate de a progresa către schimbare cu un suport minim	Prezente de severitate medie - moderată și poate interferează semnificativ cu procesul de recuperare, necesită stabilizare Angajare minimă, ambivalență semnificativă, lipsa conștientizării problemei. Sunt necesare intervenții structurate, cu suport zilnic, de intensitate semnificativă	Prezente de severitate medie - moderată, poate interfera semnificativ cu procesul de recuperare; sau necesită stabilizare. Este necesară modelare comportamentală Deschis spre recuperare dar necesită cadru structurat sau rezidențial; sau severitate crescută în cadrul acestei dimensiuni dar nu și în altele. Necesită dezvoltare motivațională. Dificultăți semnificative în legătură cu sau față de tratament,	Instabilitate moderată sau de severitate crescută. Necesită asistență psihiatrică spitalicească. Se administrează în paralel tratament pentru dependența de droguri. Rezistență la tratament, lipsa controlului impulsurilor; necesită strategii motivaționale în structuri cu regim de 24 ore sau un program intensiv de întărire motivațională Neeligibilitate pentru resurse de intensitate mai mică Potențial de continuare a consumului periculos; neeligibilitate pentru resurse de intensitate mai mică

Aria 4: Condiții familiale	sociale	și	Pacientul primește sprijin. Are instrumentele necesare pentru a depăși situația cu succes sau severitate crescută în cadrul acestei arii dar nu și în altele.	Pacientul necesită sprijin. Prin intermediul unui cadru structurat, cu sprijin și schimbarea mediului pacientul poate depăși situația cu succes.	prezentând pericol iminent.	Periculos. Pacientul nu se încadrează în criteriile serviciilor de asistență mai puțin intensive.
					Înțelege recăderile; necesită structurare pentru menținerea progresului terapeutic. Conștientizare scăzută a problemelor, necesită intervenții de tip rezidențial pentru prevenirea continuării consumului, cu consecințe iminente și serioase; deficit cognitiv și funcțional Necesită asistență de tip rezidențial pentru dezvoltarea capacității de coping Periculos. Pacientul necesită cadru structurat 24 de ore pentru a învăța să facă față situației cu succes	

VI. MANAGEMENT DE CAZ

INTRODUCERE

Datele bazate pe evidențe științifice arată că, persoanele consumatoare de substanțe care primesc asistență de specialitate pentru problemele asociate sau generate de consum își vor îmbunătăți funcționarea socială și familială, iar simptomatologia psihiatrică și cea datorată consumului va diminua în urma acestei abordări (McLellan și alții, 1993; McLellan și alții 1982; Moss și alții, 1982; Siegal și alții 1995). Clinicienii care dezvoltă o relație de „alianță și sprijin” cu persoanele cu consum abuziv de substanțe au avut rezultate terapeutice mai bune comparativ cu cei care nu au avut această abordare (Luborsky și alții 1985).

DE CE MANAGEMENT DE CAZ

Dat fiind faptul că dependența afectează atât de multe fațete ale vieții consumatorului, un continuum complex de servicii promovează recuperarea și permite pacientului să se integreze în societate ca individ sănătos, liber de drog. Acest continuum trebuie să fie creat astfel încât să determine angajament și motivație prin intermediul unor servicii de asistență adecvate nevoilor (problematicii) depistate în urma evaluării. Asistența trebuie structurată astfel încât să asigure tranziția ușoară de la un serviciu la altul, sau de la un nivel de intensitate la altul, în scopul evitării golurilor ocazionate de aceste schimbări și să răspundă rapid la potențialul de risc de recădere. Managementul de caz reprezintă resursa menită să ajute la îndeplinirea acestora.

Managementul de caz este necesar deoarece, în cele mai multe medii, serviciile sunt fragmentate și inadecvate în îndeplinirea nevoilor populației consumatoare de substanțe. Această lipsă de servicii coordonate rezultă în urma unei varietăți de factori, inclusiv:

- Surse de finanțare diferite. Tratatamentul abuzului de substanțe este finanțat dintr-o varietate de surse – finanțări de stat și locale, fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, donații, sponsorizări, alte contribuții din partea persoanelor fizice sau juridice din țară sau străinătate, contribuția persoanelor beneficiare ale serviciilor, fonduri externe rambursabile sau nerambursabile.

- Centrarea preponderentă pe finanțarea programului și nu pe finanțarea sistemului.
- Finanțări centrate pe modalități singulare mai mult decât pe un continuum de asistență.
- Finanțări inadecvate create de piesele lipsă din continuum.
- Liste de așteptare datorită finanțărilor inadecvate.
- Bariere între sisteme (de exemplu, sănătatea mintală vs. consumul abuziv de substanțe, poliția vs. sănătatea mintală și consumul abuziv de substanțe).
- Lipsa de încurajări cu privire la rezultatele pacientului; programe recompensate prin măsurarea procesului, nu prin măsurarea rezultatelor procesului.
- Criteriile de eligibilitate/intrare care exclud anumiți pacienți.
- Lipsa unui consens cu privire la prioritatea de intrare/ modalitatea de asistență.
- Lipsa unor programe care să stimuleze munca în echipă.

În experiența multor țări, datorită fragmentării serviciilor, ineficienței acestora și deficitului de resurse, unele forme ale managementului de caz sunt utilizate în principiu în orice populație care caută, de obicei, servicii sociale. Variabilitatea configurației sistemului de servicii medicale, psihologice și sociale a condus la multiple implementări ale managementului de caz, având ca rezultat dispute conceptuale cu privire la managementul de caz și dificultatea de a evalua valoarea acestuia. În mod inevitabil, multe dintre aceste probleme apar și în cadrul structurilor ce se adresează consumului de substanțe. Acest capitol este creat pentru a stabili un punct de plecare comun pentru managementul de caz al persoanelor cu consum abuziv de substanțe. Pentru a răspunde cel puțin la unele dintre aceste probleme, vom admite următoarele:

1. Managementul de caz reprezintă un set de funcții care ajută pacientul să acceseze resursele de care are nevoie pentru recuperarea după problemele legate de consumul de substanțe. Funcțiile cuprinse de managementul de caz – evaluare, planificare, stabilirea legăturilor, monitorizare și advocacy – trebuie întotdeauna adaptate nevoilor individuale ale consumatorilor, dar și particularităților unei structuri organizatorice de asistență sau ale unui serviciu. Resursele necesare unui individ pot fi externe (de exemplu locuință și educație) sau interne (de exemplu, identificarea și dezvoltarea de abilități).
2. Advocacy reprezintă una din funcțiile de bază ale managementului de caz. În timp ce un profesionist conducând terapia poate interveni în numele pacientului, managementul de caz este orientat spre a face serviciile să se potrivească pacienților mai mult decât a face pacienții să se potrivească serviciilor.

3. Managementul de caz poate fi implementat de către o persoană care își dedică activitatea exclusiv sprijinirii pacientului spre a accesa resursele necesare – un manager de caz - sau de către un profesionist care are această responsabilitate pe lângă funcțiile de terapie și consiliere psihologică. În această material se pune accentul mai mult pe intervenție decât pe profesia celui care intervine.
4. Diferența esențială dintre managementul de caz și terapie este că primul pune accentul pe obținerea resurselor, în timp ce terapia se focalizează pe schimbul intra - și interpersonal. Aceasta nu înseamnă că managementul de caz și terapia sunt incompatibile. Într-adevăr, ambele răspund în general majorității pacienților consumatori de substanțe.
5. Atunci când este implementat adecvat, managementul de caz asigură continuumul de asistență: pretratament, program integrat de tratament și asistență continuă. Acest lucru se întâmplă datorită funcției de advocacy a managementului de caz; necesitatea ca managerii de caz să fie flexibili, acțiunile acestora să se bazeze pe comunitate și să fie orientate spre comunitate; necesitatea ca managerii de caz să fie figurile principale în planificarea lucrului cu pacientul.

Aceste afirmații sunt influențate și de structura organizatorică a Centrului de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, resursa care implementează managementul de caz. Practicienii care lucrează cu persoanele consumatoare de substanțe acționează în clinicile de menținere pe metadonă, programe intraspitalicești sau în ambulator, în servicii sociale locale, programe de protecție a familiei și altele. Aceste structuri organizatorice sunt influențate de numeroși alți factori, care includ: sursele de finanțare ale unui serviciu, misiunea acestuia, formarea personalului, educație și pregătire, principiile de tratament ale serviciului, structura celorlalte servicii sociale dintr-o anumită zonă geografică. Astfel, legătura dintre aceste resurse devine de maximă importanță.

SCURT ISTORIC

Cu mai mult de 70 de ani în urmă, când Mary Richmond a imaginat cadrul „vecinilor prietenoși” în sensul sprijinirii celui alt în lupta cu vicisitudinile vieții (Richmond 1922) a creat nu numai aria serviciului social dar și pe cel al managementului de caz. Atunci când aceasta a introdus termenul de „caz social” în descrierea activităților care influențează adecvarea individului la mediul social dat, această abordare descrie în aceeași măsură funcțiile cheie care sunt cuprinse azi în managementul de caz.

Una dintre primele încadrări legislative ale managementului de caz a apărut în SUA, în anul 1963 în *Federal Community Mental Health Center Act* (Intagliata, 1982), act premergător dezinstituționalizării, în care persoanele aflate în asistență psihiatrică pe termen lung au fost preluate

de structuri ale comunității. Dezinstituționalizarea, ca rezultat al intervenției socialului, a condus la expansiunea rapidă a serviciilor sociale bazate pe comunitate. Din păcate, aceste servicii au fost create adesea independent unele de altele, la care s-a adăugat natura categorică a eligibilității pentru servicii, ceea ce a creat dificultăți persoanelor obișnuite să primească aceste servicii în mod instituțional. Ulterior, s-a dezvoltat managementul de caz ca un mecanism care să ajute pacienții să parcurgă acest sistem fragmentat de servicii. Prin accesarea acestor resurse, persoanele consumatoare vor avea posibilitatea să trăiască și să funcționeze adecvat în comunitățile din care fac parte (Intagliata, 1982; Stein și Test, 1980; Test, 1981; Turner și TenHoor, 1978).

Persoanele cu consum de substanțe nu au avut același istoric cu privire la frecvența instituționalizării ca în cazul celor cu probleme de sănătate mintală astfel încât, legislația cu privire la dezinstituționalizare nu a avut un impact direct asupra lor. Persoanele cu consum de substanțe nu reprezentau un obiectiv specific pentru sistemele de furnizare a serviciilor și nu erau destinatari clari ai serviciilor managementului de caz. Totuși, servicii asemănătoare managementului de caz erau oferite consumatorilor de droguri sub alte denumiri, cum ar fi „activități misionare” oferite de reprezentanții bisericii sau alte figuri din comunitate sau centre de dezintoxicare. Abia după ce consumul de substanțe începe să fie discriminat și considerat o boală, persoanele cu consum de substanțe erau trimise către diferite servicii sociale.

Politicienii din Canada au fost printre primii care au tradus în practică multe funcții generice ale managementului de caz în câmpul tratamentului consumului de substanțe, subliniind elementele esențiale ale unei combinații între managementul de caz și tratamentul abuzului de substanțe (Graham și Birchmore – Timney, 1990; Ogborne și Rush, 1983; Rush și Ekdahl, 1990). Managementul de caz pentru persoanele cu consum de substanțe a câștigat interes inițial în Statele Unite prin programul *Treatment Alternatives for Safe Communities* (TASC) (cunoscut sub numele de *Treatment Alternatives to Street Crime*) care a început să conecteze sistemul de justiție cu sistemul de tratament al abuzului de droguri în 1972 și care s-a dezvoltat ajungând în prezent la peste 185 de programe (Cook, 1992).

DEFINIȚII ȘI FUNCȚII

Orice definiție actuală a managementului de caz este inevitabil contextuală, bazată pe necesitățile unei anumite structuri organizaționale, pe realitatea înconjurătoare și pe prioritățile pregătirii persoanelor care implementează, asistenți sociali, asistente medicale, psihologi, medici sau specialiști în managementul de caz. Totuși, iată câteva exemple:

DEFINIȚII ALE MANAGEMENTULUI DE CAZ

Managementul de caz reprezintă:

- „planificarea și coordonarea unui pachet de servicii de sănătate și servicii sociale individualizate pentru a răspunde necesităților particulare ale pacientului” (Moore, 1990).
- „un proces sau o metodă care să asigure capacitatea de a oferi pacienților toate serviciile de care au nevoie într-o manieră coordonată, efectivă și eficientă” (Intagliata, 1981).
- „sprijinirea persoanelor ale căror vieți sunt nesatisfăcătoare sau neproductive datorită prezenței unor probleme multiple care necesită asistență de la mai multe servicii în același timp” (Ballew și Mink, 1996).
- „monitorizarea, urmărirea evoluției și oferirea de sprijin unui pacient în cursul tratamentului și după încheierea acestuia” (Ogborne și Rush, 1983).
- „asistarea unui pacient în reconstituiră a unor resurse interne cum ar fi inteligența, competența și abilități de rezolvare a problemelor; stabilirea și negocierea liniilor de operare și comunicare între pacient și resursele externe; coordonarea cu aceste resurse externe pentru a îmbunătăți continuitatea, accesibilitatea, responsabilitatea și eficiența acestor resurse” (Rapp și alții, 1992).
- „evaluează necesitățile pacientului și familiei acestuia, acolo unde este cazul, și organizează, coordonează, monitorizează, evaluează și încurajează adresarea către un pachet de servicii multiple pentru a veni în întâmpinarea necesităților complexe specifice ale unui pacient.”

În timp ce definițiile sunt utile pentru ghidarea discuțiilor generale, funcțiile sunt o modalitate mai eficientă de abordare a managementului de caz așa cum este practicat în prezent.

Un set de funcții larg acceptate cuprinde:

- (1) evaluarea**
- (2) planificarea**
- (3) crearea de legături de colaborare**
- (4) monitorizarea**
- (5) advocacy.**

Trimiterea și **coordonarea** serviciilor sunt două dintre dimensiunile importante ale practicii managementului de caz, necesare pentru a-l

considera eficient în problemele de dependență. Activitățile care fac parte din aceste două dimensiuni includ:

- angajarea;
- evaluarea;
- planificarea, stabilirea obiectivelor și implementarea;
- stabilirea legăturilor, monitorizarea și advocacy;
- terminarea programului.

Coordonarea serviciilor se definește astfel:

„Activitățile administrative, clinice și evaluative care reunesc pacientul, serviciile de tratament, serviciile comunitare și alte resurse în sensul focalizării pe problemele și necesitățile identificate și abordate prin intermediul planului individualizat de tratament. Coordonarea serviciilor, care include managementul de caz și advocacy-ul, stabilește un cadru de acțiuni adresate pacientului în vederea realizării obiectivelor specifice. Implică colaborarea cu pacientul și celelalte persoane semnificative, coordonarea serviciilor de tratament și trimiteri, activitățile de colaborare cu resursele comunității și sistemele managementului de caz, evaluarea continuă a progresului în tratament și a necesităților pacientului” (CSAT, 1998).

APLICAREA MANAGEMENTULUI DE CAZ ÎN TRATAMENTUL CONSUMULUI DE SUBSTANȚE

Managementul de caz este mult adaptabil, dar o serie de principii generale sunt reale pentru aproape orice aplicație. În continuare vom discuta despre aceste principii, competențele necesare pentru implementarea funcțiilor managementului de caz și relația dintre aceste funcții și continuumul de tratament al consumului de substanțe. În scopul prezentării, managementul de caz și tratamentul consumului de substanțe sunt prezentate ca aspecte separate și distincte în cadrul continuumului de tratament, deși în realitate acestea sunt complementare și uneori intricate.

PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI DE CAZ

Managementul de caz oferă pacientului un punct unic de contact cu sistemul de servicii medicale, psihologice și sociale. Cea mai puternică rațiune în favoarea managementului de caz poate fi aceea că se consolidează într-un singur punct de responsabilitate pentru pacienții care primesc asistență de la mai multe centre și servicii. Managementul de caz înlocuiește procesul dezorganizat sau complicat de trimiteri cu un singur serviciu bine structurat. Prin acest lucru, oferă pacientului continuitate. Fiind punctul de contact, managerii de caz au obligații atât față de pacienții lor cât și față de membrii sistemului cu care aceștia vor interacționa. Managerii de caz trebuie să se familiarizeze cu protocoalele și procedurile de intervenție

folosite de ceilalți profesioniști. Managerul de caz trebuie să mobilizeze resursele de care este nevoie, pentru acest lucru fiind necesare abilități de negociere în sistemele formale, de schimb informal între ofertanții de servicii și de a urmări constant rețelele informale. Acestea includ grupurile de auto-suport și membrii acestora, vecinii și numeroase alte resurse care uneori nu sunt nominalizate în listele serviciilor formale.

Managementul de caz orientează pacientul și este orientat de necesitățile pacientului. Prin modelele managementului de caz, în domeniul abuzului de droguri și în alte domenii există o credință generală conform căreia pacientul trebuie să preia inițiativa în identificarea resurselor necesare. Managerul de caz își utilizează experiența în identificarea opțiunilor pentru pacient, dar totodată susține dreptul pacientului la auto-determinare. O dată ce pacientul alege dintre opțiunile identificate, experiența managerului de caz are rolul de a ajuta pacientul să acceseze serviciile alese. Managementul de caz este bazat pe înțelegerea experiențelor pacienților și a lumii în care aceștia trăiesc – natura dependenței și problemele pe care aceasta le cauzează și alte probleme cu care pacientul se confruntă (infectarea cu HIV, probleme de sănătate mintală sau detenție). Această înțelegere formează contextul muncii managerului de caz care se centrează pe identificarea problemelor medicale și psiho-sociale și pe anticiparea și sprijinirea pacientului în obținerea resurselor. Scopul managementului de caz este de a oferi nivelul necesar de asistență, cel mai puțin restrictiv, astfel încât să interfereze cât mai puțin cu viața pacientului.

Managementul de caz implică advocacy. Scopul principal în punerea în legătură a pacienților cu diversele servicii, fiecare putând avea adesea solicitări contradictorii, este promovarea intereselor pacientului. Managerii de caz trebuie să susțină aceasta în interacțiunea cu mai multe sisteme, inclusiv servicii, familii, sistemul de justiție și de ordine. Managerul de caz poate susține ‘cauza pacientului’ prin informarea și sensibilizarea personalului din serviciile existente despre problemele consumului de substanțe în general și despre necesitățile specifice ale fiecărui consumator. Câteodată, managerul de caz trebuie să negocieze în privința regulilor unui serviciu cu scopul de a câștiga accesul sau continuitatea pentru un pacient. Advocacy-ul poate îmbrăca uneori forme dure, ca în situațiile în care un manager de caz trebuie să insiste față de un centru să ofere servicii unui pacient, făcând apel la demersurile legale sau contractuale. Pentru pacienții aflați în sistemul de justiție, advocacy-ul poate cuprinde recomandările și sancțiunile menite să încurajeze complianța și motivația pacientului.

Managementul de caz este bazat pe comunitate. Toate abordările managementului de caz pot fi considerate bazate pe comunitate deoarece acestea ajută pacientul să negocieze cu serviciile comunitare și cu resursele de asistență informală cum ar fi familia, prietenii, grupurile de auto-suport și biserica. În tot cazul, gradul de implicare directă a comunității, de către managerul de caz, variază în funcție de centru. Unele centre sporesc

eforturile în munca de teren în cadrul comunității. În astfel de programe, managerii de caz însoțesc pacienții în diferite ipostaze ale vieții curente a acestora. Această implicare personală validează experiențele pacienților într-un mod în care nici o altă abordare nu o poate face. Astfel, aceasta se potrivește subculturii adicției deoarece permite managerului de caz să înțeleagă mai bine lumea pacientului, să învețe care sunt străzile sigure și unde există trafic de droguri. Această familiarizare ajută profesioniștii să aprecieze realitățile cu care se confruntă pacientul și să stabilească obiective de tratament mai adecvate, să ajute pacientul să aibă încredere și să respecte managementul de caz. Datorită faptului că adeseori trece de limitele facilitării și datorită faptului că managerul de caz este mai implicat în comunitate și în viața pacientului, reușitele în reangajarea pacientului în tratament și comunitate sunt, în general mai mari comparativ cu cele obținute prin eforturi bazate pe servicii. Pentru pacienții instituționalizați, managementul de caz implică pregătirea pacienților pentru tratamentul bazat pe comunitate și pentru viața în comunitate. Managementul de caz poate să se asigure că tranzițiile sunt line și că nu există obstacole la intrarea în programele bazate pe comunitate. Managementul de caz poate, de asemenea, să coordoneze obținerea datelor pentru a se asigura că nu există lacune în cadrul serviciului. Tipul de relație descris aici poate uneori să strângă legăturile terapeut – pacient, modificând astfel relația tradițională.

Managementul de caz este pragmatic. Managementul de caz începe „acolo unde este pacientul”, răspunzând necesităților imediate și obiective, cum ar fi cele de hrană, adăpost, îmbrăcăminte, transport sau îngrijirea copiilor. Intrarea în tratament poate să nu reprezinte o prioritate pentru pacient în timp ce găsirea unui adăpost poate fi. Răspunzând acestor scopuri, managerul de caz dezvoltă o relație cu angajarea efectivă a pacientului. Această perspectivă centrată pe pacient este menținută în timp ce pacientul avansează în tratament. În același timp, totuși, managerul de caz trebuie să păstreze în minte dificultatea realizării unei balanțe între ajutorul favorabil, util și cel care poate împiedica angajamentul în tratament. De exemplu, pierderea locuinței poate duce la necesitatea unei asistențe rezidențiale. Învățarea de către pacienți a abilităților cotidiene necesare pentru avea un mod de viață adaptat în comunitate și lipsit de drog este o parte importantă a managementului de caz. Aceste abilități pragmatice pot fi educate explicit, sau doar modelate în timpul interacțiunilor dintre managerul de caz și pacient.

Managementul de caz este anticipativ. Managementul de caz trebuie să dețină abilitatea de a înțelege cursul natural al dependenței și recuperării, pentru a observa o problemă, pentru a întrevădea opțiunile disponibile pentru rezolvarea acesteia și de a acționa adecvat. În unele cazuri, managerul de caz poate interveni direct; în altele, managerul de caz va acționa pentru a se asigura că altă persoană din echipa de asistență intervine în funcție de necesitate. Managerul de caz, lucrând împreună cu

echipa de asistență, pune bazele următoarei faze a planului individualizat de asistență.

Managementul de caz trebuie să fie flexibil. Managementul de caz trebuie să fie adaptabil la variațiile generate de o serie extinsă de factori, inclusiv apariția unor probleme asociate, cum ar fi infecția HIV sau probleme de sănătate mintală, structura serviciilor, disponibilitatea sau lipsa unor anumite resurse, gradul de autonomie și putere garantată ale managerului de caz.

Managementul de caz este sensibil la diferențele culturale. Acomodarea la diversitate, rasă, gen, etnie, dizabilități, orientare sexuală și etapa de viață (de exemplu, adolescenți sau vârstnici), trebuie să fie clădită în cadrul procesului de management de caz. Cinci elemente sunt asociate competenței față de diferențele culturale:

- (1) aprecierea diversității,
- (2) realizarea unei evaluări culturale,
- (3) înțelegerea dinamicii interacțiunilor culturale,
- (4) încorporarea cunoștințelor culturale,
- (5) adaptarea practicilor la diversitatea prezentă într-o anumită structură (Cross și alții, 1989).

PRACTICA MANAGEMENTUL DE CAZ – CUNOȘTINȚE, ABILITĂȚI ȘI ATITUDINI

Toți profesioniștii care oferă servicii persoanelor cu consum abuziv de substanțe, inclusiv cei specializați în managementul de caz, trebuie să dețină cunoștințe, abilități și atitudini specifice acestui domeniu, care să le permită particularizarea, adecvarea și răspunsul consecvent la evoluția fiecărui caz. Cerințele de bază ale practicii efective includ abilitatea de a stabili rapid un raport, o relație, o conștientizare a modalităților de menținere a legăturilor adecvate în relația managementului de caz, capacitatea de a nu judeca pacienții, și anumite „competențe transdisciplinare” (*Addiction Technology Transfer Centers-ATTCs*). Prezentăm câteva exemple de competențe:

- Înțelegerea modelelor și teoriilor explicative ale dependenței și altor probleme asociate cu consumul de substanțe.
- Abilitatea de a descrie principiile, practicile, politicile și rezultatele modelelor de tratament, recuperare, prevenirea recăderilor cele mai general acceptate și validate din punct de vedere științific.
- Recunoașterea importanței familiei, rețelelor sociale și sistemelor comunitare în procesul de asistență și recuperare.

- Înțelegerea diversității de resurse disponibile, a rolului acestora și capacitatea de a ajuta pacienții să acceseze aceste resurse.
- Înțelegerea varietății culturale și încorporarea necesităților relevante ale diverselor grupuri, în cadrul practicii clinice.
- Înțelegerea valorii unei abordări interdisciplinare în asistența dependenței (CSAT, 1998).

Deși managerii de caz nu s-au bucurat întotdeauna de același statut acordat altor specialiști din continuumul de tratament al consumului abuziv de substanțe, aceștia trebuie să aibă un corp de cunoștințe la fel de extinse și să dispună de un sistem complex de abilități pentru a oferi servicii optime pacienților lor. Managerii de caz nu trebuie să aibă numai aceleași abilități ca și ceilalți profesioniști din domeniu ci trebuie, de asemenea, să dețină abilități speciale legate de arii cum ar fi funcționarea interdisciplinară, negocierea și advocacy. În recunoașterea competențelor specifice aplicabile managementului de caz se relevă două dimensiuni fundamentale – **trimiterea și coordonarea asistenței** – acestea implică deprinderea unor cunoștințe, abilități și atitudini esențiale pentru managementul de caz. În continuare prezentăm activitățile acoperite de aceste dimensiuni.

1. TRIMITEREA

- Stabilirea și menținerea relațiilor cu societatea civilă, centrele/serviciile, alți profesioniști, entități guvernamentale sau nonguvernamentale și comunitare, pentru a asigura trimiteri adecvate, pentru identificarea lacunelor în servicii, pentru a extinde resursele comunității și pentru a le sprijini în răspunsul adresat necesităților locale.
- Evaluarea continuă a resurselor pentru a determina gradul de adecvare al acestora.
- Diferența între situațiile în care este mai adecvată auto-referirea pacientului la unele resurse și cele în care referințele managementului de caz sunt necesare.
- Stabilirea trimiterii către alți profesioniști, servicii, programe comunitare sau alte resurse adecvate pentru a răspunde necesităților pacientului.
- Folosirea unui limbaj clar și adecvat fiecărui individ în explicarea necesității trimiterii și a procesului de trimitere pentru a da pacientului posibilitatea de înțelegere a demersului și, în consecință, de a urma trimiterea.
- Realizarea unui schimb de informații relevant cu serviciul sau profesionistul spre care se face trimiterea, într-o manieră consistentă și păstrând confidențialitatea și standardele de asistență profesională.

2. COORDONAREA ASISTENȚEI

Implementarea planului de asistență

- Inițierea colaborării cu serviciile spre care s-ar putea face trimiterea,
- Obținerea, revizuirea și interpretarea evaluării și a informațiilor relevante pentru planificare,
- Confirmarea eligibilității pacientului (prin utilizarea criteriilor de orientare) pentru includerea într-un program integrat de asistență și continuarea pregătirii pentru includere și schimbare,
- Realizarea procedurilor administrative necesare pentru includerea în program,
- Stabilirea unor așteptări realiste cu privire la tratament și recuperare împreună cu pacientul și celelalte persoane semnificative, dar fără a se limita la:
 - obiectivele programului
 - procedurile programului
 - natura serviciilor
 - calendarul activităților
 - costuri
 - factori care afectează durata asistenței
 - reguli privind conduita pacientului
 - drepturile și responsabilitățile pacientului
- Coordonarea tuturor serviciilor oferite pacientului.

Lucrul în echipă

- Cunoașterea istoriei personale a pacientului, a planului individualizat de asistență, a progresului și problemelor care împiedică derularea acestuia, în scopul asigurării calității asistenței, obținerii feedback-urilor și (re)planificării schimbărilor în cursul asistenței.
- Înțelegerea terminologiei, procedurilor și rolului fiecărei discipline implicate în tratamentul tulburărilor determinate de consumul de substanțe.
- Implicarea și lucrul în cadrul echipei multidisciplinare de tratament.
- Păstrarea confidențialității.
- Dezvoltarea și menținerea unei relații de respect și ne-critică față de toți pacienții, ca și în toate contactele cu profesioniștii din cadrul comunității sau serviciilor existente (CSAT, 1989).

CONTINUUMUL DE ASISTENȚĂ AL CONSUMULUI DE SUBSTANȚE ȘI FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI DE CAZ

Continuumul de asistență al consumului de substanțe

Tratamentul pentru consumul de substanțe poate fi caracterizat ca un continuum dezvoltat prin intermediul măsurilor și intervențiilor particulare.

Continuumul descris în acest material este ordonat cronologic, de la **identificarea cazului și pretratament** până la includerea într-un **program integrat de asistență (PIT)**, rezidențial sau ambulator, asigurând **asistența continuă**.

În timp ce pentru fiecare punct din continuum există scopuri distincte și intervenții specifice, rar se întâmplă ca necesitățile pacienților să se încadreze clar în acestea, la un moment dat. De exemplu, un pacient ar putea avea nevoie de tratament rezidențial pentru probleme serioase legate de consumul abuziv de substanțe, dar să fie motivat să primească asistență doar pentru problema privind locuința. În acest sens, managementul de caz este creat pentru a cuprinde necesitățile pacienților și structura programului.

Identificarea cazului și pretratament

Activitatea de identificare a cazului este în general o problemă de maximă importanță pentru programele de asistență, deoarece aceasta generează fluxul pacienților în tratament. De-a lungul timpului, în multe țări, pretratamentul s-a schimbat ca urmare a faptului că unele programe s-au închis, resursele s-au diminuat și serviciile disponibile s-au diversificat, au apărut serviciile de teren. Mulți indivizi identificați ca fiind eligibili pentru tratament nu pot fi incluși din diverse motive mai mult sau mai puțin întemeiate, iar pretratamentul poate constitui o intervenție terapeutică de scurtă durată. Programele de management de caz pot desfășura activități de identificare a cazurilor prin legăturile formale cu potențiale surse de referință cum ar fi angajații, autoritățile de aplicare a legii, serviciile publice, resursele de asistență medicală de urgență și cele de medicină de familie, organizațiile non-guvernamentale. Campaniile generale media pot, de asemenea, orienta consumatorii să contacteze programele de asistență.

Unele programe de asistență dezvoltă programe intensive de teren pentru a identifica și angaja pacienții în sistemul de asistență. Lucrătorii din serviciile de teren contactează viitorii pacienți și se oferă să le faciliteze intrarea în tratament. Deși intrarea în tratament poate fi scopul principal al lucrătorului și al programului de asistență, aceștia au frecvent alte necesități înainte de a consimți să participe. O mare parte din asistența oferită de lucrătorii din serviciile de teren se aseamănă cu managementul de caz prin faptul că este bazată pe comunitate, răspunde necesităților imediate ale unui pacient și este pragmatică.

O perioadă de pretratament poate reprezenta rezultatul unei liste de așteptare sau al ezitării pacientului de a se angaja pe deplin în PIT. În structurile sistemului judiciar, aceasta poate reprezenta o perioadă de pregătire a pacienților pentru intrarea în PIT, prin faptul că adesea aceștia nu au modalități de sprijin stabilite: lipsa unei locuințe, a posibilităților de transport sau abilităților necesare de muncă sau de trai. O perioadă de pretratament este necesară în situațiile în care pacienții pierd interesul/motivația pentru tratament. În condițiile în care în această perioadă sunt oferite servicii adecvate, abordarea poate conduce la creșterea angajamentului în tratament. Numeroase intervenții și tehnici adresate asumării rolurilor, lucrul în grupuri de pretratament și management de caz au fost instituite pentru îmbunătățirea rezultatelor asociate cu perioada de pretratament (Alterman și alții, 1994; Gilbert, 1988; Stark și Kane, 1985; Zweben, 1981).

Programul integrat de asistență (PIT)

Programul integrat de asistență este un termen general utilizat pentru a defini perioada în care persoana cu consum de substanțe începe să examineze impactul consumului de substanțe asupra diferitelor aspecte ale vieții sale.

Oricare ar fi structura organizatorică, este necesară o **evaluare** extensivă bio-psiho-socială. Această evaluare oferă atât pacientului cât și echipei posibilitatea de a determina severitatea clinică, preferințele pacientului, diagnosticele coexistente, abordarea terapeutică prioritară și alți factori relevanți în adecvarea pacient - modalitatea de tratament și nivelul de asistență. Dacă nu a fost deja stabilită în faza de dimensionare a cazului/pretratament, această evaluare trebuie să ia, de asemenea, în considerare necesitățile pacientului de a beneficia de anumite resurse, pentru asigurarea căora managementul de caz poate oferi sprijin.

Asistența continuă

Asistența continuă, este etapa (cronologic) următoare după realizarea intervențiilor adresate problemelor individuale ce necesită o rezolvare rapidă. Aceasta se desfășoară pe întreg parcursul circuitului integrat.

La finalizarea evaluării, pacientul este informat despre structurile circuitului terapeutic integrat, despre condițiile de tratament și reabilitare proprii fiecărui serviciu sau centru medical la care poate fi trimis, în scopul ajutării pacientului în luarea unei decizii informate privitoare la participarea sa activă la procesul de asistență. Managerul de caz colectează și analizează datele rezultate în urma evaluării și selectează includerea pacientului în unul din cele 4 PIT.

Includerea într-un PIT se face pe baza criteriilor de orientare, în funcție de problemele depistate în ariile de evaluare și de serviciile existente și disponibile. Managerul de caz stabilește împreună cu solicitantul obiectivele

principale pe cele cinci arii evaluate și elaborează planul individualizat de asistență.

Includerea se face cu manifestarea acordului de includere a solicitantului prin semnarea unui Acord de asistență medicală, psihologică și socială.

Planul individual de asistență cuprinde serviciile, măsurile și intervențiile terapeutice, psihologice și sociale individualizate din cadrul unui PIT, precum și orice alte măsuri prevăzute de alte reglementări.

Uneori, un pacient este capabil să funcționeze utilizând un plan auto-direcționat, care include interacțiuni minime cu un consilier. În acest caz, interacțiunea cu un consilier preia o funcție de monitorizare. Pacienții continuă astfel să-și reorienteze comportamentul spre un stil de viață pro-social, abstinent. Asistența continuă se referă și la situațiile în care pacientul se află într-o altă structură de asistență, cum ar fi asistența periodică în ambulator, grupuri de recuperare/prevenire a recăderilor, grupurile de auto-suport și locuințe protejate. Chiar dacă persoanele au încheiat un tratament complet în cadrul unei resurse rezidențiale sau ambulatorii, acestea au în continuare nevoie de dezvoltarea unor abilități de menținere a abstenenței și încep să lucreze la remedierea altor aspecte ale vieții lor afectate de consumul de droguri. Lucrul este intrapersonal, interpersonal și de relație cu mediul. Ariile problematice ale mediului de viață, cum ar fi reabilitarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea și asigurarea unei locuințe, intră de asemenea în definiția managementului de caz.

Dacă diferiți profesioniști îndeplinesc funcția de responsabili de caz într-un anumit serviciu, aceștia trebuie să comunice constant în timpul asistenței continue cu privire la implementarea și progresul tuturor componentelor de tratament și asistență. Datorită faptului că managerii de caz interacționează cu pacientul în cadrul comunității, aceștia se află într-o poziție unică pentru a observa rezultatele și progresele fiecărui pacient și pentru oferirea unei perspective asupra funcționării pacientului în cadrul comunității. Relațiile stabilite prin managementul cazului pot fi la fel de valoroase pentru pacient în timpul stadiului de recuperare ca și cele ale consilierului în probleme de dependență.

Asistența continuă este importantă în completarea planului individualizat de tratament, atât din punct de vedere al finanțării (mulți finanțatori refuză să plătească pentru anumite servicii), cât și din perspectiva pacientului.

Funcțiile managementului de caz

În continuare vom prezenta funcțiile managementului de caz față de posibilitatea pierderii continuității prin ieșirea pacientului din cadrul continuumului îngrijirilor pentru a sublinia relațiile dintre tratament și managementul de caz. Principala diferență dintre cele două este faptul că

managementul de caz este centrat pe asistarea persoanelor cu consum de substanțe în obținerea resurselor de asistență necesare. Tratatamentul se centrează pe activități care ajută pacienții să recunoască extinderea problemei legate de consumul abuziv de substanțe, să câștige motivația necesară schimbării și instrumentele pentru a menține abstinanța, acolo unde este cazul sau pentru minimalizarea riscurilor asociate consumului. Funcțiile managementului de caz oglindesc stadiile tratamentului și recuperării. Dacă este implementat în mod adecvat, managementul de caz sprijină pacientul în timp ce parcurge acest continuum, încurajând participarea, progresul, menținerea și rezultatele pozitive. Implementarea funcțiilor managementului de caz depinde de mai mulți factori, inclusiv locul pacientului în continuum și nivelul motivației pentru schimbare, misiunea serviciului, pregătirea personalului, configurația echipei de management al asistenței, necesitățile populației țintă și disponibilitatea resurselor.

1. Angajarea

Identificarea cazului și pretratament

Angajarea, realizată în timpul fazei de dimensionare a cazului/pretratament este în mod particular o funcție proactivă. Managerul de caz trebuie să intervină frecvent și semnificativ, adesea într-o manieră non-tradițională, pentru a ajunge la pacient în loc să aștepte până când acesta caută ajutorul. Angajarea nu înseamnă numai întâlnirea cu pacienții și informarea acestora asupra resurselor existente. Activitățile de angajare au ca scop identificarea și rezolvarea necesităților imediate ale pacientului, adesea prin acțiuni directe pragmatice, începând de la procurarea unei perechi de șosete sau transportul până la doctor.

Această perioadă inițială este adesea dificilă. Motivația poate fi trecătoare iar accesul la servicii poate fi limitat. În multe situații, există o perioadă de așteptare semnificativă până la programarea evaluării sau stabilirii unei programări pentru intrarea în tratament. În scopul parcurgerii cu succes a acestei etape pot fi implicate persoane relevante din viața pacientului, care să încurajeze menținerea motivației de schimbare, iar insistența pacientului poate fi un factor cheie în accesarea serviciilor.

Pot apărea factori suplimentari în cazul în care pacientul este trimis din sistemul juridic. În această ipostază, pacienții pot fi refractari la tratament și pot refuza serviciile care li se oferă. Pacienții care încep tratamentul după o perioadă petrecută în detenție prezintă probleme semnificative de viață la care se poate răspunde simultan (cum ar fi o locuință sigură, bani sau alte probleme). Aceștia pot avea resentimente, rezistențe sau alte trăiri ce îngreunează procesul de angajare. Alții pot prezenta consum actual de substanțe sau pot fi implicați în activități ilegale. Pe de altă parte, solicitările impuse de sistemul de justiție trebuie, de asemenea, îndeplinite; acestea pot

fi în relație conflictuală cu atingerea altor scopuri, inclusiv participarea la tratamentul pentru consumul de substanțe.

Pacienții potențiali pot să nu fie familiarizați cu procesul de tratament. Așteptările lor cu privire la tratament pot să nu fie realiste și pot cunoaște foarte puține lucruri cu privire la consumul abuziv de substanțe și dependență. Adeseori se întâmplă ca persoanele din acest stadiu să minimizeze impactul consumului de substanțe sau al consumului abuziv asupra vieții lor. Acești factori se manifestă adeseori în comportamentul pacientului prin programări pierdute, continuarea consumului, scuze, apatie și lipsa dorinței de a realiza o schimbare.

Scopul managementului de caz în acest stadiu este de a reduce barierele, atât interne cât și externe, care interferează cu intrarea în tratament. Ezitarea pacientului în a se angaja în tratament poate fi redusă prin:

- (1) Abordări specifice interviului motivațional;
- (2) Educație de bază cu privire la dependență și recuperare;
- (3) Reamintirea consecințelor consumului abuziv de substanțe;
- (4) Asistență pentru rezolvarea necesităților de bază ale pacientului;
- (5) Angajare în dezvoltarea relațiilor manager de caz - pacient.

Evaluarea pentru orientarea către un program, coordonarea trimiterilor și lucrul pentru a reduce orice barieră administrative poate facilita accesul la servicii.

Procesul de motivare a unui pacient, începerea procesului de educare, identificarea necesităților esențiale și formarea unei relații poate începe din timpul interviului de evaluare. Abordările motivaționale sugerate de Miller și Rollnick încurajează angajarea pacientului mai mult prin măsuri exploratorii decât confruntative (Miller și Rollnick, 1991). Recunoscând că nu toți pacienții intră în tratament cu aceleași nivel motivațional ei construiesc stadiile de motivație pentru tratament descrise de Prochaska și DiClemente. Stadiile avansează de la lipsa de recunoaștere a existenței unei probleme (precontemplare) la contemplarea necesităților de tratament și asistență, la determinare, acțiune și în final la menținerea obiectivelor îndeplinite (Prochaska și DiClemente, 1982). Managementul de caz poate utiliza acest cadru pentru a angaja pacientul în serviciile adecvate stadiului. Aceasta înseamnă că persoanele care nu au decis să răspundă consumului lor abuziv de substanțe pot adeseori să fie cuprinse într-un tratament mai intensiv prin oferirea de suport de bază. Oferirea acestui suport poate avea un efect suplimentar în creșterea dezirabilității percepute sau continuarea consumului de substanțe și a stilului de viață asociat cu acesta.

Un interviu structurat oferă pacientului oportunitatea de a discuta despre consumul de droguri și istoricul acestuia împreună cu managerul de caz și de a explora pierderile care ar putea rezulta din acest consum. Pentru unii pacienți, acest istoric poate releva un patern de creștere a renunțării la

control (și probabil pierderea libertății). Revizuirea și discutarea pierderilor poate servi în motivarea pacienților de a avansa în tratament. Ascultarea empatică și exprimarea îngrijorării cu privire la bunăstarea pacientului poate facilita inițierea unei relații semnificative, suportive între pacient și managerul de caz și poate servi, de asemenea, în motivarea pacientului. O relație inițială bună între pacient și managerul de caz poate fi, de asemenea, neprețuită atunci când pacientul experimentează dificultăți mai târziu, pe parcursul procesului de asistență (Miller și Rollnick, 1991).

Pe lângă informațiile cu privire la consumul abuziv de substanțe și procesul de tratament, pacienții pot fi informați cu privire la solicitările și obligațiile managerului de caz sau programului managementului de caz și cu privire la solicitările care se așteaptă a fi îndeplinite din partea lor o dată cu intrarea în tratament. Acest tip de discuție prezintă o altă oportunitate de întărire a angajării participării la tratament. Chiar și în stadiile timpurii, pacienților trebuie să li se reamintească faptul că pentru recuperare sunt necesare schimbări permanente. În final, pacientului trebuie să i se răspundă la orice întrebare. Acest lucru poate fi important în special pentru pacienții trimiși de sistemul de justiție care ar putea fi confuzi într-o anumită măsură cu privire la cerințele sistemului, consecințele non-compliancei și dificultățile pe care le întâmpină în a răspunde acestor solicitări.

În timp ce managementul de caz în faza de pretratament poate avea ca scop orientarea pacienților spre un anumit program, angajarea nu este doar un “vino” la tratament. Mulți dintre pacienții viitori nu vor intra formal în tratament într-o perioadă definită dar, în limite flexibile, serviciile managementului de caz trebuie să fie disponibile pentru aceste persoane. Tranziția de la angajare la planificare este graduală.

Programul integrat de tratament (PIT)

Pentru pacienții care aleg să intre în tratament servește ca orientare a acestora în program. Orientarea implică explicarea regulilor și regulamentelor programului într-o măsură mai mare decât era posibilă sau necesară în pretratament. Managerul de caz conturează așteptările pacientului față de program și descrie ce așteaptă programul de la pacient. Persoana responsabilă cu oferirea managementului de caz unui anumit pacient se află în poziția unică de a asista adecvarea pacient - tratament. În timpul PIT, managerul de caz poate fi una dintre legăturile pacientului cu lumea din exterior, asistând pacientul în rezolvarea îngrijorărilor imediate care îi pot împiedica concentrarea pe rezolvarea scopurilor tratamentului principal – tratamentul consumului de substanțe.

Pe lângă orientarea pacienților în programele integrate de asistență, managerii de caz pot adecva serviciile la pacienții pe care îi trimit. Informațiile adunate în timpul fazei de pretratament pot oferi sprijin pentru procesul de tratament care rezultă în urma admiterii în PIT.

Asistența continuă

În timp ce se află în tratament, cea mai mare parte din timpul pacienților este petrecută pentru a înfrunța situația consumului de substanțe. Chiar dacă planificarea ieșirii din tratament a fost luată în considerare, este utilă evaluarea de zi cu zi pentru a adapta planul și serviciile la posibilele urgențe. Datorită relațiilor pe care le au cu pacienții și legăturilor cu comunitatea, managerii de caz sunt bine poziționați pentru a ajuta pacienții să realizeze o tranziție ușoară. Managerul de caz coordonează toate aspectele tratamentului pacientului. Această coordonare apare în cadrul unui anumit program, între program și servicii și între resurse. Capacitatea managerului de caz de a lucra în interesul pacientului va fi ghidată în egală măsură de autoritatea formală cu care a fost investită persoana de către ofertanții de servicii implicați și de relațiile informale pe care le stabilește.

Cunoștințele extensive ale managerului de caz cu privire la necesitățile realității lumii din care vine pacientul pot însemna un sprijin pentru pacientul care nu mai consumă. Pacienții au o serie de necesități, inclusiv necesitatea unei locuințe, a unui mediu sigur, fără droguri, a unei surse de venit, a unor abilități de lucru și a unui sistem de suport. Mulți au amânat asistența medicală sau stomatologică; în recuperare ei o pot solicita pentru prima dată după mulți ani. Odată ce individul se află în recuperare, medicația prescrisă de medic împotriva durerilor poate deveni o problemă majoră, o problemă care poate necesita coordonare și advocacy.

2. Evaluare

Diferența cea mai importantă dintre tratament și evaluările managementului de caz se reflectă în faptul că cea din urmă se concentrează pe necesitatea pacientului de a avea acces la resurse comunitare. Rezultatele evaluărilor, inclusiv deficitul cu privire la anumite abilități, necesitățile de suport, nivelul de funcționare și gradul de risc definesc scopul și orientează către un PIT.

Identificarea cazului și pretratament

În funcție de structura centrului care oferă managementul de caz, evaluarea poate începe odată cu angajarea. Rolul managerului de caz este de a explora necesitățile, dorințele, abilitățile, punctele tari și deficitul pacientului și de a utiliza aceste date în dezvoltarea unui plan individualizat de tratament, creat pentru a răspunde în mod eficient acestor necesități. Dacă persoana nu este eligibilă pentru un anumit serviciu din planul individualizat, managerul de caz face legătura dintre pacient și resursele de tratament externe adecvate. Acest proces include evaluarea eligibilității pacientului și gradul de adecvare pentru alte servicii și pentru un nivel specific de asistență în cadrul acestor servicii. Dacă persoana este atât eligibilă cât și adecvata pentru serviciu, rolul managerului de caz este de a angaja pacientul în tratament.

Program integrat de asistență (PIT)

Pentru pacienții care intră într-un program integrat, funcția de evaluare a managementului de caz, este asociată cu o evaluare focalizată pe probleme legate de procesul terapeutic – consum de substanțe, probleme psihologice și disfuncții familiale. Ambele evaluări sunt integrate în cadrul unei evaluări bio-psiho-sociale de proces (Wallace, 1990). Această evaluare bio-psiho-socială trebuie, cel puțin, să examineze situația pacienților în arii cum ar fi existența unei locuințe, situația financiară, starea de sănătate fizică și mintală, statusul profesional/educațional, gradul de suport social, relațiile familiale, modalitățile de petrecere a timpului liber, pentru transport și existența necesităților spirituale. De asemenea, sunt colectate informații detaliate cu privire la consumul de droguri, istoricul acestuia, istoricul problemelor de sănătate, probleme medicale curente, starea sănătății mintale, consum de alcool și droguri în familie. Această evaluare utilizată împreună cu evaluarea necesităților, asistă echipa de tratament în dezvoltarea unui plan formal de tratament (PIA) pentru a fi prezentat, adaptat și agreeat de către pacient. Aceste aspecte ale evaluării sunt realizate de o persoană sau de mai multe persoane. Acolo unde există o abordare de echipă, toți membrii echipei, inclusiv managerul de caz sau un alt profesionist care are acest rol, trebuie să își aducă experiența în această evaluare. Realizarea planificării și identificarea necesităților, în mod particular cu limitele curente de finanțare, începe la admiterea în programul integrat de asistență.

Managerul de caz, ca persoană responsabilă cu coordonarea diverselor servicii, trebuie să aibă o viziune generală asupra necesităților pacientului, să privească dincolo de terapia primară, îndeosebi la impactul dependenței pacientului în ariile de evaluare descrise, și să evalueze impactul problematicei depistate în recuperarea pacientului. Trebuie, de asemenea, să evalueze ariile specifice ale deficitelor la nivel de abilități, inclusiv abilități în viața personală, abilități de găsimă a unui loc de muncă, abilități sociale sau interpersonale. Persoanele care realizează această funcție trebuie să aibă cunoștințe ample și experiență în domeniul consumului de substanțe. Cu cât este mai mare numărul de probleme identificate și depășite de către pacient cu ajutorul managerului de caz în timpul programului integrat de tratament, cu atât mai mic va fi numărul de probleme la care pacientul trebuie să răspundă în timpul recuperării – și cu atât mai mari vor fi șansele de succes în tratament.

O evaluare trebuie să includă o revizuire a celor cinci arii funcționale. Acestea nu sunt exhaustive, dar încadrează dimensiunile esențiale ale necesităților (problematicei) asociate consumului care ar trebui explorate. Evaluarea pe arii de funcționare oferă date cu privire la gradul de afectare al pacientului și barierele în calea recuperării acestuia. Managerul de caz poate desfășura multe intervenții în interesul pacientului până când acesta va atinge stadiul dobândirii abilităților necesare.

Evaluarea din cadrul managementului de caz trebuie să includă o examinare a indicatorilor care delimitează gradul de risc față de propria persoană sau față de alții. Cu cât sunt mai mari deficitul în abilitățile sociale și interpersonale, cu atât este mai mare probabilitatea riscului față de propria persoană sau față de alții. Managerul de caz trebuie să aibă în vedere și cazierul judiciar. Dacă persoana se află în supravegherea sistemului de justiție, ofițerii de probațiune trebuie să fie contactați pentru a determina dacă există, sau nu, un potențial pentru comportament violent, ca și pentru a contura o măsură de suport în cazul în care apare o criză.

Asistența continuă

Capacitatea pacientului de reintegrare în comunitate reprezintă una dintre problemele pe care se concentrează evaluarea managementului de caz în cadrul continuumului de tratament. Deoarece managerul de caz este adesea în cadrul comunității, împreună cu pacientul, acesta se află într-o poziție excelentă pentru a evalua acest indicator. Pe parcursul programului integrat de tratament, evaluarea poate releva probleme noi, recurente sau nerezolvate pe care pacientul trebuie să le depășească înainte ca acestea să interfereze cu recuperarea. Potențialul de recădere reprezintă o provocare semnificativă, iar pacientul trebuie să fie capabil să identifice determinanții personali de recădere și să învețe cum să facă față acestora. Datorită faptului că managerii de caz sunt familiarizați cu comunitatea, pacienții și problemele legate de tratamentul pentru consumul abuziv de substanțe, ei pot identifica astfel de determinanți și pot interveni adecvat. Dacă, de exemplu, un manager de caz se teme că hotărârea unui pacient de a se întoarce în cartierul său poate duce la contactarea prietenilor consumatori de droguri, poate fi necesară o nouă rezidență.

3. Planificare, stabilirea scopurilor și implementare

Urmând în mod direct și logic procesul de evaluare, planificare, stabilirea scopurilor și implementarea cuprind fundamentele managementului de caz. Bazându-se pe o evaluare bio-psiho-socială, pacientul și managerul de caz identifică obiectivele în cadrul fiecărei arii relevante ale vieții utilizând punctele tari, necesitățile și dorințele anunțate în procesul de evaluare. Dezvoltarea unui plan individualizat de tratament și stabilirea obiectivelor sunt esențiale în managementul de caz (Ballew și Mink, 1996; Rothman, 1994; Sullivan, 1991). Acești autori sunt de acord în mai multe privințe: fiecare obiectiv din planul individualizat trebuie să fie defalcat în obiective operaționale/acțiuni și dacă este posibil chiar în etape mai mici sau strategii specifice din punct de vedere comportamental, măsurabile și realiste. În mod distinct, obiectivele măsurabile ajută pacienții să nu se simtă copleșiți pe de o parte, iar pe de alta, oferă indicatori de etapă care permit măsurarea progresului. Scopurile, obiectivele și strategiile trebuie să fie dezvoltate în colaborare cu pacientul. Acestea trebuie încadrate într-un context pozitiv – mai degrabă ca ceva ce trebuie îndeplinit decât ca ceva ce trebuie evitat. Trebuie identificat cadrul de timp pentru completarea obiectivelor și

strategiilor. Modelele prescurtate, ușor de utilizat, de planificare a tratamentului facilitează participarea pacientului în dezvoltarea unui plan. În acest context, devine esențială disponibilitatea personalului de a asista în planificarea, stabilirea obiectivelor și implementarea aspectelor managementului de caz cu privire la planul individualizat de tratament.

Atingerea cu succes a unui obiectiv trebuie să ofere pacientului satisfacția de a câștiga resursele dorite și de a demonstra reușita în atingerea acestuia. Eșecul în atingerea unui obiectiv trebuie să fie privit ca o oportunitate de reevaluare a eforturilor. În ultima situație, managerul de caz trebuie să fie pregătit să ajute pacientul, să vină cu abordări alternative sau să înceapă un proces de advocacy.

O abordare deliberată, atent considerată în identificarea obiectivelor unui pacient oferă beneficii care se extind dincolo de dobândirea capacităților dorite. Beneficiile pot rezulta din:

- Învățarea unui proces prin stabilirea sistematică a obiectivelor.
- Înțelegerea modalităților de îndeplinire a obiectivelor dorite prin intermediul îndeplinirii unor obiective mai mici – operaționale/acțiuni.
- Câștigarea controlului asupra propriei persoane și asupra mediului prin modalități de reflecție asupra posibilelor bariere în atingerea unui anumit scop sau obiectiv.
- Experimentarea procesului de accesare și acceptare a asistenței în stabilirea obiectivelor și îndeplinirea acestora.

Acestea și alte rezultate centrate pe individ, fac din planificare și stabilirea obiectivelor două procese la fel de importante ca rezultatele finale. Acesta este stadiul de acțiune al managementului de caz, în care pacientul participă în multe activități noi și poate avea multiple solicitări impuse de multiple servicii. Pot fi implicate multe tranziții semnificative și stresante – de la consumul de substanțe la abținerea, de la instituționalizare sau cadru rezidențial la reintegrarea în comunitate și de la grupul de egali consumatori de droguri sau alcool, la prieteni noi, abținerea. S-ar putea simți copleșiți, și se întâmplă adesea, ca în recuperare, în timp ce dezvoltă relații și stiluri de viață noi, pacienții pot experimenta sentimente de izolare și depresie determinate de suferința legată cu ceea ce au pierdut. În plus, presiunile reale legate de situația materială, angajare, locuință, reunirea cu copii sau grija față de aceștia pot fi foarte stresante.

Identificarea cazului și pretratamentul

În timpul fazei de pretratament planificarea funcțiilor managementului de caz se concentrează pe sprijinirea pacienților în rezolvarea necesităților imediate și facilitarea intrării în tratament. În mod ideal, profesionistul care implementează managementul de caz se întâlnește cu pacientul pentru a planifica obiectivele pentru dezvoltarea planului de servicii. Deși planificarea

și stabilirea obiectivelor sunt importante în acest stadiu precoce al asistenței, acestea pot fi dificile datorită interpunerii activităților de rezolvare a unor necesități imediate, ca și datorită posibilității continuării consumului. Managerul de caz poate decide să completeze un plan formal după ce o activitate a fost realizată și să o abordeze în cadrul discuțiilor cu pacientul. În cazul în care capacitatea unui pacient este diminuată din cauza consumului abuziv de substanțe și prezenței unor probleme multiple, serioase, managerul de caz va trebui să întârzie procesul de educare și formare a pacientului și să se bazeze pe propriile contacte, resurse și abilități. Pe măsură ce pacientul progresează în cadrul continuumului de tratament, managerul de caz poate direcționa din ce în ce mai mult responsabilitatea de acțiune asupra pacientului.

Pacienții care continua consumul în timp ce primesc servicii specifice managementului de caz reprezintă o dilemă semnificativă pentru managerul de caz. Pe de o parte, pacientul poate să nu dorească sau să nu fie capabil să participe în tratament; pe de altă parte, ofertanții de tratament în mod normal așteaptă un angajament de abținere înainte ca persoanele să înceapă procesul de tratament. Ca urmare, managerul de caz trebuie să negocieze cadrul comun între pacient și program. De exemplu, un manager de caz poate solicita pacientului să identifice și să progreseze în obiectivele stabilite mutual înainte de a intra în tratament. Structurată corect, o astfel de abordare are un succes garantat. Îndeplinirea acestor obiective fie elimină necesitățile pacienților de tratament, fie îi pregătește pentru a accepta mai hotărât tratamentul. Chiar dacă persoana nu dorește sau nu poate să îndeplinească aceste obiective, managerul de caz poate da informații suplimentare în încercarea de a motiva pacientului să solicite tratament.

Programul integrat de tratament (PIT)

În cadrul programului integrat de tratament, managerul de caz și pacientul dezvoltă un plan individualizat de servicii care identifică și propune strategii pentru a răspunde necesităților pe termen scurt și lung ale pacientului. Planul trebuie să reflecte nivelul și intensitatea serviciilor împreună cu obiectivele specifice ale pacientului. Teoretic, toți pacienții au multiple necesități; în consecință, planul individualizat de servicii trebuie să fie structurat astfel încât să se centreze și să răspundă problemelor pacienților ce participă la tratament. Perspectiva în care o persoană poate lăsa la o parte lipsa locuinței, problemele legate de un loc de muncă sau un copil bolnav pentru a se concentra exclusiv pe tratamentul pentru dependență și recuperare este nerealistă și pregătește eșecul atât al ofertantului de servicii cât și al pacientului. Din acest motiv, este necesar adesea, ca atât pacientul cât și managerul de caz să realizeze o ierarhizare a problemelor în sensul prioritizării acestora.

În cadrul programului integrat de tratament, în faza de planificare și implementare, managerul de caz trebuie:

- (1) să continue motivarea pacientului pentru a păstra angajarea acestuia și pentru a progresa în tratament;
- (2) să organizeze timpul și implicarea serviciilor pentru a facilita atingerea obiectivelor;
- (3) să ofere sprijin în timpul tranzițiilor;
- (4) să intervină pentru a evita sau să răspundă la situațiile de criză
- (5) să dezvolte structuri de suport extern pentru a facilita integrarea susținută în comunitate.

Tehnicile managementului de caz trebuie să fie create pentru a reduce barierele interne ale pacientului dar și barierele externe care pot împiedica progresul.

Este foarte important să se ofere constant motivație pacientului de-a lungul continuumului de servicii. Pacienții au nevoie de încurajare pentru a accepta intrarea în program, pentru a rămâne în program și pentru a continua să progreseze. Managerul de caz trebuie să caute continuu modalitățile de stimulare specifice pacientului. Pacienții sunt încurajați de diferiți factori dar putem spune și că, același pacient poate răspunde în mod diferit în funcție de situație. De exemplu, mulți pacienți trimiși din sistemul de justiție vor fi motivați inițial să încerce tratamentul pentru a evita pedeapsa cu închisoarea; aceștia ar putea fi motivați să rămână în tratament din motive foarte diferite (de exemplu, încep să se simtă mai bine, speră să-și recâștige copiii). Pe de altă parte, procesul de tratament este dificil și mulți pacienți se pot descuraja după entuziasmul inițial. Recuperarea poate solicita explorarea unor probleme inconfortabile. Poate rezulta disconfort fizic și depresie. Managerii de caz pot oferi sprijin în timpul acestor perioade prin oferirea de informații cu privire la tehnici de coping, cum ar fi exerciții, diete, activități de recreere. Dacă depresia este semnificativă, managerii de caz pot lucra împreună cu consilieri psihologici, psihoterapeuți sau psihiatrii pentru a realiza o evaluare a stării de sănătate mintală și, dacă este cazul, pacienții pot fi încurajați să caute suport terapeutic suplimentar pentru depresie. Asistența empatică continuă poate, de asemenea, să motiveze pacienții.

Pot fi utilizate de asemenea, intervenții cu caracter de descurajare. De exemplu, managerul de caz poate reaminti pacienților despre rezultatul terminării premature a tratamentului – pentru unii acest lucru ar putea însemna întoarcerea în închisoare, pentru alții poate însemna confruntarea cu consecințele comportamentului adictiv privind sănătatea sau siguranța individuală. Pentru pacienții care se află sub controlul sistemului de justiție ar putea fi necesare sancțiuni, inclusiv revenirea în penitenciar pentru a obține reangajarea și motivația.

Un alt rol fundamental al managementului de caz în timpul fazei de tratament activ este coordonarea programărilor diferitelor intervenții pentru îndeplinirea obiectivelor. Managerul de caz trebuie să lucreze cu pacientul

pentru a echilibra interesele concurente și pentru a dezvolta strategii care să răspundă necesităților de bază ale pacientului pe perioada în care se află în program. De exemplu, există posibilitatea ca managerul de caz să trebuiască să negocieze între probațiune și tratament pentru a asigura posibilitatea pacientului de a participa la ședințele de tratament și să se poată întâlni cu ofițerul de probațiune. Unele activități necesită elaborarea unui scenariu pentru a asigura aplicarea acestora la timpul potrivit, în ordinea corectă. Pacienții care nu au un loc de muncă și nu au abilități profesionale, de exemplu, managerul de caz trebuie să inițieze activități de pregătire imediat după stabilizare. Aceștia vor necesita sprijin suplimentar pentru căutarea unui loc de muncă și păstrarea acestuia. Se întâmplă foarte frecvent ca o dată stabilizați, pacienții să se simtă foarte puternici. În această situație, sarcina managerului de caz este de a îndruma pacienții să avanseze încet, să își asume pe rând câte o responsabilitate. Acest lucru poate fi dificil în mod special pentru femei care sunt nerăbdătoare să revină la copii.

Tranziția între servicii – de la programe instituționale la tratament rezidențial; de la tratament rezidențial la ambulator; sau la niveluri de intensitate mai mica în cadrul unei structuri ambulatorii – este întotdeauna stresantă și atrage frecvent recăderea. Pentru a evita situațiile de criză în timpul tranzițiilor, managerii de caz trebuie să intensifice legătura cu pacienții. Managerii de caz trebuie să lucreze pentru a se asigura că lanțul serviciilor nu este întrerupt. Acolo unde este posibil, datele de ieșire trebuie să fie coordonate pentru a coincide cu intrarea în serviciul următor.

Dacă persoana se află sub controlul sistemului de justiție, managerul de caz trebuie să se asigure că supervizarea activităților rămâne aceeași sau crește pe măsură ce activitatea în tratament descrește. Foarte frecvent se întâmplă ca un pacient care încheie șederea într-un serviciu de tratament să fie în același timp transferat la un nivel de intensitate mai mica. Acest lucru elimină, în același timp, orice suport. Dacă este posibil, activitățile de supraveghere și tratament trebuie să fie coordonate pentru a promova gradual progresul spre autonomie și pentru a reduce posibilitatea de recădere.

Pe lângă activitățile desemnate pentru a evita crizele sau recăderile, managerul de caz trebuie să fie capabil să răspundă crizelor și recăderilor, atunci când acestea apar. În multe cazuri, managerul de caz este cel care trebuie să preia inițiativa. Managerul de caz trebuie să fie frecvent în contact cu serviciile de asistență pentru a verifica participarea și progresul pacientului. Lipsa de participare și/sau progresul scăzut poate semnală o criză iminentă. În aceste cazuri trebuie programată o ședință în legătură cu aceste situații. Ședința poate rezolva problemele și preveni încheierea imediată a tratamentului.

Violența îndreptată spre personal sau alți pacienți este o situație evident de excludere imediată din program, dar alte încălcări ale obligațiilor pacientului nu atrag în mod necesar excluderea. Echipa care realizează managementul

de caz și pacientul trebuie să lucreze împreună pentru a dezvolta alternative pentru menținerea în program. Dacă excluderea din tratament este sigura alternativă, există posibilitatea ca un pacient să fie readmis după o reevaluare, și după ce pacientul „își revizuieste atitudinea” și se re-angajează în tratament și să respecte regulile.

S-a dezvoltat un model de ședință pentru asistarea pacienților cu probleme juridice. La aceste ședințe participă managerul de caz, consilierul psihologic/psihoterapeutul, ofițerul de probațiune, pacientul și orice alte persoane implicate în caz. Scopul ședinței este de a confrunța pacientul cu problema și de a discuta rezolvarea acesteia prin lucrul în echipă. Pacientul trebuie să își dea consimțământul în scris legat de rezolvarea propusă. Acest model oferă un avertisment clar pacientului (trei ședințe de acest fel pot avea ca rezultat excluderea pacientului), reduce presiunea abordării pacientului din trei direcții diferite sau manipularea pacientului ca rezultat al lipsei de coordonare a părților și reunește abilitățile și resursele multiplelor servicii și profesioniști.

Asistența continuă

Unul dintre rolurile anticipative ale managementului de caz în timpul derulării unui program integrat de tratament este planificarea serviciilor care îl compun, ieșirea din program și reintrarea în comunitate. În timpul programului integrat managerul de caz ajută pacientul să dobândească abilități de bază necesare pentru a funcționa independent în comunitate, inclusiv modalități de câștigare a resurselor financiare, învățarea rolului de părinte sau de gospodărire a locuinței. Scopurile pe termen scurt sunt treptat înlocuite cu scopurile pe termen lung de integrare a individului într-un stil de viață fără drog. Acolo unde este cazul, planurile serviciului trebuie să reflecte o focalizare pe acceptarea de către pacient a responsabilității pentru propriile acțiuni. Intervenția managementului de caz poate crește sau descrește în funcție de răspunsul pacientului la autonomie și progresul reintegrării în comunitate.

4. Crearea de legături, monitorizare și advocacy

Există cercetări care sugerează că unele persoane cu probleme legate de consumul de substanțe preferă, în general, să acceseze serviciile în mod independent, fără intervenția managerului de caz. Acestea au adesea probleme în utilizarea eficientă a serviciilor (Ashery și alții, 1995). Aici este punctul în care crearea de legături, monitorizarea continuă și, în multe cazuri, activitatea de advocacy pot fi valoroase. O funcție suplimentară de maximă importanță a managementului de caz este cea de coordonare a diferiților ofertanți și de integrare a acestora într-un tot unitar.

Crearea de legături înseamnă mai mult decât punerea la dispoziția pacientului a unei liste cu resursele disponibile. Managerii de caz trebuie să

lucreze pentru a dezvolta o rețea de resurse formale și informale și contacte pentru a oferi pacienților serviciile necesare.

Identificarea cazului și pretratament

Managerii de caz pot fi în special activi în crearea de legături și activități de advocacy în timpul fazei de pretratament a continuumului de asistență. La fel ca în cazul fiecăreia dintre funcțiile managementului de caz, rădăcinile interrelației cu pacientul încep mult mai devreme, în timpul realizării evaluării și al stabilirii obiectivelor. Au fost identificate cinci sarcini legate de interrelație înainte de contactul propriu-zis cu resursele necesare. Managerii de caz trebuie:

- (1) să stimuleze angajarea pacientului în contactarea serviciilor;
- (2) să planifice contactarea serviciilor;
- (3) să analizeze potențialele obstacole;
- (4) să modeleze și să întărească aderența la servicii;
- (5) să prezinte primii pași pacientului (Ballew și Mink, 1996).

Programul integrat de asistență (PIT)

După ce este făcută conexiunea, managerul de caz trece la monitorizarea adecvării relației pacient - resurse. Monitorizarea progresului pacientului și ajustarea planurilor de servicii în funcție de necesități reprezintă o funcție esențială a managementului de caz. În plus, se asociază necesitatea de a împărtăși informațiile relevante cu pacientul și cu celelalte părți implicate. De exemplu, dacă rezultatele testării prezenței drogului în organism sunt pozitive în cazul unui pacient provenit din sistemul de justiție, atât consilierul cât și ofițerul de probațiune trebuie să știe. Dacă managerul de caz a luat la cunoștință existența unor probleme ale pacientului la locul de muncă, ar putea fi necesar ca această informație să fie împărtășită cu ofertantul de servicii în limitele regulilor de confidențialitate.

Managerii de caz care sunt responsabili de consumatori delincvenți aflați în tratament pot superviza testarea regulată. Aceasta este o modalitate eficientă de a obține informații obiective cu privire la consumul de drog al pacientului ca și pentru structurarea limitelor pentru pacient pentru a ajuta la prevenirea recăderilor. Activitatea de advocacy vorbește în interesul pacientului. Advocacy poate fi precipitat de oricare din următoarele evenimente:

- Un pacient este refuzat de anumite servicii datorită discriminării, chiar dacă discriminarea este bazată pe unele aspecte intrinseci ale pacientului, cum ar fi gen sau etnie sau natura problemelor pacientului, cum ar fi dependența.

- Un pacient este refuzat de servicii deși îndeplinește criteriile de eligibilitate.
- Un pacient este exclus de către servicii pentru alte motive decât cele prevăzute de regulamentele serviciilor respective.
- Un pacient este refuzat de servicii deoarece acestea au mai fost accesate anterior și nu au fost utilizate.
- Managerul de caz crede că serviciul poate fi extins pentru a răspunde necesităților pacientului fără a afecta natura de bază a serviciului.

Advocacy-ul în interesul pacientului trebuie să fie întotdeauna direcționat și profesional. Advocacy poate lua multe forme, de la o discuție deschisă cu un coordonator de serviciu sau centru sau cu un angajat, la o scrisoare adresată judecătorului/procurorului sau ofițerului de probațiune, pentru a primi reasigurarea oferirii serviciului respectiv. Advocacy-ul, adesea, implică educarea ofertanților de servicii în sensul renunțării la miturile în care ar putea crede cu privire la consumatorii de substanțe, sau să amelioreze interacțiunile negative care ar putea avea loc între pacient și ofertantul de servicii. Acest lucru este important în mod special pentru anumite grupuri cu care serviciile nu doresc să lucreze, cum ar fi pacienții cu HIV/SIDA sau pacienții proveniți din sistemul de justiție.

O activitate de advocacy mai complicată implică, de exemplu, atacarea unei hotărâri luate de membru al personalului serviciului, în mod ierarhic, până la nivelurile înalte de autoritate în cadrul unei instituții. Cele mai înalte, cele mai implicate niveluri de advocacy includ organizarea unui răspuns comunitar față de o anumită situație sau inițierea unui demers juridic. Modcrin și colegii (1985) oferă o rețea strategică de advocacy care poate ajuta managerii de caz să planifice sistematic eforturile de advocacy. Din această perspectivă, nivelurile la care advocacy poate fi efectuat (individual, administrativ sau politic) se compară cu diverse abordări (pozitive, negative sau naturale). La trei răspunsuri negative pe un anumit nivel conduc la creșterea efortului de advocacy, după înțelegerea punctului de vedere al instituției care desfășoară serviciul și după consultarea cu personalul de supervizare. (Sullivan, 1991).

Advocacy-ul centrat pe pacient trebuie întotdeauna să fie adaptat spre îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul individualizat de asistență. Advocacy nu înseamnă că întotdeauna pacientul obține ceea ce dorește. În mod special în cazul pacienților al căror consum continuu de droguri sau întreruperea tratamentului ar prezenta consecințe negative considerabile cum ar fi închisoarea sau moartea, advocacy poate însemna a face orice pentru a-i ține în tratament, chiar dacă acest lucru înseamnă a-i trimite către penitenciar pentru stabilizare. De fapt, adeseori se întâmplă ca, în momentul în care tratamentul devine dificil, pacienții să declare preferința lor pentru închisoare. Chiar atunci când se realizează advocacy-ul pentru pacienți, managerul de caz trebuie să respecte limitele sistemului. De exemplu, un manager de caz poate negocia cu dificultate reținerea un

pacient delincvent în tratamentul bazat pe comunitate, dar să fie de acord să informeze ofițerul de probațiune cu privire la testele pozitive la drog sau comportament ilegal suspicionat. În timp ce advocacy-ul pentru anumite grupuri de pacienți este esențial, preocuparea pentru pacient nu ar trebui să depășească scopurile siguranței publice. Advocacy-ul centrat pe pacient poate pune managerul de caz în poziție de conflict cu colegii de lucru, coordonatori de centre sau servicii sau chiar cu supervizorii. Managerul de caz care face advocacy pentru extra-beneficii pentru pacienții lor se pot expune unui pericol atât pe ei și supervizorii lor cât și sursele de finanțare. Va fi utilă o infrastructură coordonată cu politicile și procedurile existente pentru o colaborare centrată pe pacient.

5. Terminarea programului

Ieșirea din structurile managementului de caz, cum ar fi finalizarea serviciilor clinice, nu este un eveniment ci un proces. Într-un fel, procesul începe în timpul angajării. Atât pentru pacient cât și pentru managerul de caz, aceasta implică separare atât fizică cât și emoțională, având loc o dată ce pacientul a dezvoltat un sens al autoeficienței și este capabil să funcționeze autonom. La un nivel semnificativ, această hotărâre poate fi bazată pe progresul definit de planul individualizat. Dacă planul a fost desfășurat cu adevărat cu implicarea activă a pacientului, vor exista informații obiective semnificative care vor ajuta atât managerul de caz cât și pacientul să hotărască momentul în care finalizarea este adecvată. Este de preferat ca aceasta să fie planificată și deliberată decât ca relația să se încheie în urma unor întâlniri pierdute, fără un rezumat al pacientului și profesionistului cu privire la ceea ce s-a învățat. Finalizarea formală oferă pacientului oportunitatea de a explora ceea ce a învățat despre interacțiunea cu ofertanții de servicii și despre stabilirea și realizarea obiectivelor. Managerul de caz are șansa de a auzi de la pacienți ceea ce ei consideră benefic – sau nefavorabil în relații. Revizuirea și rezumarea progresului pacientului poate reprezenta un aspect important de consolidare a beneficiilor pacientului și de încurajare a viitoarelor abilități de a accesa singuri resursele.

MANAGERUL DE CAZ ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII PRINCIPALE:

- a) primirea și informarea cu privire la serviciile pentru consumatorii de droguri;
- b) oferă evaluare și reevaluare continuă pe **cinci** arii principale;
- c) realizează trimiteri/planificări pentru realizarea evaluării medicale, psihologice și sociale;
- d) recunoaște aspectele personale, familiale și sociale care pot sprijini sau pot fi obstacole pentru PIT;

- e) orientează beneficiarul în funcție de rezultatele evaluării în vederea includerii într-un program integrat terapeutic, în funcție de serviciile existente;
- f) stabilește împreună cu beneficiarul obiectivele principale pe cele cinci arii evaluate și elaborează planul individualizat de asistență;
- g) realizează balanța dintre nevoile depistate în urma evaluării și serviciile existente;
- h) face trimiterile spre resursele necesare și realizează demersurile necesare obținerii includerii beneficiarului în acestea.
- i) monitorizarea continuă a planului individualizat;
- j) oferă sprijin în pregătirea beneficiarului pentru intrarea în programul integrat;
- k) oferă servicii directe din cadrul planului individualizat în funcție de pregătirea sa;
- l) răspunde la situațiile de criză;
- m) sprijină dezvoltarea resurselor informale de suport;
- n) se angajează în advocacy pentru beneficiar;
- o) se angajează în advocacy pentru dezvoltarea resurselor din circuitul terapeutic integrat;
- p) consilierea, orientarea și ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare obținerii drepturilor sociale;
- q) participarea la monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor pentru consumatorii de droguri;
- r) participă la elaborarea strategiilor și planurilor de asistență medicală, psihologică și socială naționale, județene și, după caz, locale.

🔗 PUNCTE CHEIE

- o Introducerea managementului de caz în asistența consumatorilor de droguri se constituie într-un mijloc de suport, atât pentru pacient și familia acestuia, prin crearea unui punct unic și sigur de legătură cu sistemul de asistență, cât și pentru sistem și servicii, prin realizarea unui continuum de asistență, corelarea datelor, cunoașterea istoricului clinic și realizarea unei rețele funcționale.
 - o Managerul de caz, prin poziția sa, oferă suport structural și funcțional fiecărui caz în parte, dar aceasta nu exclude aplicarea abilităților clinice în evaluare, planificare și monitorizare.
 - o Funcțiile managementului de caz sunt: evaluarea, planificarea, crearea de legături de colaborare, monitorizarea, advocacy. Acestea se aplică în toate etapele evoluției fiecărui caz: identificare și pretratament, program integrat de asistență și asistență continuă.
 - o Poziția managementului de caz în cadrul circuitului de asistență este una de atragere, evaluare, coordonare și monitorizare, și nu trebuie confundată cu alte poziții de responsabilitate: coordonare, responsabil de program, manager sau director al unui centru sau serviciu, supervisor sau persoana care colectează datele. Mici segmente din cele enumerate se regăsesc în funcțiile managerului de caz, dar nu au caracter definitoriu, ci de corelare.
-

VII. REINSERTIA SOCIALĂ A CONSUMATORILOR DE DROGURI

Reinsertia socială a consumatorilor de droguri, ca obiectiv final, este bazată pe **trei criterii**:

- Face parte dintr-un plan global care înțelege abordarea aspectelor biologice, psihologice și sociale ale problemei și intervenția asupra individului, mediului acestuia și comunității.
- Trebuie să se sprijine pe resursele personale și sociale ale subiectului, achiziționate în prealabil, recuperate sau potențiale.
- Agenții, resursele, serviciile comunitare și participarea activă a cetățenilor sunt indispensabile pentru orice acțiune de socializare.

OBIECTIVE:

- Normalizarea situației personale și sociale a persoanelor cu probleme de dependență.
- Sensibilizarea societății, transmitând populației o viziune asupra dependenței de droguri ajustată la realitate, pentru a facilita atitudinile sociale cele mai eficace și solidare.
- Întărirea rețelilor comunitare de sprijin social și colaborare cu inițiativa socială.
- Dotarea centrelor și resurselor specifice, înțelese ca fiind complementare și tranzitorii resurselor specializate.
- Oferirea unui spațiu de coabitare și primire persoanelor dependente de droguri care, intrând într-un program terapeutic, răspund unui profil tranzitoriu, sau care au un grad crescut de marginalizare care împiedică continuarea procesului terapeutic. Permite, de asemenea, îndeplinirea alternativei la pedeapsă.
- Sprijinirea și întărirea stabilizării procesului terapeutic (inclusiv tratamentul farmacologic) dezvoltând intervenții cu caracter socio-educativ care facilitează procesul de ajustare a necesităților de bază ale consumatorilor și integrarea progresivă în contexte normalizate a dependenților de droguri fără adăpost, a celor care locuiesc cu dependenți de droguri sau care au o familie destructurată.

- Oferirea unui spațiu de coabitare și rezidențial normalizat care sprijină și întărește procesul de reabilitare-reinserție a dependenților de droguri fără adăpost, a celor care locuiesc cu dependenți de droguri sau care au o familie destructurată.
- Oferirea unui spațiu rezidențial și de coabitare în regim de autogestionare, pentru obținerea unei vieți autonome, de sprijin pentru reinserția dependenților de droguri care se află în apartamentele de sprijin.
- Facilitarea procesului de inserție/reinserție oferind un răspuns integral prin intermediul modelelor educative, întărind și potențând capacitățile intelectuale și cognitive de bază și superioare, adaptându-se la necesitățile educative speciale

ARII DE INTERVENȚIE ÎN PROCESELE DE REINSERȚIE:

1. **Personal și social.** Achiziționarea de norme de coabitare, întărirea atitudinilor pozitive față de persoanele neconsumatoare și promovarea utilizării resurselor comunitare.

2. **Formare profesională.** Dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor și tehnicilor profesionale.

3. **Angajare.** Căutarea și obținerea unui serviciu remunerat

4. **Educativ și cultural.** Obținerea unui nivel educativ, cultural și ludic suficient pentru a înțelege și participa la viața socială.

5. **Stabilizarea situației juridice penale și civile**

6. **Intervenție comunitară.** Coordonarea, sprijinul tehnic și colaborarea cu entități publice și de inițiativă socială. Întărirea serviciilor sociale comunitare.

PROMOVAREA ALTERNETIVELOR PROFESIONALE PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE DE DROGURI

Sunt programe specifice de inserție adresate persoanelor dependente de droguri aflate în tratament, care, din cauza situației personale sociale și a absenței sau insuficienței formării sau experienței profesionale sunt defavorizați pe piața muncii. Obiectivul este propunerea unui itinerariu care să faciliteze achiziționarea unor abilități profesionale, formarea tehnică specializată, accesul la un loc de muncă. Sunt servicii de însoțire pentru încadrarea socio-profesională. Acest serviciu își propune să faciliteze inserția profesională a beneficiarilor, utilizând în special instrumentele de formare și gestionare a abilităților personale în mediul unei economii de piață. Se dezvoltă prin intermediul sprijinului tehnic permanent al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

OBIECTIV GENERAL:

- „Articularea” mecanismelor de însoțire a persoanelor dependente care facilitează punerea în mișcare și obținerea unor procese integrate de încadrare socială și profesională.
- Facilitarea inserției profesionale a dependenților de droguri, intensificând inițiativele de auto-angajare și angajare.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Promovarea activităților care facilitează apropierea persoanelor dependente de piața de muncă.
- Facilitarea dezvoltării atitudinilor necesare pentru integrarea socio-profesională.
- Implicarea agenților sociali care pot facilita integrarea socio-profesională.
- Dezvoltarea proceselor formative care favorizează formarea profesională și inserția socio-profesională a beneficiarilor.
- Structurarea proceselor de inserție socio-profesională cu scopul de a favoriza crearea de întreprinderi prin formarea tehnică, impresarială și de administrare/conducere asistată.
- Intensificarea potențialului de angajare prin auto-angajarea colectivă și angajarea autonomă.
- Stabilirea mecanismelor de cooperare împreună cu agenți sociali implicați în rețeaua de asistență.
- Facilitarea accesului la piața de muncă a dependenților de droguri aflați în tratament care, din lipsă de formare sau experiență de lucru, prezintă dificultăți de încadrare pe piața muncii.

SERVICII:

Orientare socio-profesională

- Informare și orientare socio-profesională individuală și/sau de grup.
- De grup: Ateliere de formare de competențe cheie pentru angajare; grupuri pentru căutarea activă a unui loc de muncă

Intermediere

- Bursă pentru cererea și oferta de angajare.
- Serviciu de depistare a ofertei de pe piața muncii
- Însoțirea la locul de muncă.

Educare și Formare profesională. Acestea au o funcție triplă:

- Achiziționarea unor cunoștințe profesionale tehnice

- Dezvoltarea de abilități de lucru, de coabitare și de relaționare în grup
- Orientarea profesională
- Formarea tehnică în inserția socio-profesională.
- Educație și formare antreprenorială.
- Conducere/administrare asistată și crearea de întreprinderi
- Asistență specializată pentru femeile dependente de droguri
- Programe de inițiere: potențarea, dezvoltarea și/sau amintirea cunoștințelor deja achiziționate.
- Alfabetizare: inițiere (citit-scris, numere, concepte, operațiuni de bază).
- Obținerea unui nivel de bază de exprimare și înțelegere a conceptelor matematice și de limbaj. Creșterea nivelului cultural.
- Pregătire pentru absolvire: pregătire pentru absolvirea liceului.
- Programe de sprijin: oferirea strategiilor și instrumentelor necesare pentru sprijinirea cursurilor realizate până în momentul actual.
- Programe de cunoștințe deschise: canalizarea propunerilor educative către interesele și solicitările cursanților. De exemplu: atelier de engleză, atelier de informatică.
- Program de limba: cunoașterea limbii. Inițierea în cunoștințele culturale.

RESURSE SPECIFICE PENTRU REINSERȚIE

- Centre de coabitare
- Centre de coabitare și sprijin pentru tratament și reinserție
- Centre de coabitare cu autogestionare de sprijin pentru reinserție
- Centre socio-educative
- Centre de orientare socio-profesională
- Centre de promovare a alternativelor profesionale
- Ateliere de formare profesională
- Centre de coabitare și sprijin în tratamentul și reinserția minorilor dependenți de droguri
- Ateliere educative, de distracție și de petrecere a timpului liber
- Ateliere pentru dezvoltarea abilităților sociale.
- Servicii de căutare a unui loc de muncă.
- Centre de coabitare pentru îndeplinirea pedepsei
- Servicii de intervenție în centre penitenciare.
- Servicii de informare, orientare și evaluare directă prin telefon.

ANEXE

Agencia Națională Antidrog
Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog:

RAPORT EVALUARE

Nr. _____

Data: _____

I. DATE DESPRE CONSUMATOR:

Numele/prenume: _____ fiul lui _____ și al _____
domiciliat în _____,
posesor BI seria _____ nr. _____;

Reprezentant legal (se completează după caz)

Cod. consumator _____

Rezumat/Narativ: _____

II. Rezultat evaluare arii:

1. _____	Specialist: _____
2. _____	Specialist: _____
3. _____	Specialist: _____
4. _____	Specialist: _____
5. _____	Specialist: _____

(Semnătura și, după caz, parafa
specialistului)

III. Expertiza medico-legală (după caz) _____

IV. Recomandări

1. Lista problemelor pe arii

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

2. Program integrat de asistență propus _____

3. Modalități/Intervenții recomandate pentru problemele active:

4. Criterii:

5. Planificare:

6. Furnizori disponibili și/sau necesari:

V. Alte date _____

Coordonator centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog:

Manager de caz:

EVALUAREA DE PROCES ȘI ÎNAINTE DE IEȘIRE

1. DATE DE IDENTIFICARE

Numele/prenume: _____ fiul lui _____ și al _____
domiciliat în _____, posesor
BI seria _____ nr. _____;

Reprezentant legal (se completează după caz)

Cod. consumator _____

2. EVALUARE ÎN CENTRU

2.1. Data de intrare

2.2. Prima evaluare

2.3. Dezintoxicare

2.4. A doua evaluare

2.5. Data semnării acordului terapeutic

2.6. Data de includere în PIT

3. PROFESIONIȘTI DE REFERINȚĂ

PROFESIONIST

NUME

4. VARIABLE OPERAȚIONALE

1.1. Asistență

Programe/Ateliere	Nr. de absențe ale consumatorului		Nr. total de ședințe	%
	Nejustificate	Justificate		

TOTAL

1.2. Punctualitate

- De obicei este punctual.
- Frecvent nepunctual
- Nu intră ocazional din cauza întârzierilor

OBSERVAȚII:

1.3. Participare

PARTICIPARE	Adecvată	Insuficientă	Disruptivă	Altele
Programe				
Ateliere				
Altele				

1.4. Sarcini

	BINE	SATISFĂCĂTOR	NESATISFĂCĂTOR
De obicei le realizează			
Le realizează ocazional			
Le realizează doar stimulat			
Nu le realizează			

OBSERVAȚII:

1.5. Alunecări ocazionale

S		Declarat	Nedeclarat	Nu asistă	Total
U	Heroină				
B	Cocaină				
S					
T					
A					
N					
T					
E					

1.6. Enumerarea evaluărilor

Data	Motivul	Recomandarea

OBSERVAȚII:

5. INCIDENTE

- Probleme punctuale apărute:
- Consum de alcool, hașiș etc:

6. URMĂRIREA OBIECTIVELOR

Revizuirea obiectivelor propuse:

- Pe termen scurt, mediu și lung.
- Pe arii (medical, psihologic, social).

7. OBIECTIVE DE ÎNDEPLINIT

- Pe arii (medical, psihologic, social)
- Prioritate în timp

ACORD DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI SOCIALĂ

Între :

**CENTRU DE EVALUARE, PREVENIRE ȘI CONSILIERE ANTIDROG
SAU FURNIZOR DE SERVICII**

Manager de caz sau Responsabil centru

și

CONSUMATOR

Nume/prenume:

B.I./C.I./Pașaport nr.

Cod:

Data includere:

Data ieșire:

1. OBIECTUL ACORDULUI:

Art. 1 - Obiectivul acordului constă în stabilirea unui cadru de raporturi între consumator și centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, ca urmare a includerii consumatorului în circuitul integrat de asistență.

2. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:

Art. 2- Consumatorul are **dreptul:**

- a) La informații cu privire la diferitele servicii și resurse existente.
- b) La informații cu privire la procesul terapeutic pe care îl parcurge, în orice fază a acestuia.
- c) La asistență în cadrul rețelei de asistență, adecvată la planul individualizat de asistență și la includerea pe lista de așteptare în condițiile în care unul dintre serviciile selectate este pentru moment ocupat.
- d) La alegerea uneia dintre diferitele recomandări propuse de managerul de caz pe baza evaluării și informării cu rezultatele acesteia sau de a refuza ceea ce este echivalat cu consimțământul informat de ieșire din program.
- e) La respect față de personalitatea, demnitatea și intimitatea sa.
- f) La confidențialitate față de toate informațiile referitoare la procesul de tratament în conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

- g) La eliberarea unei legitimații gratuite care să certifice includerea în program.
- h) La participarea familiei sau a unei persoane relevante pentru beneficiar, pe care acesta o consideră utilă în procesul terapeutic în conformitate cu regulamentul centrului respectiv.
- i) La întreruperea voluntară în oricare din fazele programului de asistență în condițiile manifestării consimțământului informat.
- j) La informare în cazul în care unul din serviciile din cadrul programului pe care le primește face parte dintr-un proiect de cercetare.
- k) La informare cu privire la regulamentele de organizare și funcționare a furnizorilor de servicii pe care le accesează.

Art. 3- Consumatorul are următoarele **obligații**:

- a) Să respecte măsurile de asistență din planul individualizat, anexă la acord.
- b) Să îndeplinească toate recomandările primite pe parcursul programului.
- c) Să respecte regulamentul de organizare interioară a furnizorului și regimul de asistență al acestuia.
- d) Să se supună testelor de prezență a drogurilor solicitate și la probele recomandate stabilirii diagnosticului sau necesare pe parcursul tratamentului.
- e) Să nu inducă în eroare refuzând sau înlocuind mostre de urină.
- f) Să participe la măsurile de asistență în condițiile prevăzute în planul individualizat de tratament.
- g) Să semneze voluntar consimțământul informat în caz de renunțare la asistență.
- h) Să răspundă la întrebările care i se pun în desfășurarea tratamentului și să ofere, cu sinceritate, toate datele și documentele necesare pentru o desfășurare mai bună a procesului terapeutic.
- i) Să nu manifeste comportamente agresive fizice sau verbale, să nu posede arme de orice fel, să nu falsifice rețete sau orice alt tip de document, să nu consume droguri în incinta centrelor în care primește asistență, să nu incite la consum sau trafic de droguri în interiorul acestora, să ofere colaborare pentru buna funcționare a furnizorului și pentru menținerea resurselor materiale și a mediului.
- j) Să se angajeze într-o utilizare adecvată a bunurilor la care are acces în cadrul serviciului de asistență.

- k) Să mențină un comportament bazat pe respect, toleranță, colaborare și bună conviețuire.
- l) Să anunțe, după caz, furnizorii de servicii medicale ca se află în tratament cu antagonist de opiacee, în cazul în care solicită astfel de servicii.
- l) Să anunțe managerul de caz și furnizorii de servicii din program în cazul în care i s-au prescris medicamente de către un alt doctor.

Art. 4- Managerul de caz are drepturile și obligațiile prevăzute în regulamentul de aplicare a legii și următoarele îndatoriri:

- a) Să manifeste respect față de personalitatea, demnitatea și intimitatea consumatorului.
- b) Să informeze consumatorul cu privire la diferitele servicii și resurse existente.
- c) Să păstreze confidențialitatea față de toate informațiile referitoare la procesul de tratament în conformitate cu prevederile legale.

3. DURATA

Art.5 - Termenul acordului este același cu durata planului de asistență, putându-se prelungi la schimbarea sau modificarea acestuia.

4. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

Art. 6 – Acordul se modifică la schimbarea planului individualizat de asistență printr-o anexa la acesta.

Art. 7 – Acordul încetează la ieșirea din programul integrat de asistență.

5. SANCTIUNI

Art. 8 – Neîndeplinirea obligațiilor conținute în prezentul acord atrage schimbarea programului de asistență, a furnizorului de servicii sau a planului de asistență și, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.

Manager de caz/RESPONSABIL CENTRU

Consumator

DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU SUBSTITUȚIA CU AGONIȘTI DE OPIACEE

(acordul terapeutic se va completa cu următoarele prevederi)

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE CONSUMATORULUI:

- 2) Să prezinte la fiecare administrare BI/C.I., pasaportul și/sau legitimația în format electronic.
- 3) Să i se solicite de către personal administrarea agonistului în prezența sa.
- 4) Să respecte orarul stabilit pentru administrarea agonistului, în caz contrar nu i se va elibera medicația.
- 5) Să i se elibereze agonsitul pentru administrare la domiciliu în cazul în care echipa terapeutică consideră această măsură recomandabilă.
- 6) Să anunțe furnizorii de servicii medicale care se află în tratament cu agonist de opiacee, în cazul în care solicită astfel de servicii .
- 7) Să anunțe managerul de caz și furnizorii de servicii din program în cazul în care i s-au prescris medicamente de un alt doctor.
- 8) Să justifice cu documente toate absențele de la administrarea de agonist sau de la altă măsură din planul individualizat de asistență.
- 9) Să nu consume alte substanțe psihoactive fără recomandare medicală.
- 10) Să solicite suspendarea acestui tratament în orice moment, și trebuie să cunoască faptul că dacă ia această hotărâre, i se va face o dezintoxicare cu control medical, în funcție de evoluție și stare
- 11) Să semneze consimțământul informat de includere în menținere cu agonist de opiacee.

Neprezentarea la administrarea de metadonă, fără o cauză justificată, timp de 7 zile consecutive sau 10 zile alternative, într-o perioadă de 30 de zile, poate fi considerată ca abandon.

PLAN INDIVIDUALIZAT DE TRATAMENT

Numele clientului: _____ Nr.Id.Client: _____ Data admiterii: _____ **PIT:** _____
 Data de începere a planului: _____

PREZENTAREA PROBLEMELOR PE ARII

NR. 1 (Istoric de consum, semne intoxicație, sevraj)

NR. 2 (Medical)

NR. 3 (Psihologic / Motivație)

NR. 4 (Social / Familiar)

NR. 5 (Juridic)

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

SCOP: _____

OBIECTIVE:

Data la care se așteaptă
să fie atinse

1 _____
 2 _____
 3 _____

Nr. obiectiv	Data	Metode (Servicii)	Cantitatea	Frecvența	Durata	Centru / Instituție	Persoana responsabilă

**ACORD DE IEȘIRE LA CERERE
ÎMPOTRIVA RECOMANDĂRII PROFESIONISTULUI**

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT

Numele/prenume: _____ B.I. _____
cu domiciliul în _____
Plan individualizat de asistență _____
Serviciul/Furnizor _____

Data _____

Acest document certifică faptul că eu, _____,
părăsesc tratamentul de la data _____, la insistențele mele și
împotriva recomandărilor specialiștilor (denumirea furnizorului
_____). Am fost informat cu privire la riscurile pe care le implică
ieșirea din tratament în acest moment. Îmi asum responsabilitatea pentru
orice consecință negativă care ar putea apare ca urmare a ieșirii premature
din tratament.

Am înțeles că orice solicitare ulterioară pentru readmiterea în (denumirea
programului) _____ va necesita evaluarea și hotărârea
echipei de tratament.

Prin semnarea prezentei, responsabilitatea deciziei îmi aparține și, astfel,
echipa multidisciplinară/specialistul _____
este exonerat/ă de orice responsabilitate.

Semnătura: _____

Martor _____

Data _____

Numele pacientului

Codul pacientului

Data

Program integrat de tratament 1

ARII	CRITERII DE ORIENTARE	În cadrul fiecărei arii, încercuiți toți itemii care se aplică în cazul pacientului. Puneți un semn în una dintre casuțele „da” sau „nu” care indică validarea sau lipsa validării
Criterii program	Risc minim în toate ariile	DA NU
Aria 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abinență	a. istoric scurt de consum b. monodependență c. istoric recent de administrare intra-venoasă c. absența consumului de droguri în ultimele 2 săptămâni, dar există potențial de recădere și necesită asistență de prevenire a recăderilor d. consum de droguri cu potențial mic de dependență e. nu prezintă risc de sevraj f. nu este necesar un management medical pentru consumul de droguri g. nu este necesară dezintoxicarea	
Aria 2: Condiții bio-medicale și complicații	a. fără condiții medicale cronice b. starea de sănătate nu a fost afectată de consum c. existența unor condiții bio-medicale care pot fi vindecate sau care nu interferează cu procesul de recuperare d. există condiții medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică	
Aria 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații. Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme	a. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații b. există tulburări emoționale și/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare c. risc absent sau redus pentru sine sau alții d. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 1 e. există condiții psihologice care necesită monitorizare atentă în regim închis f. conștientizarea problemei și dorința de angajare în tratament g. grad de conștientizare și/sau motivare care necesită asistență structurată de intensitate medie sau mare h. risc redus de recădere i. potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis	
Aria 4: Condiții sociale și familiale	a. mediu suportiv b. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare c. mediul nu este suportiv dar asistența poate crește abilitățile de a face față dorinței imperioase de consum d. mediu nesuportiv sau interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis	
Aria 5:	a) situația anterioară	

Situația juridică

- a. antecedente penale fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. antecedente penale în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. trafic
- d. consum
- e. violență
- f. altele
- g. pedepse aplicate privative de libertate
- h. pedepse aplicate neprivative de libertate
- i. măsuri de supraveghere și obligații impuse
- j. măsuri de siguranță

b) situația prezentă:

- a. proces penal fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. proces penal în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. în urmărire penală
- d. în judecată
- e. termen încercare
- f. executare pedeapsă privativă de libertate
- g. executare pedeapsă neprivativă de libertate
- h. măsuri supraveghere și obligații

Numele Managerului de caz

Semnătura Managerului de caz

Data:

Numele pacientului

Codul pacientului

Data

Program integrat de tratament 2

ARII	CRITERII DE ORIENTARE	În cadrul fiecărei arii, încercuiți toți itemii care se aplică în cazul pacientului. Puneți un semn în una dintre casuțele „da” sau „nu” care indică validarea sau lipsa validării	DA	NU
Criterii program	Risc minim de intoxicație acută severă, sindrom de abstenență abordabil medical imediat și risc minim în aria bio-medicală dar cu risc moderat în orice altă arie			
Aria 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abstenență	a. istoric mediu sau scurt de consum b. monodependență c. perioade de abstenență semnificative (60zile) în istoric d. consum de droguri în ultimele 2 săptămâni e. recădere recentă f. risc minim de sevraj sever și există surse externe pentru administrarea medicației și monitorizare în sistem ambulator			
Aria 2: Condiții bio-medicale și complicații	g. semne curente ale sindromului de abstenență moderat - sever care necesită medicație și monitorizare în regim închis a. absența antecedentelor medicale sau condiții bio-medicale stabilizate b. starea de sănătate nu este grav afectată de consum c. existența unor condiții bio-medicale care pot fi vindecate sau nu interferează cu procesul de recuperare d. există condiții medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică			
Aria 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații. Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme.	e. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 2 în timpul dezintoxicării f. există condiții psihologice care necesită monitorizare atentă în regim închis după dezintoxicare g. condiții psihologice instabile, care necesită monitorizare structurată dar nu influențează dezintoxicarea d. risc absent sau redus pentru sine sau alții e. există tulburări emoționale și/sau cognitive care nu interferează cu procesul de recuperare f. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații g. potențial de creștere a motivației dacă sunt oferite intervenții suplimentare h. istoric de non-complianță la dezintoxicare ambulatorie și necesită asistență în regim închis i. conștientizarea problemei și dorință de angajare în tratament j. necesită asistență pentru prevenirea recăderilor k. risc redus – mediu de recădere; potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis			
Aria 4:	a. mediu în care asistența poate crește abilitățile de a face față dorinței de consum			

Condiții sociale și familiale

- b. mediu nesuportiv sau care interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis iar măsurile pot restabili condițiile necesare reabilitării
- c. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare
- d. mediu suportiv care permite administrarea medicației și monitorizarea dezintoxicării în ambulator

Aria 5:**Situația juridică****a) situația anterioară**

- a. antecedente penale fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. antecedente penale în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. trafic
- d. consum
- e. violență
- f. altele
- g. pedepse aplicate privative de libertate
- h. pedepse aplicate neprivative de libertate
- i. măsuri de supraveghere și obligații impuse
- j. măsuri de siguranță

b) situația prezentă:

- a. proces penal fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. proces penal în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. în urmărire penală
- d. în judecată
- e. termen încercare
- f. executare pedeapsă privativă de libertate
- g. executare pedeapsă neprivativă de libertate
- h. măsuri supraveghere și obligații

Numele Managerului de caz

Semnătura Managerului de caz

Data:

Numele pacientului

Codul pacientului

Data

Program integrat de tratament 3

ARII	CRITERII DE ORIENTARE	În cadrul fiecărei arii, încercuiești toți itemii care se aplică în cazul pacientului. Puneți un semn în una dintre casuțele „da” sau „nu” care indică validarea sau lipsa validării	DA	NU
Criterii program	Risc mediu – crescut de intoxicație acută severă, sindrom de abstenență de severitate moderată/crescută neabordabil medical imediat sau risc moderat în aria bio-medicală sau psiho-emoțională plus risc crescut în orice altă arie			
Aria 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abstenență	a. istoric mediu sau scurt de consum b. monodependență / polidependență ce poate fi stabilizată c. istoric de consum de alte droguri/medicamente d. perioade de consum compulsiv semnificative e. risc de sevrăj moderat – sever; f. semne curente ale sindromului de abstenență care necesită medicație și monitorizare după stabilizare g. istoric de consum îndelungat care permite dezintoxicarea după stabilizare			
Aria 2: Condiții bio-medicale și complicații	a. starea de sănătate este grav afectată de consum și necesită stabilizare b. existența unor condiții bio-medicale, dar acestea pot fi vindicate înaintea și/sau în timpul procesului de recuperare pentru a nu interfera cu acesta c. există condiții medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică d. afecțiuni medicale în tratament care poate interfera cu medicația pentru dezintoxicare și necesită consult interdisciplinar e. absența condițiilor bio-medicale			
Aria 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații. Acceptarea/rezistența la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme.	a. există tulburări emoționale și/sau cognitive, care interferează cu procesul de recuperare și necesită stabilizare înaintea dezintoxicării b. există condiții psihologice sau psihiatrice care necesită monitorizare atentă în regim închis înainte de dezintoxicare c. condiții psihiatrice sau psihologice care necesită stabilizare înaintea dezintoxicării d. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 3 e. există tulburări emoționale și/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare f. risc pentru sine sau alții ce necesită stabilizare înaintea dezintoxicării g. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații h. rezistență la tratament, necesită asistență pentru creșterea motivației înainte de intrarea în tratament i. grad redus sau absent de conștientizare și/sau motivare; necesită asistență structurată de intensitate medie sau mare pentru intrarea în tratament j. istoric de non-complianță și necesită asistență în regim închis k. conștientizarea problemei și dorință de angajare în tratament			

Aria 4:
Condiții sociale și familiale

- l. potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis
- m. istoric de recădere la o intensitate mai redusă a intervențiilor
- n. necesită asistență pentru prevenirea recăderilor
- o. risc redus de recădere
- a. mediul nu este suportiv, dar asistența poate crește abilitățile de a face față dorinței de consum
- b. mediu nesuportiv sau interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis
- c. necesită suport social minim înaintea intrării în tratament
- d. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare
- e. mediu suportiv care permite administrarea medicației și monitorizarea dezintoxicării în ambulator

Aria 5:
Situația juridică

a) situația anterioară

- a. antecedente penale fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. antecedente penale în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. trafic
- d. consum
- e. violență
- f. altele
- g. pedepse aplicate privative de libertate
- h. pedepse aplicate neprivative de libertate
- i. măsuri de supraveghere și obligații impuse
- j. măsuri de siguranță

b) situația prezentă:

- a. proces penal fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. proces penal în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. în urmărire penală
- d. în judecată
- e. termen încercare
- f. executare pedeapsă privativă de libertate
- g. executare pedeapsă neprivativă de libertate
- h. măsuri supraveghere și obligații

Numele Managerului de caz
Numele pacientului

Semnătura Managerului de caz
Codul pacientului

Data

Data:

Program integrat de tratament 4

ARII

CRITERII DE ORIENTARE

În cadrul fiecărei arii, încercuiți toți itemii care se aplică în cazul pacientului.
Puneți un semn în una dintre căsuțele „da” sau „nu” care indică validarea sau
lipsa validării

DA NU

Criterii program	Risc sever datorat intoxicației/sevrajului sau semnelor/simptomelor biomedicale sau emoționale/comportamentale
Aria 1: Istoric personal și de consum, semne de intoxicație și/sau sindrom de abinență	a. vârstă peste 18 ani b. consum de heroină c. testare pozitivă pentru heroină sau metadonă d. istoric lung de consum, în cantitate mare e. polidependență f. consumul intravenos de opiacee în ultimul an g. risc de sevraj sever h. eșecuri repetate în programe drog 0 i. perioade semnificative de consum compulsiv j. multiple episoade de recădere
Aria 2: Condiții bio-medicale și complicații	a. starea de sănătate este grav afectată de consum și necesită menținere b. existența unor condiții bio-medicale, dar acestea pot fi vindicate înaintea și/sau în timpul procesului de recuperare și nu interferează cu menținerea c. există condiții medicale severe în legătura sau nu cu consumul de heroină pentru a căror stabilizare este necesară intrarea într-un program de menținere cu agoniști de opiacee d. sarcină apărută la o consumatoare de heroină
Aria 3: Condiții psihologice sau psihiatrice și complicații. Acceptarea/rezistență la tratament. Potențial de recădere, continuare a consumului, alte probleme	a. există tulburări emoționale și/sau cognitive care interferează cu procesul de recuperare și necesită menținere cu agoniști b. condiții psihiatrice sau psihologice care necesită intrarea într-un program de menținere cu agoniști de opiacee c. risc pentru sine sau alții ce necesită menținere cu agoniști d. există condiții psihologice sau psihiatrice importante e. există condiții psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate în PIT 4 f. există tulburări emoționale și/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare g. fără condiții psihologice sau psihiatrice și complicații h. rezistență la tratament, necesită asistență pentru creșterea motivației înainte de intrare și în timpul tratamentului i. grad redus sau absent de conștientizare și/sau motivare; necesită asistență structurată de intensitate medie sau mare j. istoric de non-complianță și necesită asistență în regim închis k. conștientizarea problemei și dorință de angajare în tratament de menținere l. risc crescut de recădere m. potențial de recădere care face necesară asistența în regim închis n. istoric de recădere la o intensitate mai mică a intervențiilor

Aria 4:**Condiții sociale și familiale**

- a. mediu nesuportiv sau interferează cu procesul de recuperare și este necesară acordarea asistenței în regim închis
- b. necesită suport social
- c. mediul nu este suportiv, dar asistența poate crește abilitățile de a face față dorinței de consum
- d. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenței sau de recuperare
- e. mediu suportiv care permite administrarea medicației și monitorizarea menținerii în ambulator

Aria 5:**Situația juridică****a) situația anterioară**

- a. antecedente penale fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. antecedente penale în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. trafic
- d. consum
- e. violență
- f. altele
- g. pedepse aplicate privative de libertate
- h. pedepse aplicate neprivative de libertate
- i. măsuri de supraveghere și obligații impuse
- j. măsuri de siguranță

b) situația prezentă:

- a. proces penal fără legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- b. proces penal în legătură cu infracțiunile la regimul drogurilor
- c. în urmărire penală
- d. în judecată
- e. termen încercare
- f. executare pedeapsă privativă de libertate
- g. executare pedeapsă neprivativă de libertate
- h. măsuri supraveghere și obligații

Numele Managerului de caz

Semnătura Managerului de caz

Data:

**FOAIE INDIVIDUALĂ DE URGENȚĂ PENTRU
CONSUMUL DE DROGURI**

1. Nr. fișei clinice de urgență
2. Nr. de identificare al spitalului
3. Data admiterii în urgență
4. Cod
5. Sex
 1. bărbat
 2. femeie
 3. neidentificat
6. Data nașterii
7. Locul nașterii
 1. născut în România
 2. născut în altă țară
8. Cetățenie
9. Etnie
10. Județul de reședință
11. Municipiul de reședință
12. Condiția legală a pacientului
 1. deținut
 2. nu este deținut sau fără referințe la condiția legală
 3. necunoscut
13. Diagnosticul de urgență
 - 13.a.
 - 13.b.
 - 13.c.
14. Numele drogurilor care se menționează în fișa clinică
 - 14.a.
 - 14.b.
 - 14.c.
 - 14.d.

14.e.

14.f.

15. Calea de administrare

1. oral

2. inhalare

3. intranazal

4. parenteral

5. intravenos

6. altele

7. necunoscut

16. Evidențe ale relației directe între consumul de droguri și urgența menționată de către medic

1. da

2. nu

17. Numele drogurilor pe care medicul le-a relaționat cu urgența din fișa clinică

17.a.

17.b.

17.c.

17.d.

**FOAIE INDIVIDUALĂ DE ADMITERE LA TRATAMENT
PENTRU CONSUMUL DE DROGURI**

1. Nr. foi de observație
2. Data admitterii la tratament
3. Data externării
4. Nr.de identificare al centrului
5. Cod
6. Sex
 - 1.Barbat
 - 2.Femeie
 - 9.Neidentificat
7. Data nașterii
8. Locul nașterii
 - 8a.Născut în România: Județul
 - 8b.Născut în altă țară
9. Cetățenie
10. Etnie
11. Județul de reședință
12. Municipiul de reședință
13. Tipul contractului
 - 1.Pacient nou
 - 2.Pacient vechi
 - 9.Nespecificat
14. Aflat sub tratament la altă unitate
 - 1.Da
 - 2.Nu
 - 9.Nespecificat
15. Drogul principal pentru care este admis la tratament
16. Frecvența consumului drogului principal în ultimele 30 zile anterioare admitterii la tratament
 - 1.În fiecare zi
 - 2.4-6 zile/săptămână
 - 3.2-3 zile/săptămână
 - 4.1 zi/săptămână
 - 5.Mai puțin de 1 zi/săptămână
 - 6.N-a consumat
 - 9.Necunoscut
17. Anul începerii consumului drogului
18. Tratament anterior pentru același drog pentru care se va trata acum
 - 1.Da
 - 2.Nu
 - 9.Necunoscut

19. Calea cea mai frecventă de administrare a drogului principal în ultimele 30 zile de consum

- 1.Oral
- 2.Inhalare(gaze sau vapori)
- 3.Intranazal
- 4.Parenteral
- 5.Intravenos
- 6.Altele
- 7.Fumat
- 9.Necunoscut

20. Alte droguri consumate în ultimele 30 zile înainte de admiterea la tratament

- 20a.
- 20b.
- 20c.
- 20d.

21. Timpul care a trecut de cand si-a injectat ultima oara orice drog

- 01.Mai puțin de 1 ora
- 02.Mai puțin de 12 ore
- 03.Mai puțin de 24 ore
- 04.Ultima săptămână
- 05.Ultima lună
- 06.Ultimele 3 luni
- 07.Ultimele 6 luni
- 08.Ultimul an
- 09.Ultimii 2 ani
- 10.Peste 2 ani
- 11.Niciodată injectat
- 99.Necunoscut

22. Starea HIV, HB, HC

- 1.Da
- 2.Nu
- 9.Nespecificat
- 22a. Testat pentru HIV
- 22b. Confirmat HIV
- 22c. Testat pentru HB
- 22d. Confirmat HB
- 22e. Testat pentru HC
- 22f. Confirmat HC

23. Patologie somatică asociată în mod direct consumului de droguri

- 1.Hepatita B
- 2.Hepatita C
- 3.HIV/SIDA
- 4.Sifilis
- 5.Altele

24. Patologie psihiatrică asociată consumului de droguri

- 1.Schizofrenie
- 2.Tulburare afectivă
- 3.Tulburare de personalitate de tip antisocial

- 4.Tulburare de personalitate de tip borderline
- 5.Tulburare de personalitate de tip polimorf
- 6.Tulburare de personalitate de tip emoțional-instabilă
- 7.Schizofrenie și alte tulburări psihotice
- 8.Alte tipuri de tulburări de personalitate
- 9.Altele
- 10.Nu
- 25. Asigurare de sănătate
 - 1.Da
 - 2.Nu
- 26. Statutul profesional principal în momentul admiterii la tratament
 - 01.Cu contract pe perioadă nedefinită sau autonom(Chiar dacă e în concediu)
 - 02.Cu contract temporar(Chiar dacă e în concediu)
 - 03.Lucrează fără salariu pentru familie
 - 04.Somer, fără să fi lucrat înainte
 - 05.Somer, a lucrat înainte
 - 06.Handicapat permanent, pensionar
 - 07.Elev
 - 08.Student sau în alte forme
 - 09.Realizează exclusiv activități casnice
 - 10.Fără ocupație
 - 11.În altă situație
 - 99.Necunoscut
- 27. Nivelul maxim de studii complete
 - 01.Nu știe să citească nici să scrie
 - 02.Școală primară incompletă
 - 03.Școală primară completă
 - 04.Gimnaziu
 - 05.Liceu
 - 06.Școală profesională
 - 07.Studii universitare de scurtă durată
 - 08.Studii universitare superioare
 - 09.Altele
 - 99.Necunoscut
- 28. Vârsta părăsirii școlii
- 29. Cine trimite
 - 01.Alt serviciu de tratament al toxicodependențelor
 - 02.Medic de familie, sistem de asistență primară
 - 03.Spital sau alte servicii de sănătate
 - 04.Servicii sociale
 - 05.Penitenciar, centre de internare pentru minori
 - 06.Servicii legale
 - 07.Firma sau angajator
 - 08.Familia sau prietenii
 - 09.Inițiativa proprie
 - 10.Altele
 - 99.Necunoscut
- 30. Cu cine a locuit în ultimele 30 zile înainte de admiterea la tratament

- 01.Singur/a
 - 02.Cu partenerul/a
 - 03.Doar cu copii
 - 04.Cu partenerul/a si copii
 - 05.Cu părinții sau familia de origine
 - 06.Cu prieteni
 - 07.Cu alți consumatori
 - 08.Altele -
 - 99.Necunoscut
31. Unde a locuit în ultimele 30 zile premergătoare admiterii la tratament
- 01.Casa, apartament
 - 02.Penitenciar, centru de internare pentru minori
 - 03.Alte instituții
 - 04.Pensiuni, hoteluri, cabane
 - 05.Locuință instabilă/precară
 - 06.Alte locuri
 - 99.Necunoscut
32. Tratamentul aplicat
- 01.Dezintoxicare
 - 02.Fara medicație
 - 03.Sfătuire, suport
 - 04.Trimitere în alt centru
 - 05.Tratament neinițiat
 - 06.Substitutie
 - 99.Necunoscut
33. Rezolvarea cazului
- 01.Externare voluntară
 - 02.În tratament RTS
 - 03.În tratament ZI
 - 04.Externare la cerere
 - 05.Excludere din program
 - 06.Externare

Oraș.....
Județ.....
Unitateacod unitate.....
Numar foaie observație.....

**CAZURI ÎNREGISTRATE DE HVC/HVB ÎN RÂNDUL
CONSUMATORILOR DE DROGURI INJECTABILE**

Cod pacient
Data internării.....
Data externării.....

Sex
Feminin
Masculin

Data nașterii.....

Diagnostic la internare
HVB
HVC
Ambele

Tipul cazului
Acut
Cronic
Ambele

Calea de infectare:
Sanguină
Sexuală
Verticală
Necunoscută

Diagnostic confirmat și prin teste de laborator
DA.....pentru HCV-ARN
DA.....Ag HBe
DA.....ambele
NU

Utilizarea drogurilor injectabile:
Vreodată
Regulat (În ultimele 12 luni)

Nu

Formular completat de.....

Oraş.....
Judeţ.....
Unitateacod unitate.....
Numar foaie observaţie.....

**PREVALENȚA INFECȚIILOR CU HIV, HVB/HVC ÎN RÂNDUL
CONSUMATORILOR DE DROGURI INJECTABILE**

Cod pacient
Data internării.....
Data externării.....
Sex
Feminin
Masculin

Data naşterii.....

Utilizarea drogurilor injectabile
Vreodată
Regulat (În ultimele 12 luni)
Nespecificat

Tipul de drog injectat:
Heroină
Alte opiacee (exceptând heroina).....se specifică
Non-opiacee (specificaţi).....

De când se injectează
Mai mult de 2 ani
Mai puţin de 2 ani
Nu ştiu/nu specifică

Testarea s-a făcut:
cu consimţământul persoanei
fără consimţământul persoanei

Testat pentru:
Ag HBS
anti HBs
anti HBc
Ac HVC
Ac HIV

Pozitiv pentru:
Ag HBS
anti HBs

anti HBc
Ac HVC
Ac HIV

Confirmat pentru
HVB
HVC
HIV

Produsul testat
Salivă
Sânge Urină
Altele (specificați).....

Formular completat
de.....

**FIȘA DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A DECESULUI CA
URMARE A REACȚIEI ACUTE LA SUBSTANȚE PSIHOACTIVE
(DECES RASP)**

Numele și prenumele decedatului

BI/CI al decedatului

Nº raportului medico-legal sau al autopsiei

Nº fișei toxicologice

Numărul de înmatriculare

Instituția de unde se colectează datele

7. Instanța judecătorească care transmite cazul

7.a. Județul

7.b. Municipul

Localitatea unde a survenit decesul

Municipiul unde a survenit decesul

Data decesului

Cod

Sex

Data nașterii

Vârstă

Locul nașterii

15.a. Născut în România

15.b. Născut în altă țară

Cetățenie

Localitatea de domiciliu

Municipiul/județul de domiciliu

Starea civilă (1.celibatar. 2.căsătorit. 3.separat/divorțat. 4.văduv)

Proveniența cadavrului (1.domiciliu. 2. hotel/pensiune. 3.stradă.

4.stabiliment public. 5.spital. 6.penitenciar. 7.alt loc)

Criterii clinice de moarte prin reacție acută datorată consumului de droguri
îndeplinite

21.a Evidențe ale consumului recent de droguri

1. Da 2. Nu

Dovezi clinice documentate de patologie acută datorată consumului de
droguri, imediat înainte de moarte

Semne fizice ale administrării recente de substanțe psihoactive (intravenos)
sau prezența resturilor de substanțe psihoactive în cavitatea bucală, fose
nazale, stomac etc.

Prezența de substanțe psihoactive sau ustensile (seringi, folie de aluminiu,
recipiente de pastile etc) la locul decesului

Antecedente privind consumul recent menționate de familie, prieteni sau
cunoscuți sau de medicul legist în expertize medico-legale anterioare

21.b. Semne la autopsie compatibile cu moartea prin reacție acută la
droguri

1.Da 2. Nu

22.c. Diagnosticul medico-legal al morții RAD

1. Da 2. Nu

Evidențe ale suicidului

1. Da 2. Nu

Semne recente de injectare IV (mai puțin de o săptămână înaintea morții)

1. Da 2. Nu

Moarte a cărei cauză de bază este o patologie anterioară complicată prin consumul de droguri

1.Da 2.Nu

Anticorpi anti-HIV 1.Pozitiv 2.Negativ

Substanțe psihoactive sau metaboliții detectați la analizele toxicologice

26.a. Substanțe psihoactive sau metaboliții detectați la analizele toxicologice

26.b. Tipul mostrei biologice (0.păr.1.sânge.2.urina.3.bilă.4.c gastric.5.LCR. 6.viscere. 7.umoare vitroasa. 8. altele. 9 necunoscut)

26.c. Rezultatul cantitativ (în micrograme/ml, exceptând alcoolul în grame/litru)

Numele instituției care a realizat analizele toxicologice adnotate

Numele drogurilor consumate imediat înaintea morții

GLOSAR DE TERMENI

1. **acord de asistență medicală, psihologică și socială:** document în baza căruia consumatorul de droguri este inclus în programul integrat de asistență și care cuprinde drepturi și obligații ale acestuia;
2. **agonist:** substanța care prin acțiunea sa la nivelul receptorilor neuronali produce efecte similare celor ale drogului de referință (ex: metadona);
3. **antagonist:** substanța care prin interacțiunea cu receptorii neuronali diminuează sau anulează efectele drogului de referință sau inhibă acțiunea acestuia;
4. **afecțiuni asociate consumului:** afecțiuni medicale datorate și/sau coexistente consumului de droguri;
5. **caz:** persoană care se adresează pentru acordarea de servicii unui furnizor din circuitul integrat, în cursul unui an calendaristic;
6. **circuit integrat de asistență** a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri - totalitatea programelor integrate de asistență asigurate consumatorilor și consumatorilor dependenți în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice și sociale a individului.
7. **circuit terapeutic** - ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial și continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;
8. **consumator** - persoana care își administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghițire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;
9. **consumator dependent** - consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat și sub necesitate ori nevoie, prezintă consecințe fizice și psihice conform criteriilor medicale și sociale;
10. **decese datorate consumului:** decese rezultate fie direct, ca urmare a consumului, fie indirect, ca urmare a comportamentelor determinate de consumul de droguri;
11. **dependență de droguri:** nevoia imperioasă sau persistentă de a continua consumul drogului, în scopul obținerii unei stări de bine sau pentru a evita starea de rău generată de întreruperea acestuia;
12. **diagnostic dual:** coexistența diagnosticului de tulburare mintală cu cel de consum de droguri;
13. **intoxicație acută:** o stare tranzitorie prezentă la scurt timp de la utilizarea drogului cu apariția efectelor specifice care pot fi detectate prin metode de evaluare medicală;

14. **manager de caz:** persoana din cadrul centrului de prevenire, evaluare și consiliere care coordonează, planifică și monitorizează serviciile de asistență medicală, psihologică și socială în raport de necesitățile individuale ale consumatorului;

15. **medicamentele care conțin plante, substanțe stupefiante și psihotrope** sau amestecuri de asemenea plante și substanțe aflate sub control național, înscrise în tabelele nr. I-III din lege sunt considerate droguri atunci când nu sunt folosite în cadrul actului medical conform legislației privind circuitul legal al acestora;

16. **metaboliți:** substanțele ce apar în organism după consumul unui drog, ca urmare a proceselor suferite de acesta în organism, și care pot persista o perioadă îndelungată de la consumul ultimei doze de drog;

17. **polidependență:** consumul a cel puțin două droguri diferite în condiții de dependență;

18. **program integrat de asistență** a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri - totalitatea serviciilor de sănătate și a serviciilor de asistență psihologică și socială asigurate în mod integrat și coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unitățile medicale, psihologice și sociale, publice, private și mixte;

19. **program psihologic și social** - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere și psihoterapie individuală sau de grup și a serviciilor și măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare și adaptare continuă pentru fiecare consumator în vederea înlăturării dependenței, reabilitării și reinsertiei lui sociale;

20. **program terapeutic** - totalitatea serviciilor și a măsurilor medicale și psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare și adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenței psihice și/sau fizice și/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;

21. **registru unic codificat:** baza de date care cuprinde toate înregistrările individuale privind cazurile, primite de la furnizorii de servicii;

22. **sindrom de abstinență:** reacția organismului la întreruperea bruscă a consumului de droguri, la administrarea de antagonist specific sau la scăderea cantității de drog față de care s-a instalat dependența;

23. **supradoză:** consumul unei cantități de drog suficientă să determine efecte care pun viața în pericol;

24. **urgență:** condiția medicală a unui consumator de droguri, în legătură sau nu cu consumul, care îi pune în pericol viața;

REFERINȚE

1. Agencia Antidroga, Consejería de sanidad y consume, Comunidad de Madrid: *Memoria 2003*.
2. Agenția Națională Antidrog: *Prevalența consumului de droguri în România. Studiu în populația generală, 2004, publicat 2005*.
3. American Psychiatric Association: *Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders, Compendium 2002*.
4. Concejalía de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Dirección de Servicios de Drogodependencias, Departamento de Asistencia, Sección de Programas Asistenciales: *instrumentos utilizados en las adicciones*.
5. Dan Prelipceanu, Victor Voicu, editori: *Abuzul și dependența de substanțe psihoactive, 2004*.
6. Department of Health Scottish Office Department of Health, Welsh Office, Department of Health and Social Services Northern Ireland: *Drug Misuse and Dependence Guidelines on Clinical Management*.
7. Dima Abdulrahim with Don Lavoie Sherife Hasan, *The Substance Misuse Advisory Service 1st Edition Summer 1999: COMMISSIONING STANDARDS, Drug and Alcohol Treatment and Care. Helping commissioning in Tackling Drugs to Build a Better Britain*.
8. EMCDDA: *Standards and quality assurance in treatment related to illegal drugs and social reintegration in EU Member States and Norway*.
9. European Union Strategy 2005-2012.
10. Federation of European Professionals Working in the Field of Drug Abuse With the support of the European Commission. Responsible Prof. Umberto Nizzoli, Collaboration Chiara Covri: *Evaluation of the Medical, Psychological, Socio-educational*.
11. Ioseba Iraugi Castillo, Francisco Gonzales Saiz (editors): *Instrumentos de evaluation in drogodependencias, 2002*.
12. Marc Galanter, M.D., Herbert D. Kleber, M.D.: *Textbook of Substance Abuse Treatment, Second Edition, 1999*.
13. National Treatment Agency for Substance Misuse, Department of Health: *Models of Care for Treatment of Drug misusers, Promoting quality, efficiency and effectiveness in drug misusers treatment services in England, 2002*.
14. Operation PAR, Inc. Medical Records Department: *tools used in addictions*
15. Organization of American States (OAS), Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD): *Practical Guide for the Organization of a Comprehensive Drug Dependence Treatment System, 2003*.
16. Plan Nacional sobre Drogas: *Servicios sociales y drogodependencias, 1998*.

17. Quality in Alcohol and Drug Services (QuADS), Alcohol Concern, DrugScope: *Organisational Standards for Alcohol and Drug Treatment Services*, 1999.
18. Rebecca Sager Ashery, D.S.W., NIDA Research Monograph 127, 1992: *Progress and Issues in Case Management*, 1992.
19. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Substance abuse treatment: *Comprehensive Case Management for Substance Abuse Treatment, Treatment Improvement protocol (TIP) Series 27*, 2001.
20. Sue Henry-Edwards, Linda Gowing, Jason White, Robert Ali, James Bell, Rodger Brough, Nick Lintzeris, Alison Ritter, Allan Quigley: *Clinical Guidelines and Procedures for the Use of Methadone in the Maintenance Treatment of Opioid Dependence*.
21. Susana Lorenzo, José Joaquín Mira, Elena Sánchez: *Evaluacion de las Normas de atencion en el Tratamiento de Drogas, Documento de sintesis. Seminario Sobre Normas de Atencion en el Tratamiento de la Farmacodependencia, Santiago de Chile, Caracas Venezuela, Noviembre de 1993. Total quality management and evidence based medicine*.
22. United Nations, Office on Drugs and Crime: *Drug Abuse Treatment and Rehabilitation, A practical Planning and Implementation Guide*, 2003.
23. Wouter Vanderplasschen, Promotor: Prof. Dr. E. Brockaert: *Implementation and Evaluation of Case Management for Substance Abusers with Complex and Multiple Problems*, 2004.